

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ



Медицинский факультет

Кафедра «Терапевтической стоматологии»

«УТВЕРЖДЕНО»

Декан медицинского факультета
доцент Мамашарипов К.М.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель УМС МФ
ст. преп., Турсунбаева А.Т.

Фонд тестовых заданий для компьютерного тестирования
предназначен для контроля знаний студентов по специальности
«Стоматология»

дисциплина «Терапевтическая стоматология 3»

курс - 5, семестр - 10

объем учебной нагрузки по дисциплине составляет:

всего-90

лекционные- 14 ч

практические- 22ч

СРС-45ч, СРСП- 9ч.

кол-во вопросов-300

Тестолог: Жаныбай кызы Каныкей. _____

Обсужден на заседании кафедры от « 10 » 04 2026 г протокол № 9

Заведующий кафедрой: Исмаилов А.А.

Составитель: Бадинова А.Э., Маматкасымов М.Б.

Ош 2026г.

№1. Проанализируйте патогенетические механизмы цервикальной инвазивной резорбции и сформулируйте её определение, отражающее ключевые этапы развития и тканевые взаимодействия.

- a) Поверхностное повреждение эмали вследствие воздействия агрессивных кислот.
- b) Локализованный резорбтивный процесс в пришеечной области зуба под эпителиальным прикреплением.**

- c) Воспалительная деструкция тканей пульпы, развивающаяся строго внутри корневого канала.
- d) Процесс физиологического рассасывания корней временных зубов у детей.
- e) Генерализованная потеря костной ткани альвеолярного отростка в области моляров.

№2. Объясните сущность телестоматологии и её роль в организации современного клинического стоматологического приёма.

- a) Проведение хирургических операций с использованием роботов-манипуляторов.
- b) Система дистанционного обмена стоматологической информацией для консультаций и диагностики.**
- c) Использование телевизионных экранов для трансляции развлекательного контента пациенту.
- d) Метод бесконтактного измерения температуры слизистой оболочки полости рта.
- e) Способ стерилизации инструментов с помощью направленного радиоизлучения.

№3. В стоматологической практике при проведении электроодонтодиагностики (ЭОД) у пациента с жалобами на боль при приёме холодной пищи врач должен правильно использовать метод для оценки состояния пульпы. Какое действие является наиболее корректным при проведении ЭОД?

- a). Провести ЭОД сразу после анестезии для уменьшения боли
- b). Использовать ЭОД на сухой изолированной поверхности зуба после удаления налёта**
- c). Проводить ЭОД только на рентгенологически изменённых зубах
- d). Выполнять ЭОД без предварительной очистки зуба для ускорения процедуры
- e). Использовать ЭОД только на зубах с глубокими кариозными полостями

№4. Объясните механизм кавитации, возникающей при работе ультразвукового скейлера \

- a) Механическое соприкосновение насадки инструмента с поверхностью эмали.
- b) Образование и схлопывание микропузырьков в жидкости с высвобождением энергии.**
- c) Направленное охлаждение тканей струей водно-воздушной смеси.
- d) Химическое растворение органической матрицы зубного налёта антисептиком.
- e) Процесс кристаллизации солей из слюны под действием высокой частоты.

№5. Укажите что подразумевает понятие «Электрофорез» в стоматологии:

- a) Способ механической очистки каналов с помощью вращающихся электродов.
- b) Метод введения лекарственных веществ в ткани с помощью постоянного электрического тока.**
- c) Вид местной анестезии, основанный на блокировке нервных импульсов током.
- d) Лабораторный метод анализа состава ротовой жидкости пациента.
- e) Процесс удаления некротизированной пульпы из системы корневых каналов.

№6. Укажите какие характеристики определяют диатермокоагуляцию как хирургический метод:

- a) Иссечение тканей с помощью охлажденного до сверхнизких температур скальпеля.
- b) Использование тока высокой частоты для прицельного нагрева и денатурации белков.**
- c) Метод остановки кровотечения путем наложения давящей марлевой повязки.
- d) Применение светового луча узкого спектра для активации фотосенсибилизатора.
- e) Разрушение грануляционной ткани с помощью концентрированных кислот.

№7. Объясните, что такое апикальный упор в эндодонтии и какое значение он имеет при инструментальной обработке корневого канала.

- a). Это плотное анатомическое сужение в области апекса корня, служащее естественным ограничителем для инструментов и пломбировочного материала.**
- b). Это искусственно создаваемое расширение апикальной части канала для улучшения ирригации.
- c). Это зона резорбции костной ткани вокруг верхушки корня зуба.
- d). Это метод определения жизнеспособности пульпы с помощью электрического тока.
- e). Это этап антисептической обработки канала с использованием ультразвука.

№8. Дайте определение понятию «Ложноположительный результат» при проведении ЭОД:

- a) Прибор показывает отсутствие реакции, хотя пульпа на самом деле жива.
- b) Пациент реагирует на ток, но стимул проходит через десну или соседний зуб, а не через пульпу.**
- c) Зуб не реагирует на холод, но реагирует на механическое зондирование.
- d) Показатели тока соответствуют норме, но на рентгене видна киста.
- e) Цифры на дисплее прибора меняются хаотично из-за разряда батареи.

9. Какое морфологическое изменение наиболее характерно для эпителиальной дисплазии как предракового состояния?

- а) Нормальный процесс ороговения клеток слизистой оболочки.
- б) Нарушение структуры и клеточную атипичию эпителия без инвазии в подлежащие ткани.**
- с) Быстрое заживление эрозивного дефекта после устранения травмы.
- д) Появление белого налета, который легко снимается при соскабливании шпателем.
- е) Разрастание сосудистой сети в очаге хронического воспаления.

№10. Что подразумевает термин «Струп» после электрохирургического вмешательства:

- а) Зона здоровой ткани, сохранившая чувствительность.
- б) Слой коагулированной, некротизированной ткани, выполняющий защитную функцию.**
- с) Гнойное отделяемое, свидетельствующее об инфицировании раны.
- д) Искусственный материал, накладываемый врачом для закрытия раны.
- е) Участок гипертрофированной десны, подлежащий повторному удалению.

№11. Пациент обратился в стоматологическую клинику с жалобами на боль и признаки воспаления. Врач проводит первичный осмотр, оформляет медицинскую документацию, оценивает общее соматическое состояние пациента и при необходимости направляет его к смежным специалистам, после чего организует лечение в профильном отделении. Какой алгоритм маршрутизации пациента наиболее соответствует современным требованиям междисциплинарного подхода и рекомендациям ВОЗ.

- а) Немедленная постановка на диспансерный учёт с последующим направлением в терапевтическое отделение без предварительного комплексного обследования и оценки соматического статуса.
- б) Проведение осмотра с последующим оформлением медицинской документации и началом лечения в терапевтическом кабинете без привлечения смежных специалистов.
- с) Первичный осмотр в смотровом кабинете с оформлением документации, последующим направлением в профильное отделение и координацией лечения с учётом соматического статуса пациента.**
- д) Направление пациента в хирургическое отделение для устранения очагов инфекции без предварительной терапевтической подготовки и консультации специалистов.
- е) Отсрочка стоматологического лечения до полного обследования у смежных специалистов без проведения первичного стоматологического осмотра.

№12. Укажите какой вариант маршрутизации пациента является наиболее обоснованным с позиции организационной структуры оказания стоматологической помощи:

- а) Направление пациента непосредственно в терапевтическое отделение без предварительного осмотра в смотровом кабинете.
- б) Первичный осмотр в смотровом кабинете с последующим направлением в профильное отделение и уточнением показаний к проведению лечения.**
- с) Перевод пациента в хирургическое отделение для экстренного удаления причинного зуба без проведения дополнительной диагностики.
- д) Проведение лечения в любом доступном кабинете без учёта профилизации отделений и маршрутизации пациента.
- е) Отказ в оказании помощи до получения дополнительного административного направления или согласования.

№13. Выберите подход, который одновременно соответствует национальным стандартам КР и ВОЗ:

- а) Постановка на диспансерный учёт только после проведения платной реставрации с использованием материалов премиум-класса, так как бесплатное лечение в рамках госгарантий ограничивается только острой патологией.
- б) Комплексное профилактическое лечение в рамках ЦСМ с внесением данных в форму 030/у, активным ежемесячным контролем гигиены и динамическим наблюдением согласно принципам плановости и непрерывности, рекомендованным ВОЗ.**
- с) Направление пациента в республиканскую стоматологическую поликлинику для постановки на диспансерный учёт, поскольку ЦСМ согласно нормативным документам КР имеет право только на оказание первичной помощи, но не на ведение диспансерных групп.
- д) Одноразовый приём с проведением лечебно-профилактических мероприятий без постановки на диспансерный учёт, так как стратегия ВОЗ «Оральное здоровье 2020–2030» акцентирует внимание исключительно на краткосрочных профилактических вмешательствах, а не на долгосрочном мониторинге.
- е) Отказ от диспансерного учёта с ограничением только подробными рекомендациями по индивидуальной гигиене и мотивацией пациента к самостоятельному контролю, поскольку в условиях дефицита ресурсов ЦСМ приоритет отдаётся пациентам с декомпенсированной патологией.

№14. При централизованном размещении стоматологической поликлиники в КР (все отделения в одном здании) возникает риск перекрёстной инфекции. Пациент с хроническим рецидивирующим афтозным

стоматитом (иммуносупрессия) требует диспансерного учёта. Найдите, какой организационный шаг является критической ошибкой согласно структуре КР?

а) Направление пациента в терапевтическое отделение после осмотра в смотровом кабинете с организацией изоляции приёма и использованием индивидуальных средств защиты для снижения риска перекрестного инфицирования.

б) Одновременный приём в одном кабинете с пациентами, нуждающимися в хирургическом вмешательстве, так как централизованное размещение всех отделений в одном здании позволяет оптимизировать поток пациентов и повысить пропускную способность поликлиники.

в) Заполнение контрольной карты диспансерного наблюдения с обязательным указанием иммуносупрессии для правильного планирования комплексного лечения и междисциплинарного взаимодействия.

г) Обязательная консультация иммунолога перед постановкой на диспансерный учёт с целью коррекции терапии и оценки общего иммунного статуса пациента.

д) Использование отдельного физиотерапевтического кабинета для местного лечения с соблюдением усиленного режима дезинфекции и строгой очереди для иммунокомпрометированных пациентов.

№15. В децентрализованном размещении (терапевтические кабинеты при школах/ЦСМ) врач проводит приём. Укажите согласно структуре КР, какой документ обязательно заполняется при первичном обращении ребёнка 7 лет с множественным кариесом для дальнейшего диспансерного учёта?

а) Только амбулаторная карта стоматологического больного, поскольку в децентрализованных кабинетах при ЦСМ и школах ведётся упрощённая форма документации для оптимизации рабочего времени врача.

б) Контрольная карта диспансерного наблюдения (форма 030/у) + амбулаторная карта + журнал профилактических осмотров организованных контингентов, что обеспечивает полный учёт и преемственность наблюдения.

в) Только направление в республиканскую стоматологическую поликлинику, так как децентрализованные кабинеты при школах и ЦСМ не наделены правом самостоятельной постановки детей на диспансерный учёт по организационным нормам КР.

г) Листок ежедневного учёта врача без заполнения диспансерной карты, поскольку при высоком потоке детских пациентов в децентрализованных условиях приоритет отдаётся оперативности приёма.

д) Форма 049/у (журнал профилактики) без постановки на диспансерный учёт, так как множественный кариес у ребёнка 7 лет относится к категории плановой профилактики, а не к диспансерному наблюдению.

№16. Пациент 45 лет с компенсированным хроническим генерализованным пародонтитом (группа Д-Ша) отказывается от постановки на диспансерный учёт, мотивируя «не хочу, чтобы данные были в базе».

Укажите согласно принципам диспансерного учёта в КР и Кодексу профессиональной этики медицинского работника КР (2004), действия врача:

а) Принудительная постановка на учёт с обязательной записью в карте «отказ пациента» и уведомлением заведующего отделением для фиксации административного нарушения.

б) Разъяснение пациенту права на отказ, документирование информированного добровольного отказа в установленной форме, предложение альтернативного наблюдения по обращаемости и повторное активное приглашение через 6 месяцев.

в) Игнорирование отказа пациента и автоматическая постановка на диспансерный учёт, поскольку пародонтит средней степени тяжести входит в перечень социально значимых заболеваний, требующих обязательного диспансерного наблюдения.

г) Направление материалов в суд для решения вопроса о принудительном диспансерном учёте, так как отказ пациента создаёт риск прогрессирования заболевания и возможных осложнений.

д) Отказ в проведении любого лечебно-профилактического вмешательства до получения письменного согласия пациента на постановку на диспансерный учёт, в соответствии с принципом комплексности диспансеризации.

№17. Оцените предложенные тактики ведения пациента с декомпенсированным пародонтитом на фоне ревматоидного артрита (приём Метотрексат). Выберите наиболее обоснованное решение с позиции принципа комплексности диспансерного наблюдения и объясните свой выбор.

а) Только интенсивное пародонтологическое лечение без привлечения смежных специалистов, поскольку стоматологическая помощь в рамках программы госгарантий должна оказываться в одном учреждении.

б) Консультация ревматолога, корректировка плана лечения с учётом иммуносупрессивной терапии + внесение в контрольную карту диспансерного наблюдения конкретных сроков совместного динамического наблюдения.

- с) Перевод пациента на хирургическое лечение с целью радикального удаления подвижных зубов как ведущего звена комплексной терапии при декомпенсированном пародонтите на фоне приёма метотрексата.
- д) Отказ в постановке на диспансерный учёт до полной отмены иммуносупрессоров ревматологом, так как проведение любого стоматологического вмешательства на фоне метотрексата повышает риск тяжёлых инфекционных осложнений.
- е) Самостоятельное назначение стоматологом иммуномодуляторов и коррекция дозы метотрексата в рамках диспансерного наблюдения, поскольку пародонтит является ведущим звеном и требует активного воздействия на иммунный статус.

№18. Проанализируйте клиническую ситуацию: пациент с субкомпенсированным пародонтитом (группа Д-IIIб) не явился на контрольный осмотр в течение 3 месяцев. Какое действие врача наиболее соответствует принципу плановости диспансерного наблюдения?

- а) Автоматическое снятие пациента с диспансерного учёта, поскольку неявка в течение 3 месяцев свидетельствует об отсутствии мотивации к лечению и нецелесообразности дальнейшего планового наблюдения.
- б) Активный вызов пациента (телефон, смс или официальное письмо), документирование факта неявки в контрольной карте, анализ причин и корректировка плана лечения с учётом повышенного риска обострения.**

- с) Игнорирование факта неявки и продолжение оказания помощи исключительно по обращаемости пациента, так как принцип плановости не является обязательным при субкомпенсированном течении заболевания.
- д) Наложение штрафа на пациента за нарушение графика диспансерного наблюдения в соответствии с внутренними регламентами поликлиники и Программой госгарантий.
- е) Передача сведений о неявке в страховую компанию без уведомления пациента для пересмотра объёма финансирования по диспансерной группе Д-IIIб.

№19. Пациентка относится к группе диспансерного наблюдения Д-II (практически здорова), имеет некариозные поражения зубов и находится в состоянии беременности. Какой вариант тактики диспансерного наблюдения является наиболее правильным с учётом принципов дифференцированности и комплексности?

- а) Пожизненное диспансерное наблюдение без плановых переосмотров, так как группа Д-II подразумевает минимальный риск и не требует активного контроля.
- б) Диспансерное наблюдение до родов с ежемесячным контролем состояния твёрдых тканей и гигиены + постнатальный перевод в группу Д-I или Д-III в зависимости от клинической динамики некариозных поражений.**
- с) Ограничение только одним профилактическим визитом в первом триместре беременности, поскольку дальнейшее наблюдение выходит за рамки стоматологической помощи в первичном звене.
- д) Диспансерное наблюдение до достижения пациентом 18-летнего возраста, так как некариозные поражения у беременных часто связаны с возрастными изменениями минерального обмена.
- е) Отсутствие диспансерного учёта в принципе, поскольку пациент относится к группе Д-II («практически здоров») и наличие беременности не является основанием для постановки на учёт по стоматологической патологии.

№20. Проанализируйте клиническую ситуацию сочетания пародонтита и лейкоплакии слизистой оболочки. Обоснуйте выбор ведущего звена диспансеризации и оцените роль других звеньев в комплексном ведении пациента.

- а) Только хирургическое звено, поскольку лейкоплакия требует обязательной биопсии и радикального удаления очагов изменённой слизистой для предотвращения малигнизации.
- б) Терапевтическое (пародонтологическое) звено в сочетании с обязательным онкологическим контролем, включая люминесцентную стоматоскопию и динамическое наблюдение, согласно действующим клиническим рекомендациям.**
- с) Ортопедическое звено как ведущее, так как при сочетании пародонтита и лейкоплакии приоритет отдаётся стабилизации окклюзии и протезированию для снижения травматической нагрузки на слизистую.
- д) Отсутствие чётко определённого ведущего звена, поскольку при сочетанной патологии все звенья (терапевтическое, хирургическое и ортопедическое) должны работать параллельно без выделения приоритета.

е) Только профилактика гигиены как ведущее звено, так как качественный гигиенический уход является основой лечения как пародонтита, так и лейкоплакии, а остальные вмешательства носят вспомогательный характер.

№21. Оцените деонтологическую ситуацию: пациент отказывается от внесения информации о ВИЧ-статусе в медицинскую документацию. Каковы действия врача с точки зрения медицинской этики и законодательства? Обоснуйте принятое решение.

а) Удалить упоминание о ВИЧ-статусе из всех документов, чтобы избежать возможной жалобы и сохранить доверительные отношения с пациентом.

б) Объяснить пациенту медицинскую необходимость внесения этих данных исключительно для обеспечения безопасности лечения и персонала, гарантировать строгую конфиденциальность и внести информацию только после получения информированного согласия (при отказе — документировать отказ в установленной форме).

с) Внести данные о ВИЧ-статусе принудительно в диспансерную карту, поскольку риск инфицирования медицинского персонала и других пациентов превышает право пациента на отказ от предоставления информации.

д) Отказать пациенту в приёме и диспансерном учёте до тех пор, пока он не предоставит письменное согласие на внесение полного диагноза.

е) Сообщить главному врачу о требовании пациента без его присутствия и получить административное указание по дальнейшим действиям.

№22. Врач-терапевт в ЦСМ получает запрос от страховой компании на полные данные диспансерного учёта пациента без его согласия. Выберите деонтологически правильное действие:

а) Предоставить полные данные диспансерного учёта, поскольку страховая компания является плательщиком по Программе госгарантий и имеет право на получение всей медицинской информации.

б) Предоставить только обезличенные статистические сведения или отказать в предоставлении полной информации без письменного информированного согласия пациента, с обязательной ссылкой на нормы медицинской тайны.

с) Предоставить все запрошенные данные, так как финансовая зависимость учреждения от страховой компании требует максимального сотрудничества в обмене информацией.

д) Удалить из электронной карты все сведения о диспансерном учёте пациента до ответа на запрос страховой компании.

е) Сообщить пациенту постфактум о поступившем запросе и предоставить данные страховой компании после его уведомления.

№23. На приём к врачу обратился несовершеннолетний пациент 16 лет. Он настаивает на проведении лечения без уведомления родителей, ссылаясь на право на конфиденциальность. Какое решение врача является наиболее правильным с точки зрения медицинской этики и законодательства Кыргызской Республики?

а) Отказать в любом лечении до получения письменного согласия обоих родителей или законных представителей, поскольку несовершеннолетний не обладает полной дееспособностью.

б) Провести необходимое лечение с информированного согласия самого подростка, при этом уведомить родителей (за исключением случаев, когда такое уведомление может угрожать здоровью или жизни несовершеннолетнего), соблюдая баланс автономии и родительской ответственности согласно законодательству КР.

с) Лечить тайно без какого-либо уведомления родителей, полностью уважая право подростка на конфиденциальность медицинской информации.

д) Направить несовершеннолетнего в суд для решения вопроса о самостоятельном согласии на лечение.

е) Требовать обязательного присутствия и письменного согласия обоих родителей даже при отсутствии угрозы жизни, так как возраст 16 лет ещё не даёт права на самостоятельное медицинское решение.

№24. Оцените правомерность отказа врача от приёма пациента в состоянии алкогольного опьянения с позиции медицинской деонтологии и профессиональной ответственности.

а) Абсолютное нарушение профессионального долга, поскольку врач обязан оказывать медицинскую помощь всем обратившимся независимо от их состояния.

б) Правильно только в случае реальной угрозы безопасности персонала и других пациентов; в остальных случаях необходимо оказать неотложную помощь, документировать состояние пациента и факт отказа в приёме в установленной форме.

с) Всегда правильное действие, так как приём пациента в состоянии алкогольного опьянения автоматически нарушает санитарно-эпидемиологические нормы и деонтологические принципы.

- д) Нарушение только в том случае, если пациент уже состоит на диспансерном учёте; для первичных пациентов отказ допустим.
- е) Правильно при условии обязательной записи в журнале отказов и последующего уведомления главного врача поликлиники.

№25. Врач-стоматолог обнаружил, что коллега-терапевт в соседнем кабинете нарушает установленную структуру приёма (ведёт пациентов без использования смотрового кабинета). Какую деонтологическую обязанность должен реализовать врач в данной ситуации?

- а) Игнорировать нарушение, поскольку каждый врач самостоятельно несёт ответственность за организацию своего рабочего места.
- б) Тактично указать коллеге на нарушение организационных норм, предложить помощь в правильной организации приёма и, при отсутствии положительной динамики, доложить заведующему отделением в корректной профессиональной форме.

- с) Прямо сообщить пациенту коллеги, что «ваш врач нарушает установленный порядок приёма», чтобы защитить интересы больного.
- д) Перехватить пациента и принять его в своём кабинете согласно всем требованиям структуры приёма.
- е) Молчать и не вмешиваться, так как принцип невмешательства в работу коллег является одним из ключевых положений кодекса этики медицинского работника КР.

№26. Выберите согласно организационной структуре терапевтической стоматологии Кыргызской Республики и рекомендациям ВОЗ (Global Oral Health Status Report 2022), какой из перечисленных принципов не является обязательным при интеграции стоматологической помощи в систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на уровне ЦСМ?

- а) Принцип межсекторального взаимодействия с эндокринологической, ревматологической и кардиологической службами для обеспечения комплексного подхода к пациентам с сопутствующей соматической патологией.
- б) Принцип обязательной централизации всех терапевтических приёмов в одном блоке для снижения затрат и повышения экономической эффективности работы поликлиники.
- с) Принцип активного динамического наблюдения (активный вызов пациентов групп Д-II и Д-III) с использованием современных средств коммуникации.
- д) Принцип ступенчатой медицинской помощи с чётким разграничением компетенций между врачом-стоматологом общей практики и узкими специалистами.
- е) Принцип непрерывности профилактики и диспансеризации с использованием единой электронной системы учёта и преемственности данных между уровнями оказания помощи.

№27. Укажите в нормативной базе КР (Приказ МЗ КР № 456 от 2021 г. и последующих): принципы диспансерного учета в терапевтической стоматологии включают дифференцированность, комплексность, плановость и активность. Какой дополнительный принцип, прямо заимствованный из стратегии ВОЗ «Здоровье полости рта 2030», должен быть интегрирован в систему диспансеризации КР?

- а) Принцип тотальной санации полости рта за один визит независимо от степени риска и соматического статуса пациента.
- б) Принцип equity (справедливости) и приоритетного охвата уязвимых групп населения (беременные, дети, пациенты с неинфекционными заболеваниями) с выделением дополнительных ресурсов.
- с) Принцип максимальной коммерциализации профилактических программ и перевода диспансерного наблюдения на платную основу.
- д) Принцип отказа от диспансерного учета пациентов старше 60 лет ввиду высокой соматической отягощённости и низкой ожидаемой эффективности.
- е) Принцип обязательного использования только импортных материалов и технологий при лечении всех диспансерных пациентов.

№28. При формировании плана диспансерного наблюдения пациента с хроническим генерализованным пародонтитом (группа Д-III) в условиях КР врач обязан соблюдать принцип выбора ведущего звена. Укажите кого следует определить ведущим звеном диспансеризации у пациента с ХГП на фоне СД2 и хронического гастрита.

- а) Только терапевт-стоматолог как специалист, отвечающий за локальное лечение пародонтита.
- б) Междисциплинарная команда с ведущей ролью врача-стоматолога терапевта-пародонтолога при обязательном участии эндокринолога и гастроэнтеролога и внесением согласованных сроков совместного наблюдения в контрольную карту.
- с) Эндокринолог как специалист по основному системному заболеванию, поскольку коррекция уровня гликемии автоматически улучшает состояние пародонта.

д) Врач общей практики ЦСМ без участия стоматолога, так как пародонтит рассматривается как проявление системной патологии.

е) Хирург-стоматолог как наиболее радикальное звено, поскольку при декомпенсированном пародонтите приоритет отдаётся удалению подвижных зубов.

№29. Определите и обоснуйте оптимальный режим диспансерного наблюдения для беременной пациентки, относящейся к группе Д-II (с некариозными поражениями), с учётом клинической ситуации?

а) Пожизненное диспансерное наблюдение без каких-либо плановых переосмотров, поскольку группа Д-II подразумевает минимальный риск и не требует активного контроля со стороны стоматолога.

б) Диспансерное наблюдение до родов с ежемесячным контролем состояния твёрдых тканей зубов, гигиены и некариозных поражений + постнатальный перевод в группу Д-I или Д-III в зависимости от клинической динамики и рекомендаций акушера-гинеколога.

с) Ограничение только одним профилактическим визитом в первом триместре беременности, так как дальнейшее наблюдение выходит за рамки компетенции стоматологической службы первичного звена.

д) Диспансерное наблюдение до достижения пациентом 18-летнего возраста, поскольку некариозные поражения у беременных часто связаны с возрастными изменениями минерального обмена и требуют длительного мониторинга.

е) Отсутствие диспансерного учёта в принципе, поскольку пациент относится к группе Д-II («практически здоров») и наличие беременности не является самостоятельным основанием для постановки на учёт по стоматологической патологии.

№30. Выберите наиболее важное организационно-деонтологическое требование к организации приёма терапевтического стоматолога в условиях централизованного размещения поликлиники и высокого потока пациентов

а) Максимальное сокращение времени приёма до 10 минут на пациента для повышения пропускной способности и выполнения нормативов по объёму оказанной помощи.

б) Обязательное соблюдение принципа «не навреди» путём строгого разведения потоков пациентов (инфекционные, иммунокомпрометированные, плановые) и обеспечение конфиденциальности беседы и медицинской документации.

с) Приоритет коммерческих пациентов над диспансерными, поскольку доход от платных услуг позволяет финансировать работу всего терапевтического отделения.

д) Отсутствие необходимости ведения формы 030/у при большом потоке пациентов, так как электронная система автоматически формирует статистику.

е) Разрешение приёма пациентов без предварительного осмотра в смотровом кабинете для ускорения процесса и снижения очередей.

№31. В ЦСМ №2, Бишкек (Кыргызстан), по Программе государственных гарантий обратился пациент 58 лет с декомпенсированным хроническим генерализованным пародонтитом (группа Д-IIIб), артериальной гипертензией III стадии (криз 2 дня назад) и приёмом варфарина. Определите наиболее правильную последовательность действий врача-стоматолога-терапевта с учётом организационной структуры стоматологической службы, принципов диспансерного наблюдения и рекомендаций ВОЗ по интеграции стоматологической помощи при неинфекционных заболеваниях:

а) Немедленное начало пародонтологического лечения с использованием местных гемостатических средств и антибиотикопрофилактики без дополнительных консультаций, поскольку пародонтит является ведущим звеном и требует скорейшей санации.

б) Осмотр в смотровом кабинете → направление на срочную консультацию кардиолога и определение МНО → документирование отложенной постановки на диспансерный учёт до стабилизации соматического статуса и получения письменного согласия кардиолога → внесение в форму 030/у только после этого.

с) Автоматическая постановка на диспансерный учёт и направление в хирургическое отделение для одномоментного удаления всех подвижных зубов в одном блоке с целью быстрой санации полости рта.

д) Отказ в приёме со ссылкой на отсутствие терапевтического профиля в ЦСМ и необходимость оказания помощи только в специализированных стоматологических учреждениях.

е) Лечение в терапевтическом кабинете без направления и без учёта антикоагулянтной терапии, так как варфарин не является абсолютным противопоказанием к пародонтологическим манипуляциям в условиях ЦСМ.

№32. В децентрализованном терапевтическом кабинете при ЦСМ сельского района КР беременная женщина на 28 неделе с множественным кариесом и начальными проявлениями гингивита требует постановки на диспансерный учёт. Муж пациентки настаивает на «полном лечении за один визит под

общим обезболиванием». Выявите какое решение будет правильным согласно нормам КР и ВОЗ (принцип справедливости и безопасности для уязвимых групп)

а) Выполнить все манипуляции в один визит под седацией по требованию мужа, поскольку беременность не является противопоказанием к стоматологическому лечению, а совместное решение супругов имеет приоритет.

б) Осмотр в смотровом кабинете → объяснение рисков → составление поэтапного плана с приоритетом неинвазивных методов → постановка на диспансерный учёт по форме 030/у с указанием срока беременности и ежемесячным контролем → обязательное информированное согласие самой пациентки (а не мужа).

в) Направление только в республиканский центр без постановки на учёт в ЦСМ, так как децентрализованные кабинеты не имеют права вести диспансерное наблюдение беременных.

г) Отказ в диспансерном учёте до окончания беременности, поскольку любые стоматологические вмешательства в третьем триместре повышают риск осложнений для плода.

д) Лечение без согласия пациентки по настоянию мужа, так как в сельской местности решение семьи часто рассматривается как коллективное и имеет юридический вес.

№33. Заведующий терапевтическим отделением центральной стоматологической поликлиники КР проводит внутренний аудит. Выявлено, что один врач ставит всех пациентов с хроническим пульпитом на диспансерный учёт сразу после первого визита без рентген-контроля и без консультации при сопутствующей патологии. Это действие нарушает сразу несколько принципов диспансерного учёта. Укажите, какой принцип нарушен в наибольшей степени?

а) Принцип активности, поскольку врач не проводит активный вызов пациентов после постановки на учёт.

б) Принцип дифференцированности и комплексности (отсутствие этапа полноценного обследования, рентгенологической диагностики и междисциплинарного подхода при сопутствующей патологии).

в) Принцип плановости, так как постановка на учёт осуществляется без разработки индивидуального графика наблюдения.

г) Принцип equity, поскольку такой подход приводит к неравенству в объёме обследования разных категорий пациентов.

д) Принцип децентрализации, так как врач игнорирует необходимость направления сложных пациентов в специализированные учреждения.

№34. Пациент 32 лет, ВИЧ-инфицированный (стадия латентная, вирусная нагрузка undetectable), с обострением хронического верхушечного периодонтита обратился в терапевтическое отделение ЦСМ. Коллега врача предлагает принять пациента в общем потоке «чтобы не создавать отдельный график». Укажите ответ согласно организационной структуре, санитарным нормам КР и деонтологическим требованиям:

а) Принять пациента в общем потоке — это не нарушает конфиденциальность и соответствует принципу равенства всех пациентов перед медицинской помощью.

б) Организовать приём в изолированном кабинете или в конце смены после тщательной дезинфекции, обеспечить конфиденциальность данных, поставить на диспансерный учёт с пометкой «особая группа» только в служебной документации и провести лечение с повышенными мерами асептики.

в) Отказать в помощи из-за ВИЧ-статуса, так как риск перекрестного инфицирования в условиях ЦСМ слишком высок и требует специализированных условий.

г) Сообщить всем сотрудникам отделения о статусе пациента для обеспечения максимальной безопасности персонала во время приёма.

д) Направить пациента только в инфекционную больницу, поскольку терапевтические отделения ЦСМ не предназначены для работы с ВИЧ-инфицированными пациентами.

№35. Врач-стоматолог-терапевт ЦСМ получил письменный запрос от прокурора района на предоставление полной амбулаторной карты и контрольной карты диспансерного наблюдения пациента, проходящего по уголовному делу (подозрение в уклонении от лечения). Пациент ранее писал отказ от диспансерного учёта. Определите правильное действие врача по принципам деонтологии и организации?

а) Немедленно предоставить все оригиналы документов, поскольку официальный запрос от прокурора имеет высшую юридическую силу.

б) Предоставить только те сведения, которые прямо запрошены и только по официальному мотивированному запросу с соблюдением установленной процедуры; предварительно уведомить пациента (если это не запрещено законом) или документировать факт запроса, сохраняя врачебную тайну в максимально возможном объёме.

- с) Отказать полностью в предоставлении любой информации, сославшись на врачебную тайну и отсутствие согласия пациента.
- д) Предоставить данные без регистрации запроса и без уведомления руководства поликлиники, чтобы ускорить процесс.
- е) Уничтожить карту до предоставления ответа на запрос, чтобы избежать нарушения конфиденциальности.

№36. В ЦСМ планируется интеграция стоматологической помощи в ПМСП. Руководство предлагает внедрить ряд организационных принципов. Проанализируйте предложенные принципы и: определите, какой из них противоречит рекомендациям Всемирная организация здравоохранения; обоснуйте, почему он не соответствует современной модели интеграции; предложите альтернативное решение.

- а) Принцип межсекторального взаимодействия с эндокринологической, ревматологической и кардиологической службами для обеспечения комплексного подхода к пациентам с сопутствующей соматической патологией.
- б) Принцип обязательной централизации всех терапевтических приёмов в одном блоке для снижения затрат и повышения экономической эффективности работы поликлиники.
- с) Принцип активного динамического наблюдения (активный вызов пациентов групп Д-II и Д-III) с использованием современных средств коммуникации.
- д) Принцип ступенчатой медицинской помощи с чётким разграничением компетенций между врачом-стоматологом общей практики и узкими специалистами.
- е) Принцип непрерывности профилактики и диспансеризации с использованием единой электронной системы учёта и преемственности данных между уровнями оказания помощи.

№37. В поликлинике внедряется система диспансеризации стоматологических пациентов. Несмотря на соблюдение принципов комплексности и плановости, охват уязвимых групп остаётся низким. Определите, какой дополнительный принцип из стратегии Всемирная организация здравоохранения «Здоровье полости рта 2030» необходимо внедрить; объясните, как его реализация повлияет на доступность помощи; приведите пример практического применения на уровне ЦСМ.

- а) Принцип тотальной санации полости рта за один визит независимо от степени риска и соматического статуса пациента.
- б) Принцип equity (справедливости) и приоритетного охвата уязвимых групп населения (беременные, дети, пациенты с неинфекционными заболеваниями) с выделением дополнительных ресурсов.
- с) Принцип максимальной коммерциализации профилактических программ и перевода диспансерного наблюдения на платную основу.
- д) Принцип отказа от диспансерного учета пациентов старше 60 лет ввиду высокой соматической отягощённости и низкой ожидаемой эффективности.
- е) Принцип обязательного использования только импортных материалов и технологий при лечении всех диспансерных пациентов.

№38. При формировании плана диспансерного наблюдения пациента с хроническим генерализованным пародонтитом (группа Д-III) в условиях КР врач обязан соблюдать принцип выбора ведущего звена. Выявите: в случае сочетания пародонтита с сахарным диабетом 2 типа и хроническим гастритом ведущим звеном диспансеризации является:

- а) Только терапевт-стоматолог как специалист, отвечающий за локальное лечение пародонтита.
- б) Междисциплинарная команда с ведущей ролью врача-стоматолога терапевта-пародонтолога при обязательном участии эндокринолога и гастроэнтеролога и внесением согласованных сроков совместного наблюдения в контрольную карту.
- с) Эндокринолог как специалист по основному системному заболеванию, поскольку коррекция уровня гликемии автоматически улучшает состояние пародонта.
- д) Врач общей практики ЦСМ без участия стоматолога, так как пародонтит рассматривается как проявление системной патологии.
- е) Хирург-стоматолог как наиболее радикальное звено, поскольку при декомпенсированном пародонтите приоритет отдаётся удалению подвижных зубов.

№39. Определите согласно Кодексу профессиональной этики медицинского работника Кыргызской Республики (2004, с изменениями) и деонтологическим требованиям при диспансерном учете, какое действие врача-стоматолога терапевта является грубым нарушением медицинской деонтологии?

- а) Документирование информированного добровольного отказа пациента от диспансерного наблюдения с подробным объяснением последствий в амбулаторной карте.

- б) Разглашение третьим лицам (включая страховую компанию без письменного согласия пациента) данных о диагнозе, диспансерном статусе и сопутствующих заболеваниях, даже если это мотивировано необходимостью оплаты лечения по Программе госгарантий.
- с) Активный вызов пациента на контрольный осмотр через SMS с указанием только даты и кабинета без раскрытия диагноза.
- д) Консультация с коллегой по сложному клиническому случаю без указания ФИО пациента и с использованием обезличенных данных.
- е) Предоставление пациенту копии его контрольной карты диспансерного наблюдения по его письменному запросу с отметкой о выдаче.

№40. В стоматологической поликлинике с централизованной структурой и высоким потоком пациентов врач-стоматолог организует приём. Определите, какое организационно-технологическое требование является ведущим для оптимизации работы и снижения времени ожидания пациентов:

- а) Максимальное сокращение времени приёма до 10–12 минут на пациента для повышения пропускной способности и выполнения плановых нормативов по объёму оказанной помощи.
- б) Обязательное соблюдение принципа «не навреди» путём строгого разведения потоков пациентов (инфекционные, иммунокомпрометированные, плановые) и обеспечение конфиденциальности беседы и медицинской документации в условиях централизованного здания.
- с) Приоритет коммерческих пациентов над диспансерными, поскольку доход от платных услуг позволяет финансировать работу терапевтического отделения и приобретение современного оборудования.
- д) Отсутствие необходимости ведения формы 030/у при большом потоке, так как электронная система автоматически формирует всю статистику и отчёты для вышестоящих органов.
- е) Разрешение приёма пациентов без предварительного осмотра в смотровом кабинете для ускорения процесса и снижения очередей в условиях централизованного размещения всех отделений.

№41. Укажите состав самоадгезивных bulk-fill композитов нового поколения (SureFil One, Futurabond One и аналоги 2025)

- а) Только нейтральные метакрилаты без кислотных функциональных групп, что обеспечивает высокую биосовместимость и минимальную технику-чувствительность при работе в условиях повышенной влажности.
- б) Кислотные функциональные мономеры (фосфорные и карбоксильные) + самоэкранирующиеся силановые системы, позволяющие химическую адгезию к дентину и эмали без отдельного адгезива, при этом сохраняя контроль над глубиной деминерализации.
- с) Только стеклоиономерные компоненты без полимерной матрицы, что даёт длительный ионный релиз и полную независимость от техники протравливания.
- д) Силорановую матрицу с низкой полимеризационной усадкой, но требующую специального оборудования для полимеризации.
- е) Исключительно фотоинициаторы без химических компонентов, что позволяет проводить полимеризацию только мощными LED-лампами последнего поколения.

№42. Определите по данным мета-анализов 2023–2026 гг.: наиболее значимым преимуществом bulk-fill композитов нового поколения по сравнению с традиционными инкрементальными композитами является:

- а) Худшая адаптация к стенкам полости и повышенный риск микроподтеканий при объёмном внесении.
- б) Снижение С-фактора и полимеризационного стресса при объёмном внесении слоем 4–5 мм за счёт модифицированной вязкоупругой матрицы и современных фотоинициаторов.
- с) Увеличение времени полимеризации до 60 секунд на каждый слой для достижения максимальной степени конверсии.
- д) Полное отсутствие необходимости в адгезивной системе даже при работе с дентином средней глубины.
- е) Снижение механической прочности на 30 % по сравнению с классическими композитами, что компенсируется повышенной биоактивностью.

№43. Выберите механизм, объясняющий реминерализующее действие современных стоматологических материалов на основе наногидроксиапатита и аморфного фосфата кальция при лечении начального кариеса (поколение 2025 года)

- а) Пассивную диффузию ионов в сочетании с механическим уплотнением деминерализованных участков за счёт полимеризационной усадки материала.
- б) Только поверхностное антибактериальное действие без значимого проникновения ионов в глубину дентина.
- с) Активное образование карбонатапатита в деминерализованном дентине при $\text{pH} < 5,5$ за счёт частиц размером ≤ 100 нм, что позволяет динамически восстанавливать структуру твёрдых тканей даже в условиях высокой кариесогенной нагрузки.

- д) Полное отсутствие химического взаимодействия с дентином, поскольку материал действует преимущественно на уровне эмали через создание защитной плёнки.
- е) Высвобождение тяжёлых металлов для подавления бактериальной активности с последующим вторичным минерализационным эффектом.

№44. Отметьте, степень конверсии (DC) в новых универсальных композитах с двойным механизмом инициации (Ivocerin + традиционный CQ) достигает:

- а) 45–55 % на глубине 5 мм при стандартной полимеризации 20 секунд, что требует обязательного послойного внесения.
- б) Менее 30 % в толстом слое независимо от мощности лампы, поскольку двойной механизм не компенсирует снижение интенсивности света.
- в) 75–85 % на глубине 4–5 мм при полимеризации 20 секунд лампой с длиной волны 385–515 нм, благодаря расширенному спектру поглощения Ivocerin.
- д) 100 % только при дополнительном химическом отверждении, так как фотоинициаторы не способны обеспечить полную конверсию в глубоких слоях.
- е) Не зависит от толщины слоя, поскольку двойной механизм полностью нивелирует влияние расстояния до источника света.

№45. Сравните стоматологические материалы и укажите, какой из них демонстрирует «умное» высвобождение фтора и в каких условиях это свойство проявляется наиболее эффективно.

- а) Одноразовый мощный выброс фтора в первые 24 часа с последующим быстрым истощением запасов.
- б) Высокий начальный выброс с последующим истощением за 7–10 дней, после чего материал переходит в инертное состояние.
- в) Постоянный низкоуровневый релиз + эффект recharge при контакте с фторсодержащими средствами за счёт S-PRG, сохраняющийся более 24 месяцев без значительной потери механических свойств.
- д) Полное отсутствие recharge, что ограничивает применение материала у пациентов высокого кариес-риска.
- е) Только антибактериальный эффект без реального ионного релиза фтора, поскольку фтор находится в химически связанной стабильной форме.

№46. Объясните, к каким клинико-физическим последствиям приводит отсутствие классических метакрилатов в ормокерах нового поколения (например, Admira Fusion).

- а) Увеличению водопоглощения более 40 мкг/мм³ и повышению риска вторичного кариеса.
- б) Повышению полимеризационной усадки до уровня традиционных гибридных композитов.
- в) Снижению водопоглощения и растворимости (<15 мкг/мм³), минимальной цитотоксичности и отсутствию остаточных мономеров Bis-GMA, что значительно повышает биосовместимость.
- д) Необходимости тотального протравливания эмали и дентина для достижения адекватной адгезии.
- е) Запрету применения в боковых зубах из-за недостаточной механической прочности.

№47. Укажите: благодаря чему биоактивные-композиты (типа Activa BioACTIVE) обладают «амортизирующим» эффектом:

- а) Жёсткой стеклоиономерной матрице, которая эффективно распределяет окклюзионную нагрузку.
- б) Полному отсутствию эластичности, что обеспечивает максимальную твёрдость и износостойкость.
- в) Эластичной резиноподобной полимерной матрице + ион-реактивным наполнителям, позволяющей поглощать окклюзионные нагрузки и предотвращать образование микротрещин.
- д) Только высокой твёрдости поверхности после полимеризации.
- е) Исключительно химическому отверждению, которое создаёт более плотную структуру.

№48. Укажите где, по рекомендациям ВСФ 2025 года, материалы нового поколения с антимикробными свойствами на основе QAS (четвертичный аммониевый силан) применяются преимущественно:

- а) Только в передних зубах для достижения максимального эстетического результата.
- б) Исключительно в качестве временных пломб, поскольку долговременный антимикробный эффект нарушает баланс микрофлоры.
- в) У пациентов высокого кариес-риска для подавления *Streptococcus mutans* и *Lactobacillus* за счёт ковалентно-связанных QAS-мономеров, не вымывающихся со временем.
- д) Только при отсутствии адгезива, так как кислотные мономеры несовместимы с традиционными адгезивными системами.
- е) С обязательным тотальным протравливанием 37% ортофосфорной кислотой для активации антимикробных свойств.

№49. Проанализируйте, какие компоненты и химические свойства обеспечивают самопротравливающую адгезию в современных композитах (2024–2026 гг.) без применения отдельного праймера

а) Только механической ретенции за счёт высокой текучести материала и глубокого проникновения в дентинные каналы.

б) Стеклоиономерной реакции, которая полностью заменяет необходимость в адгезивной системе и обеспечивает длительный ионный релиз.

с) Кислотных фосфатных и карбоксильных мономеров + функционализированных наночастиц, образующих гибридный слой толщиной 2–4 мкм с контролируемой глубиной деминерализации и химической связью.

д) Полного отсутствия химической связи с дентином, поскольку материал предназначен только для временного пломбирования.

е) Только тотального протравливания 37% ортофосфорной кислотой перед внесением, что активирует самоадгезивные свойства.

№50. Какой из перечисленных факторов наиболее характерен как критический недостаток большинства биоактивных материалов нового поколения по сравнению с традиционными наногибридными композитами

а) Сверхвысокая механическая прочность и flexural strength более 200 Мпа, что делает их избыточно жёсткими для окклюзионных зон.

б) Более низкая износостойкость и flexural strength (80–110 Мпа) при окклюзионных нагрузках, что требует дополнительного покрытия в нагрузочных зонах.

с) Полное отсутствие биоактивности и ионного релиза, что сводит их преимущества только к упрощённой технике внесения.

д) Нулевая полимеризационная усадка, которая приводит к чрезмерному напряжению в стенках полости.

е) Запрету применения в полостях класса I из-за высокой опаковости и плохой эстетики.

№51. Какой процесс является характерным для материалов с «умной полимерной» технологией (Cention N и аналоги) при кислотной атаке в полости рта?

а) Полимеризационная усадка, которая механически уплотняет материал и предотвращает дальнейшее проникновение кислот.

б) Снижение pH внутри материала, что усиливает антибактериальный эффект, но ускоряет деградацию полимерной матрицы.

с) Автоматическое повышение pH и высвобождение ионов кальция/фосфата, приводящее к образованию защитного слоя гидроксиапатита и динамической реминерализации.

д) Полное растворение материала с высвобождением большого количества фтора для немедленной остановки кариозного процесса.

е) Отсутствие какой-либо реакции на изменение pH, поскольку «smart polymer» предназначен исключительно для механической защиты.

№52. На основании данных in vitro исследований 2025 года оцените, какой из представленных реставрационных материалов наиболее эффективен в снижении маргинальной проницаемости в полостях V класса, и обоснуйте выбор.

а) Традиционные макронаполненные композиты с высоким содержанием кварцевых частиц, обеспечивающие максимальную механическую ретенцию.

б) Только самоадгезивные bulk-fill материалы без дополнительного покрытия, благодаря кислотным мономерам и низкой полимеризационной усадке.

с) Ормокер- и гиомер-материалы нового поколения за счёт низкой усадки и химической адгезии к тканям зуба.

д) Материалы с максимальной водопоглощаемостью, которые компенсируют усадку за счёт расширения при гидратации.

е) Композиты без наноапполнителей, поскольку крупные частицы лучше адаптируются к стенкам полости и снижают краевую проницаемость.

№53. Какой фотоинициатор нового поколения обеспечивает эффективную полимеризацию композитных материалов при толщине слоя 4–5 мм в течение 10–20 секунд?

а) Только классический камфорохинон (CQ), который остаётся стандартом благодаря проверенной эффективности и низкой стоимости.

б) Только химические инициаторы, поскольку они обеспечивают полную конверсию независимо от толщины слоя и мощности лампы.

с) Ivocerin (дибензоилдиэтилгерманий) в сочетании с CQ и дополнительными акселераторами.

д) Отсутствие фотоинициаторов, так как современные материалы отверждаются исключительно химическим путём для глубоких слоёв.

е) Только LED-лампы старого поколения с длиной волны 450 нм, поскольку они лучше проникают через толстые слои композита.

№54. Какое свойство является основным результатом использования «наноточностной» технологии в композитах (2026), связанной с размером и распределением наполнителя?

а) Шероховатости поверхности $>0,5$ мкм после полировки, что улучшает ретенцию и снижает риск сколов.

б) Высокой опакости и плохой эстетики, что делает материал непригодным для фронтальной группы зубов.

с) Увеличенной полимеризационной усадки, которая компенсируется повышенной прочностью на разрыв.

д) Поверхностной шероховатости $Ra < 0,1$ мкм и износостойкости, сопоставимой с эмалью, за счёт равномерного распределения наночастиц 5–20 нм.

е) Полного отсутствия необходимости полировки, поскольку материал обладает самополирующимися свойствами.

№55. Согласно современным клиническим рекомендациям ВСФ&AAE (2025–2026), проанализируйте клинические ситуации и определите, в каких случаях в первую очередь показано применение материалов нового поколения с доказанной биоактивностью и ионным высвобождением.

а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы, где приоритет отдаётся оптическим свойствам и цветостабильности.

б) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости, реставрации после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.

с) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушать баланс микрофлоры полости рта.

д) Только в сочетании с тотальным протравливанием 37 % ортофосфорной кислотой для активации ионного релиза.

е) При отсутствии каких-либо соматических заболеваний, так как системные факторы снижают эффективность реминерализации.

№56. Выберите, какие клинические свойства улучшаются за счёт оптимизированного размера наполнителя и его распределения в композитах с «nanoprecision»-технологией (2026).

а) Шероховатости поверхности $>0,5$ мкм после полировки, что улучшает механическую ретенцию и снижает риск сколов краёв.

б) Высокой опакости и плохой эстетики, что делает материал непригодным для фронтальной группы зубов.

с) Увеличенной полимеризационной усадки, которая компенсируется повышенной прочностью на разрыв.

д) Поверхностной шероховатости $Ra < 0,1$ мкм и износостойкости, сопоставимой с эмалью, за счёт равномерного распределения наночастиц 5–20 нм.

е) Полного отсутствия необходимости полировки, поскольку материал обладает самополирующимися свойствами благодаря специальному покрытию частиц.

№57. Проанализируйте клинические рекомендации FDI & AAE (2025–2026) и определите, в каких клинических ситуациях предпочтительно первоочередное применение материалов нового поколения с биоактивностью и ионным релизом. Обоснуйте свой выбор.

а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы, где приоритет отдаётся оптическим свойствам и цветостабильности.

б) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушать баланс микрофлоры полости рта.

с) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости, реставрации после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.

д) Только в сочетании с тотальным протравливанием 37 % ортофосфорной кислотой для активации ионного релиза.

е) При отсутствии каких-либо соматических заболеваний, так как системные факторы снижают эффективность реминерализации.

№58. Проанализируйте показания к применению материалов нового поколения с антимикробными свойствами на основе QAS (четвертичного аммониевого силана) согласно рекомендациям ВСФ 2025 года и определите их преимущественное клиническое использование.

а) Только в передних зубах для достижения максимального эстетического результата и естественной флуоресценции.

б) Исключительно в качестве временных пломб, поскольку долговременный антимикробный эффект может нарушить баланс нормальной микрофлоры полости рта.

с) У пациентов высокого кариес-риска для подавления *Streptococcus mutans* и *Lactobacillus* за счёт ковалентно-связанных QAS-мономеров, не вымывающихся со временем.

д) Только при отсутствии адгезива, так как кислотные мономеры QAS несовместимы с традиционными адгезивными системами и требуют отдельного праймера.

е) С обязательным тотальным протравливанием 37% ортофосфорной кислотой для активации антимикробных свойств материала.

№59. За счёт каких механизмов в самоадгезивных текучих композитах нового поколения (2024–2026) обеспечивается адгезия к дентину без применения отдельного праймера?

а) Только механической ретенции за счёт высокой текучести материала и глубокого проникновения в дентинные каналы без химического взаимодействия.

б) Стеклоиономерной реакции, которая полностью заменяет необходимость в адгезивной системе и обеспечивает длительный ионный релиз.

с) Кислотных фосфатных и карбоксильных мономеров + функционализированных наночастиц, образующих гибридный слой толщиной 2–4 мкм с контролируемой глубиной деминерализации и химической связью.

д) Полного отсутствия химической связи с дентином, поскольку материал предназначен только для временного пломбирования и не требует долговременной адгезии.

е) Только тотального протравливания 37% ортофосфорной кислотой перед внесением, что активирует самоадгезивные свойства материала.

№60. Укажите что является критическим недостатком большинства биоактивных-материалов нового поколения по сравнению с традиционными нано-гибридными композитами

а) Сверхвысокая механическая прочность и flexural strength более 200 МПа, что делает их избыточно жёсткими для окклюзионных зон.

б) Более низкая износостойкость и flexural strength (80–110 МПа) при окклюзионных нагрузках, что требует дополнительного покрытия в нагрузочных зонах для предотвращения преждевременного износа.

с) Полное отсутствие биоактивности и ионного релиза, что сводит их преимущества только к упрощённой технике внесения.

д) Нулевая полимеризационная усадка, которая приводит к чрезмерному напряжению в стенках полости и риску перелома зуба.

е) Запрет применения в полостях класса I из-за высокой опаковости и плохой эстетики.

№61. Как изменяются свойства материалов с «умной полимерной» технологией (Cention N и аналоги) при кислотной атаке и какое клиническое значение это имеет?

а) Полимеризационная усадка, которая механически уплотняет материал и предотвращает дальнейшее проникновение кислот.

б) Снижение pH внутри материала, что усиливает антибактериальный эффект, но ускоряет деградацию полимерной матрицы.

с) Автоматическое повышение pH и высвобождение ионов кальция/фосфата, приводящее к образованию защитного слоя гидроксиапатита и динамической реминерализации.

д) Полное растворение материала с высвобождением большого количества фтора для немедленной остановки кариозного процесса.

е) Отсутствие какой-либо реакции на изменение pH, поскольку «smart polymer» предназначен исключительно для механической защиты.

№62. Определите по данным in-vitro исследований 2025 года: наименьшую маргинальную проницаемость в полостях класса V демонстрируют:

а) Традиционные макронаполненные композиты с высоким содержанием кварцевых частиц, обеспечивающие максимальную механическую ретенцию.

б) Только самоадгезивные bulk-fill материалы без дополнительного покрытия, благодаря кислотным мономерам и низкой полимеризационной усадке.

с) Ormocer- и giomer-материалы нового поколения за счёт низкой усадки и химической адгезии к тканям зуба.

д) Материалы с максимальной водопоглощаемостью, которые компенсируют усадку за счёт расширения при гидратации.

е) Композиты без нанонаполнителей, поскольку крупные частицы лучше адаптируются к стенкам полости и снижают краевую проницаемость.

№63. Укажите: согласно современным клиническим рекомендациям (FDI & AAE 2025–2026), материалы нового поколения с доказанной биоактивностью и ион-релизом показаны в первую очередь:

- а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы, где приоритет отдаётся оптическим свойствам, цветостабильности и естественной флуоресценции.
- б) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушить баланс нормальной микрофлоры полости рта и привести к дисбиозу.
- с) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости, реставрации после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.
- д) Только в сочетании с тотальным протравливанием 37 % ортофосфорной кислотой для максимальной активации ионного релиза и реминерализации.
- е) При отсутствии каких-либо соматических заболеваний, так как системные факторы (диабет, ксеростомия) значительно снижают эффективность биоактивных свойств материала.

№64. Выберите в композитах с «наноточность»-технологией (2026) размер наполнителя и его распределение позволяют достичь:

- а) Шероховатости поверхности $>0,5$ мкм после полировки, что улучшает механическую ретенцию и снижает риск сколов краёв реставрации.
- б) Высокой опакости и плохой эстетики, что делает материал непригодным для фронтальной группы зубов и требует обязательного использования опакеров.
- с) Увеличенной полимеризационной усадки, которая компенсируется повышенной прочностью на разрыв и модулем упругости.
- д) Поверхностной шероховатости $Ra < 0,1$ мкм и износостойкости, сопоставимой с эмалью, за счёт равномерного распределения наночастиц 5–20 нм.
- е) Полного отсутствия необходимости полировки, поскольку материал обладает самополирующимися свойствами благодаря специальному покрытию частиц.

№65. Определите по данным in-vitro исследований 2025 года: наименьшую маргинальную проницаемость в полостях класса V демонстрируют:

- а) Традиционные макронаполненные композиты с высоким содержанием кварцевых частиц, обеспечивающие максимальную механическую ретенцию к стенкам полости.
- б) Только самоадгезивные bulk-fill материалы без дополнительного покрытия, благодаря кислотным мономерам и низкой полимеризационной усадке.
- с) Ормокер- и гиомер-материалы нового поколения за счёт низкой усадки и химической адгезии к тканям зуба.
- д) Материалы с максимальной водопоглощаемостью, которые компенсируют усадку за счёт расширения при гидратации и улучшают краевое прилегание.
- е) Композиты без нанонаполнителей, поскольку крупные частицы лучше адаптируются к неровным стенкам полости и снижают краевую проницаемость.

№66. Укажите: ключевым фотоинициатором нового поколения, позволяющим проводить полимеризацию через слой композита 4–5 мм за 10–20 секунд, является:

- а) Только классический camphorquinone (CQ), который остаётся золотым стандартом благодаря проверенной клинической эффективности и низкой стоимости.
- б) Только химические инициаторы, поскольку они обеспечивают полную конверсию независимо от толщины слоя и мощности лампы.
- с) Ivocerin (дибензоилдиэтилгерманий) в сочетании с CQ и дополнительными акселераторами.
- д) Отсутствие фотоинициаторов, так как современные материалы отверждаются исключительно химическим путём для глубоких слоёв.
- е) Только LED-лампы старого поколения with длиной волны 450 нм, поскольку они лучше проникают через толстые слои композита.

№67. Выберите: в композитах с «наноточность»-технологией (2026) размер наполнителя и его распределение позволяют достичь:

- а) Шероховатости поверхности $>0,5$ мкм после полировки, что улучшает механическую ретенцию и снижает риск сколов краёв реставрации.
- б) Высокой опакости и плохой эстетики, что делает материал непригодным для фронтальной группы зубов.
- с) Увеличенной полимеризационной усадки, которая компенсируется повышенной прочностью на разрыв.
- д) Поверхностной шероховатости $Ra < 0,1$ мкм и износостойкости, сопоставимой с эмалью, за счёт равномерного распределения наночастиц 5–20 нм.
- е) Полного отсутствия необходимости полировки, поскольку материал обладает самополирующимися свойствами благодаря специальному покрытию частиц.

№68. Укажите: согласно современным клиническим рекомендациям FDI & AAE 2025–2026, материалы нового поколения с доказанной биоактивностью и ион-релизом показаны в первую очередь:

- а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы, где приоритет отдаётся оптическим свойствам, цветостабильности и естественной флуоресценции.
- б) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушить баланс нормальной микрофлоры полости рта.
- в) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости, реставрации после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.
- г) Только в сочетании с тотальным протравливанием 37 % ортофосфорной кислотой для максимальной активации ионного релиза.
- е) При отсутствии каких-либо соматических заболеваний, так как системные факторы (диабет, ксеростомия) значительно снижают эффективность биоактивных свойств.

№69. Определите: согласно современным клиническим рекомендациям (FDI & AAE 2025–2026), материалы нового поколения с доказанной биоактивностью и ион-релизом показаны в первую очередь:

- а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы, где приоритет отдаётся оптическим свойствам и цветостабильности.
- б) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушить баланс микрофлоры полости рта.
- в) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.
- г) Только в сочетании с тотальным протравливанием 37 % ортофосфорной кислотой для активации ионного релиза.
- е) При отсутствии каких-либо соматических заболеваний, так как системные факторы значительно снижают эффективность реминерализации.

№70. Выберите по данным in-vitro исследований 2025 года, наименьшую маргинальную проницаемость в полостях класса V демонстрируют:

- а) Традиционные макронаполненные композиты с высоким содержанием кварцевых частиц, обеспечивающие максимальную механическую ретенцию.
- б) Только самоадгезивные bulk-fill материалы без дополнительного покрытия благодаря кислотным мономерам.
- в) Ormocer- и giomer-материалы нового поколения за счёт низкой усадки и химической адгезии к тканям зуба.
- г) Материалы с максимальной водопоглощаемостью, которые компенсируют усадку за счёт расширения при гидратации.
- е) Композиты без наноапполнителей, поскольку крупные частицы лучше адаптируются к неровным стенкам полости.

№71. Установите ключевым фотоинициатором нового поколения, позволяющим проводить полимеризацию через слой композита 4–5 мм за 10–20 секунд, является:

- а) Только классический camphorquinone (CQ), который остаётся золотым стандартом благодаря проверенной эффективности.
- б) Только химические инициаторы, поскольку они обеспечивают полную конверсию независимо от толщины слоя.
- в) Ivocerin (дибензоилдиэтилгерманий) в сочетании с CQ и дополнительными акселераторами.
- г) Отсутствие фотоинициаторов, так как современные материалы отверждаются исключительно химическим путём.
- е) Только LED-лампы старого поколения с длиной волны 450 нм, поскольку они лучше проникают через толстые слои.

№72. Укажите в композитах с «наноточность»-технологией (2026) размер наполнителя и его распределение позволяют достичь:

- а) Шероховатости поверхности >0,5 мкм после полировки, что улучшает ретенцию и снижает риск сколов.
- б) Высокой опакости и плохой эстетики, что делает материал непригодным для фронтальной группы.
- в) Увеличенной полимеризационной усадкой, которая компенсируется повышенной прочностью на разрыв.
- г) Поверхностной шероховатости Ra <0,1 мкм и износостойкости, сопоставимой с эмалью, за счёт равномерного распределения наночастиц 5–20 нм.

е) Полного отсутствия необходимости полировки, поскольку материал обладает самополирующимися свойствами.

№73. Определите согласно современным клиническим рекомендациям FDI & AAE 2025–2026, материалы нового поколения с доказанной биоактивностью и ион-релизом показаны в первую очередь:

а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы для достижения идеальной цветопередачи.

б) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушить баланс микрофлоры.

с) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.

д) Только в сочетании с тотальным протравливанием для максимальной активации ионного релиза.

е) При отсутствии соматических заболеваний, так как системные факторы снижают эффективность реминерализации.

№74. Укажите по данным мета-анализов 2023–2026 гг., наиболее значимым преимуществом bulk-fill композитов нового поколения по сравнению с традиционными инкрементальными композитами является:

а) Худшая адаптация к стенкам полости и повышенный риск микроподтеканий при объёмном внесении.

б) Снижение С-фактора и полимеризационного стресса при объёмном внесении слоем 4–5 мм за счёт модифицированной вязкоупругой матрицы и современных фотоинициаторов.

с) Увеличение времени полимеризации до 60 секунд на каждый слой для достижения максимальной степени конверсии.

д) Полное отсутствие необходимости в адгезивной системе даже при работе с дентином средней глубины.

е) Снижение механической прочности на 30 % по сравнению с классическими композитами, что компенсируется повышенной биоактивностью.

№75. Определите согласно современным клиническим рекомендациям (FDI & AAE 2025–2026), материалы нового поколения с доказанной биоактивностью и ион-релизом показаны в первую очередь:

а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы, где приоритет отдаётся оптическим свойствам и цветостабильности.

б) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушить баланс нормальной микрофлоры полости рта.

с) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.

д) Только в сочетании с тотальным протравливанием 37 % ортофосфорной кислотой для максимальной активации ионного релиза.

е) При отсутствии каких-либо соматических заболеваний, так как системные факторы значительно снижают эффективность реминерализации.

№76. Выберите по данным in-vitro исследований 2025 года, наименьшую маргинальную проницаемость в полостях класса V демонстрируют:

а) Традиционные макронаполненные композиты с высоким содержанием кварцевых частиц, обеспечивающие максимальную механическую ретенцию.

б) Только самоадгезивные bulk-fill материалы без дополнительного покрытия благодаря кислотным мономерам.

с) Отмосег- и giomer-материалы нового поколения за счёт низкой усадки и химической адгезии к тканям зуба.

д) Материалы с максимальной водопоглощаемостью, которые компенсируют усадку за счёт расширения при гидратации.

е) Композиты без нанонаполнителей, поскольку крупные частицы лучше адаптируются к неровным стенкам полости.

№77. Укажите ключевым фотоинициатором нового поколения, позволяющим проводить полимеризацию через слой композита 4–5 мм за 10–20 секунд, является:

а) Только классический camphorquinone (CQ), который остаётся золотым стандартом благодаря проверенной эффективности.

б) Только химические инициаторы, поскольку они обеспечивают полную конверсию независимо от толщины слоя.

с) Ivocerin (дибензоилдиэтилгерманий) в сочетании с CQ и дополнительными акселераторами.

д) Отсутствие фотоинициаторов, так как современные материалы отверждаются исключительно химическим путём.

е) Только LED-лампы старого поколения с длиной волны 450 нм, поскольку они лучше проникают через толстые слои.

№78. Выберите в композитах с «наноточность»-технологией (2026) размер наполнителя и его распределение позволяют достичь:

- а) Шероховатости поверхности $>0,5$ мкм после полировки, что улучшает механическую ретенцию и снижает риск сколов.
- б) Высокой опакости и плохой эстетики, что делает материал непригодным для фронтальной группы.
- в) Увеличенной полимеризационной усадки, которая компенсируется повышенной прочностью на разрыв.
- д) Поверхностной шероховатости $Ra <0,1$ мкм и износостойкости, сопоставимой с эмалью, за счёт равномерного распределения наночастиц 5–20 нм.
- е) Полного отсутствия необходимости полировки, поскольку материал обладает самополирующимися свойствами.

№79. Укажите согласно современным клиническим рекомендациям FDI & AAE 2025–2026, материалы нового поколения с доказанной биоактивностью и ион-релизом показаны в первую очередь:

- а) Только в эстетических реставрациях фронтальной группы для достижения идеальной цветопередачи.
- б) Исключительно как временные пломбы, поскольку долгосрочная биоактивность может нарушить баланс микрофлоры.
- в) В минимально-инвазивной стоматологии у пациентов высокого кариес-риска, включая глубокие полости после селективного удаления кариеса и пришеечные дефекты.
- д) Только в сочетании с тотальным протравливанием для максимальной активации ионного релиза.
- е) При отсутствии соматических заболеваний, так как системные факторы снижают эффективность реминерализации.

№80. Установите по данным мета-анализов 2023–2026 гг., наиболее значимым преимуществом bulk-fill композитов нового поколения по сравнению с традиционными инкрементальными композитами является:

- а) Худшая адаптация к стенкам полости и повышенный риск микроподтеканий при объёмном внесении.
- б) Снижение С-фактора и полимеризационного стресса при объёмном внесении слоем 4–5 мм за счёт модифицированной вязкоупругой матрицы и современных фотоинициаторов.
- в) Увеличение времени полимеризации до 60 секунд на каждый слой для достижения максимальной степени конверсии.
- д) Полное отсутствие необходимости в адгезивной системе даже при работе с дентином средней глубины.
- е) Снижение механической прочности на 30 % по сравнению с классическими композитами, что компенсируется повышенной биоактивностью.

№81. Укажите для жевательных зубов в технике «cusp-by-cusp buildup» (побугорная реставрация) финальная полировка фиссур проводится:

- а) Агрессивными алмазными борами средней зернистости для создания чёткой анатомии и максимальной ретенции окклюзионных контактов.
- б) Силиконовыми полировочными щётками и алмазной пастой минимальной абразивности для сохранения глубины фиссур и предотвращения «заливания» анатомии.
- в) Только резиновыми чашечками высокой абразивности, поскольку они лучше удаляют избытки материала в труднодоступных фиссурах.
- д) Без полировки фиссур вообще, так как в технике cusp-by-cusp приоритет отдаётся только функциональным гребням, а фиссуры должны оставаться шероховатыми для лучшей ретенции пищи.
- е) Пескоструйной обработкой с 50 мкм частицами для создания микротекстуры и улучшения адгезии к пищевому налёту.

№82. Выберите согласно современным рекомендациям, поверхностный слой реставрации фронтальных зубов должен иметь толщину эмалевой массы:

- а) 1,5–2 мм, чтобы обеспечить достаточную прочность и маскировку дентина при высокой прозрачности материала.
- б) 0,3–0,6 мм для оптимальной светопроводимости и естественного вида.
- в) Полное отсутствие эмалевого слоя, поскольку современные опакующие дентиновые массы полностью заменяют необходимость в эмалевом покрытии.
- д) 2 мм и более, так как толстый эмалевый слой гарантирует долгосрочную цветостабильность и защиту от стирания.
- е) Толщину, равную толщине естественной эмали пациента, измеренную с помощью цифрового калипера перед препарированием.

№83. Укажите одним из главных недостатков полировки реставраций жевательных зубов одноэтапными системами является:

- а) Сверхвысокий блеск, который приводит к чрезмерному скольжению пищи и нарушению окклюзионных контактов.

б) Более низкий уровень достигаемого Ra и быстрый возврат шероховатости под окклюзионной нагрузкой по сравнению с многоэтапными системами.

с) Отсутствие износа материала, что делает реставрацию слишком долговечной и приводит к перегрузке антагонистов.

д) Запрет применения на нанокompозитах из-за риска перегрева и растрескивания поверхности.

е) Увеличение времени процедуры в 2–3 раза по сравнению с многоэтапными системами.

№84. Отметьте в художественной реставрации для имитации «мамелонов» на фронтальных зубах используется:

а) Только шлифовка алмазными борами высокой абразивности для создания естественных вертикальных борозд.

б) Нанесение белого/опалового модификатора в виде вертикальных линий с последующей лёгкой полировкой для естественного сглаживания.

с) Полное отсутствие модификаторов, поскольку мамелонеры формируются исключительно за счёт толщины эмалевого слоя.

д) Только прозрачный слой без каких-либо опаловых включений, чтобы сохранить максимальную транслюценцию.

е) Агрессивная полировка после нанесения, чтобы полностью сгладить поверхность и добиться зеркального блеска.

№85. Выделите, при полировке межзубных контактов в реставрациях фронтальных зубов оптимальным инструментом являются:

а) Только карбидные боры средней зернистости для быстрого формирования контактного пункта.

б) Полоски с градицией абразива (Sof-Lex strips или Super-Snap strips) с последовательным переходом от средней к ультратонкой зернистости.

с) Алмазные пасты без использования полосок, поскольку они лучше проникают в межзубное пространство.

д) Отсутствие обработки контактов вообще, так как современные матричные системы обеспечивают идеальный контакт сразу после полимеризации.

е) Пескоструйная обработка с 27 мкм частицами для создания микрошероховатости и лучшей ретенции.

№86. Укажите согласно протоколам 2026 года, финальным этапом полировки любой художественной реставрации (фронтальной или жевательной) должно быть:

а) Применение 40-мкм алмазного бора для окончательной контурировки и создания микротекстуры, имитирующей естественную эмаль.

б) Нанесение алмазной полировочной пасты 0,5 мкм или силиконовой щётки с водой для удаления остаточных абразивных частиц и достижения максимального глянца.

с) Сухая полировка резиновыми чашечками высокой абразивности для предотвращения перегрева и сохранения естественной шероховатости.

д) Пескоструйная обработка с 50 мкм частицами для создания оптимальной микропористости и лучшей адгезии к пищевому налёту.

е) Отказ от финальной полировки, поскольку современные материалы обладают самополирующимся эффектом после 20-секундной полимеризации.

№87. Установите влияние метода полировки на долгосрочную цветостабильность композитной реставрации фронтальных зубов проявляется в том, что:

а) Грубая полировка улучшает стабильность, так как создаёт микропоры, которые лучше удерживают красители и пигменты.

б) Достижение минимального Ra снижает адсорбцию красителей и пигментов за счёт уменьшения микропор и повышения гладкости поверхности.

с) Полировку не влияет на цветостабильность, поскольку современные композиты имеют полностью стабильные пигменты, не подверженные внешним воздействиям.

д) Только одноэтапные системы улучшают цветостабильность за счёт специального покрытия, которое предотвращает проникновение красителей.

е) Увеличивает пигментацию, поскольку полировочные пасты содержат красящие компоненты, которые проникают в материал.

№88. Определите художественная реставрация жевательных зубов требует обязательного воспроизведения:

а) Только гладкой поверхности без анатомии, поскольку окклюзионные контакты формируются только после окончательной шлифовки.

б) Функциональной окклюзионной морфологии (триангулярные гребни, маргинальные гребни, центральная фиссура, ямки) с последующей шлифовкой под контролем артикуляционной бумаги 12–40 мкм.

с) Максимальной прозрачности, чтобы реставрация сливалась с естественными тканями зуба и не нарушала эстетику улыбки.

д) Отсутствия контактов в центральной фиссуре для предотвращения пищевого застревания.

е) Только эстетических параметров, поскольку функциональная анатомия вторична и корректируется ортодонтически.

№89. Укажите ключевым фактором, влияющим на выбор метода полировки реставраций фронтальных зубов, является:

а) Только стоимость материала и доступность полировочных инструментов в конкретном лечебном учреждении.

б) Тип композита (нано-гибрид vs микро-гибрид), оптические требования и необходимость имитации естественной эмалевой текстуры.

с) Отсутствие влияния на эстетику, поскольку полировка влияет только на функциональные характеристики реставрации.

д) Запрет многоэтапных систем в пользу одноэтапных, так как они значительно сокращают время приёма.

е) Только скорость процедуры, поскольку современные материалы не требуют тщательной полировки для достижения клинического результата.

№90. Укажите в протоколах полировки (по данным исследований 2025 г.) после использования алмазных боров зернистостью 8–16 мкм следующим этапом обязательно является:

а) Немедленная алмазная паста 3 мкм для быстрого достижения зеркального блеска.

б) Переход на среднеабразивные диски/полиры (20–40 мкм) с обильным охлаждением для удаления субповерхностного повреждённого слоя.

с) Прямое применение резиновых чашечками высокой абразивности для экономии времени.

д) Пескоструйная обработка с 27 мкм частицами для создания оптимальной микропористости.

е) Отказ от дальнейшей обработки, поскольку после боров 8–16 мкм поверхность уже считается клинически приемлемой.

№91. Выберите эффект «over-polishing» при художественной реставрации фронтальных зубов приводит к:

а) Улучшению естественной текстуры и повышению value, что делает реставрацию более естественной и долговечной.

б) Потере микротекстуры (перикиматии, лобулярности), снижению value и нарушению естественной светопроводимости.

с) Повышению адгезии бактерий и ускорению пигментации за счёт создания оптимальной микрошероховатости.

д) Увеличению толщины реставрации и улучшению краевого прилегания за счёт дополнительного уплотнения материала.

е) Снижению полимеризационного стресса и повышению прочности реставрации в пришеечной зоне.

№92. Определите согласно протоколам полировки (по данным исследований 2025 г.) после использования алмазных боров зернистостью 8–16 мкм следующим этапом обязательно является:

а) Немедленная алмазная паста 3 мкм для быстрого достижения зеркального блеска и экономии времени приёма.

б) Переход на среднеабразивные диски/полиры (20–40 мкм) с обильным охлаждением для удаления субповерхностного повреждённого слоя.

с) Прямое применение резиновых чашечек высокой абразивности для максимального сглаживания поверхности.

д) Пескоструйная обработка с 27 мкм частицами для создания оптимальной микропористости и лучшей адгезии.

е) Отказ от дальнейшей обработки, поскольку после боров 8–16 мкм поверхность уже считается клинически идеальной.

№93. Укажите: при реставрации фронтальных зубов эффект «опалесценции» достигается за счёт:

а) Толстого опакового слоя, который полностью маскирует дентин и создаёт глубину цвета.

б) Нанесения тонкого слоя опалесцентной массы (0,1–0,3 мм) на режущий край поверх эмалевого оттенка.

с) Полного отсутствия прозрачных масс, поскольку опалесценция достигается только за счёт правильного выбора дентинового оттенка.

д) Использования только дентиновых масс без эмалевого покрытия для максимальной естественности.
е) Снижения полировки, так как чрезмерная полировка уничтожает оптические свойства материала.

№94. Укажите: для жевательных зубов в технике «cusp-by-cusp buildup» (побугорная реставрация) финальная полировка фиссур проводится:

а) Агрессивными алмазными борами средней зернистости для создания чёткой анатомии и максимальной ретенции окклюзионных контактов.

б) Силиконовыми полировочными щётками и алмазной пастой минимальной абразивности для сохранения глубины фиссур и предотвращения «заливания» анатомии.

с) Только резиновыми чашечками высокой абразивности, поскольку они лучше удаляют избытки материала в труднодоступных фиссурах.

д) Без полировки фиссур вообще, так как в технике cusp-by-cusp приоритет отдаётся только функциональным гребням.

е) Пескоструйной обработкой с 50 мкм частицами для создания микротекстуры и улучшения адгезии к пищевому налёту.

№95. Выберите: при полировке межзубных контактов в реставрациях фронтальных зубов оптимальным инструментом являются:

а) Только карбидные боры средней зернистости для быстрого формирования контактного пункта.

б) Полоски с градицией абразива (Sof-Lex strips или Super-Snap strips) с последовательным переходом от средней к ультратонкой зернистости.

с) Алмазные пасты без использования полосок, поскольку они лучше проникают в межзубное пространство.

д) Отсутствие обработки контактов вообще, так как современные матричные системы обеспечивают идеальный контакт сразу после полимеризации.

е) Пескоструйная обработка с 27 мкм частицами для создания микрошероховатости и лучшей ретенции.

№96. Укажите: согласно протоколам 2026 года, финальным этапом полировки любой художественной реставрации (фронтальной или жевательной) должно быть:

а) Применение 40-мкм алмазного бора для окончательной контурировки и создания микротекстуры, имитирующей естественную эмаль, что повышает долговечность реставрации.

б) Нанесение алмазной полировочной пасты 0,5 мкм или силиконовой щёточки с водой для удаления остаточных абразивных частиц и достижения максимального глянца.

с) Сухая полировка резиновыми чашечками высокой абразивности для предотвращения перегрева и сохранения естественной шероховатости поверхности.

д) Пескоструйная обработка с 50 мкм частицами для создания оптимальной микропористости и лучшей адгезии к пищевому налёту.

е) Отказ от финальной полировки, поскольку современные материалы обладают самополирующимся эффектом после 20-секундной полимеризации.

№97. Определите: влияние метода полировки на долгосрочную цветостабильность композитной реставрации фронтальных зубов проявляется в том, что:

а) Грубая полировка улучшает стабильность, так как создаёт микропоры, которые лучше удерживают красители и пигменты.

б) Достижение минимального Ra снижает адсорбцию красителей и пигментов за счёт уменьшения микропор и повышения гладкости поверхности.

с) Полировка не влияет на цветостабильность, поскольку современные композиты имеют полностью стабильные пигменты, не подверженные внешним воздействиям.

д) Только одноэтапные системы улучшают цветостабильность за счёт специального покрытия, которое предотвращает проникновение красителей.

е) Увеличивает пигментацию, поскольку полировочные пасты содержат красящие компоненты, которые проникают в материал.

№98. Выберите: художественная реставрация жевательных зубов требует обязательного воспроизведения:

а) Только гладкой поверхности без анатомии, поскольку окклюзионные контакты формируются только после окончательной шлифовки.

б) Функциональной окклюзионной морфологии (триангулярные гребни, маргинальные гребни, центральная фиссура, ямки) с последующей шлифовкой под контролем артикуляционной бумаги 12–40 мкм.

с) Максимальной прозрачности, чтобы реставрация сливалась с естественными тканями зуба и не нарушала эстетику улыбки.

д) Отсутствия контактов в центральной фиссуре для предотвращения пищевого застревания.

е) Только эстетических параметров, поскольку функциональная анатомия вторична и корректируется ортодонтически.

№99. Укажите: ключевым фактором, влияющим на выбор метода полировки реставраций фронтальных зубов, является:

а) Только стоимость материала и доступность полировочных инструментов в конкретном лечебном учреждении.

б) Тип композита (нано-гибрид vs микро-гибрид), оптические требования и необходимость имитации естественной эмалевой текстуры.

в) Отсутствие влияния на эстетику, поскольку полировка влияет только на функциональные характеристики реставрации.

г) Запрет многоэтапных систем в пользу одноэтапных, так как они значительно сокращают время приёма.

е) Только скорость процедуры, поскольку современные материалы не требуют тщательной полировки для достижения клинического результата.

№100. Выберите: в протоколах полировки (по данным исследований 2025 г.) после использования алмазных боров зернистостью 8–16 мкм следующим этапом обязательно является:

а) Немедленная алмазная паста 3 мкм для быстрого достижения зеркального блеска и экономии времени приёма.

б) Переход на среднеабразивные диски/полиры (20–40 мкм) с обильным охлаждением для удаления субповерхностного повреждённого слоя.

в) Прямое применение резиновых чашечек высокой абразивности для максимального сглаживания поверхности.

г) Пескоструйная обработка с 27 мкм частицами для создания оптимальной микропористости.

е) Отказ от дальнейшей обработки, поскольку после боров 8–16 мкм поверхность уже считается клинически идеальной.

№101. Выберите: при полировке реставраций фронтальных зубов эффект «over-polishing» (избыточное полирование) приводит к:

а) Улучшению естественной текстуры и повышению value, что делает реставрацию более естественной и долговечной в условиях высокой окклюзионной нагрузки.

б) Потере микротекстуры (перикиматии, лобулярности), снижению value и нарушению естественной светопроводимости.

в) Повышению адгезии бактерий и ускорению пигментации за счёт создания оптимальной микрошероховатости поверхности.

г) Увеличению толщины реставрации и улучшению краевого прилегания за счёт дополнительного уплотнения материала.

е) Снижению полимеризационного стресса и повышению прочности реставрации в пришеечной зоне.

№102. Укажите: согласно протоколам полировки (по данным исследований 2025 г.) после использования алмазных боров зернистостью 8–16 мкм следующим этапом обязательно является:

а) Немедленная алмазная паста 3 мкм для быстрого достижения зеркального блеска и экономии времени приёма.

б) Переход на среднеабразивные диски/полиры (20–40 мкм) с обильным охлаждением для удаления субповерхностного повреждённого слоя.

в) Прямое применение резиновых чашечек высокой абразивности для максимального сглаживания поверхности.

г) Пескоструйная обработка с 27 мкм частицами для создания оптимальной микропористости.

е) Отказ от дальнейшей обработки, поскольку после боров 8–16 мкм поверхность уже считается клинически идеальной.

№103. Выберите: при реставрации фронтальных зубов эффект «опалесценции» достигается за счёт:

а) Толстого опакового слоя, который полностью маскирует дентин и создаёт глубину цвета.

б) Нанесения тонкого слоя опалесцентной массы (0,1–0,3 мм) на режущий край поверх эмалевого оттенка.

в) Полного отсутствия прозрачных масс, поскольку опалесценция достигается только за счёт правильного выбора дентинового оттенка.

г) Использования только дентиновых масс без эмалевого покрытия для максимальной естественности.

е) Снижения полировки, так как чрезмерная полировка уничтожает оптические свойства материала.

№104. Определите: для жевательных зубов в технике «cusp-by-cusp buildup» (побугорная реставрация) финальная полировка фиссур проводится:

а) Агрессивными алмазными борами средней зернистости для создания чёткой анатомии и максимальной ретенции окклюзионных контактов.

б) Силиконовыми полировочными щётками и алмазной пастой минимальной абразивности для сохранения глубины фиссур и предотвращения «заливания» анатомии.

с) Только резиновыми чашечками высокой абразивности, поскольку они лучше удаляют избытки материала в труднодоступных фиссурах.

д) Без полировки фиссур вообще, так как в технике cusp-by-cusp приоритет отдаётся только функциональным гребням.

е) Пескоструйной обработкой с 50 мкм частицами для создания микротекстуры и улучшения адгезии к пищевому налёту.

№105. Найдите: при полировке межзубных контактов в реставрациях фронтальных зубов оптимальным инструментом являются:

а) Только карбидные боры средней зернистости для быстрого формирования контактного пункта.

б) Полоски с градацией абразива (Sof-Lex strips или Super-Snap strips) с последовательным переходом от средней к ультратонкой зернистости.

с) Алмазные пасты без использования полосок, поскольку они лучше проникают в межзубное пространство.

д) Отсутствие обработки контактов вообще, так как современные матричные системы обеспечивают идеальный контакт сразу после полимеризации.

е) Пескоструйная обработка с 27 мкм частицами для создания микрошероховатости и лучшей ретенции.

№106. Укажите применение 38% диаминфторида серебра (SDF) в современной терапии кариеса показано:

а) Исключительно при лечении начальных форм кариеса в стадии пятна для реминерализации эмали.

б) Для консервативной остановки кариозного процесса у пациентов групп риска (дети, пожилые) с доказанной клинической эффективностью.

с) В качестве постоянного реставрационного материала для восстановления анатомической формы коронки зуба.

д) Только в тех клинических случаях, когда предварительно проведено полное иссечение всех поражённых тканей.

е) В качестве профилактического герметика для изоляции фиссур интактных моляров у подростков.

№107. Укажите принцип «зубосохраняющего оперативного вмешательства» при умеренных поражениях (ICDAS 4) предусматривает:

а) Формирование полости с созданием обширных ретенционных зон согласно классическим принципам Блэка.

б) Создание минимального доступа с защитой периферических структур зуба и использованием биоактивных составов.

с) Тактику динамического наблюдения за состоянием твёрдых тканей без проведения активных лечебных манипуляций.

д) Проведение прямой реставрации с использованием серебряной амальгамы для обеспечения долговечности пломбы.

е) Изготовление и фиксацию искусственной ортопедической коронки для предотвращения дальнейшего разрушения.

№108. Отметьте наибольшая эффективность реминерализации начальных кариозных поражений достигается при:

а) Регулярном использовании стандартной фторсодержащей зубной пасты в концентрации 1450 ppm при домашнем уходе.

б) Комплексном воздействии препаратов CPP-ACP, фтор-лака и полимерной инфильтрации с учетом кислотно-щелочного баланса.

с) Локальном применении раствора диаминфторида серебра для глубокого фторирования поражённых участков эмали.

д) Использовании лазерного излучения определенных длин волн без дополнительного введения препаратов фтора.

е) Применении изолированных аппликаций синтетического гидроксиапатита для восстановления кристаллической решетки.

№109. Укажите признаками активного кариозного поражения по ICCMSTTM являются:

а) Плотная, гладкая и блестящая поверхность участка поражения, свидетельствующая о стабилизации процесса.

б) Матовая шероховатая поверхность эмали с признаками деминерализации и размягчением краев дефекта.

с) Наличие плотного пигментированного дентина темно-коричневого цвета при зондировании дна полости.

д) Отсутствие визуально определяемых изменений цвета или прозрачности тканей на поверхности исследуемого зуба.

е) Достижение полной минерализации очага поражения в результате проведенной ранее консервативной терапии.

№110. Отметьте современный подход к глубокому кариесу с высоким риском пульпита включает:

а) Полное иссечение всех деминерализованных тканей до появления «дентинного крика» во избежание рецидива.

б) Выборочное удаление пораженного дентина с последующей герметизацией полости и динамическим наблюдением.

с) Обязательное проведение методики отсроченного двухэтапного препарирования с временным пломбированием.

д) Проведение частичной или полной пульпотомии для удаления инфицированных участков коронковой пульпы.

е) Удаление зуба как радикальный метод исключения риска развития острых гнойных осложнений в периодонте.

№111. Укажите согласно CariesCare International и рекомендациям ВСФ 2026 года, Hall Technique (герметизация преформированной коронкой) при кариесе молочных зубов наиболее обоснована в следующих случаях:

а) Исключительно при выявлении начальных дефектов эмали без образования сформированной кариозной полости.

б) При активных глубоких поражениях у детей с высокой интенсивностью кариеса и отсутствии симптомов патологии пульпы.

с) Для восстановления жевательной функции постоянных моляров у взрослого населения при значительных дефектах.

д) Только после завершения этапа полного инструментального удаления кариозных тканей под местной анестезией.

е) В клинических ситуациях, характеризующихся низким индивидуальным риском развития кариеса у пациента.

№112. Выберите ключевым биомаркером прогрессирования кариеса в современных протоколах является:

а) Субъективная визуальная оценка изменения цветовых характеристик пораженного участка твердых тканей зуба.

б) Совокупный анализ активности процесса в сочетании с цифровым мониторингом методами лазерной или световой флуоресценции.

с) Статистический индекс интенсивности кариеса (КПУ), отражающий сумму кариозных, пломбированных и удаленных зубов.

д) Изолированное использование интерпроксимальной рентгенографии (bite-wing) для поиска скрытых полостей.

е) Определение плотности дентина и эмали путем проведения тактильной пробы с помощью острого стоматологического зонда.

№113. Найдите, самым эффективным сочетанным методом остановки начального кариеса эмали (ICDAS 2) в настоящее время считается:

а) Регулярное использование стандартной фторсодержащей зубной пасты в рамках ежедневной гигиены полости рта.

б) Метод полимерной инфильтрации в сочетании с курсовым применением фтор-лака и препаратов на основе CPP-ACP.

с) Однократное нанесение раствора диаминфторида серебра для глубокой минерализации пораженного участка эмали.

д) Проведение процедуры лазерной флюоропатии для изменения структуры кристаллической решетки гидроксиапатита.

е) Тщательная профессиональная полировка поверхности зуба для удаления налета и сглаживания микродефектов.

№114. Укажите в системе CariesCare International этап «Do» (Выполнение) включает:

- а) Исключительно проведение классических оперативных манипуляций по препарированию и пломбированию зубов.
- б) Реализацию индивидуального плана лечения: коррекцию факторов риска, неоперативную терапию и щадящее препарирование.
- с) Проведение только прямой или непрямой реставрации твердых тканей зуба с использованием современных композитов.
- д) Радикальное удаление всех зубов, имеющих кариозные поражения любой степени выраженности, для санации полости рта.
- е) Тактику пассивного наблюдения за имеющимися поражениями без применения каких-либо активных лечебных мер.

№115. Определите при диагностике вторичного кариеса под реставрацией наиболее точным методом 2026 года является:

- а) Традиционный визуальный осмотр границ реставрации с использованием стоматологического зеркала при ярком освещении.
- б) Сочетанное применение инфракрасной трансиллюминации, интерпроксимальной рентгенографии и цифровой флуоресценции.
- с) Использование метода тактильного зондирования краев пломбы для обнаружения микродефектов и размягчения тканей.
- д) Проведение компьютерной томографии без использования дополнительных контрастирующих веществ в области исследования.
- е) Проведение электроодонтодиагностики для определения порога чувствительности пульпы зуба в ответ на раздражитель.

№116. Укажите селективное удаление кариеса до мягкого дентина рекомендуется:

- а) Исключительно при лечении временных зубов у детей младшего возраста для сокращения времени приема.
- б) В глубоких полостях постоянных зубов с целью сохранения витальности пульпы и снижения риска экспозиции.
- с) При диагностике поверхностных кариозных поражений эмали, не затрагивающих пограничные слои дентина.
- д) Только после завершения этапа полной некрэктомии и формирования полости по классическим канонам.
- е) Данная методика признана неэффективной и официально запрещена к применению в современной клинике.

№117. Определите основным преимуществом системы 4D CariesCare International перед традиционными подходами является:

- а) Значительное увеличение объема выполняемых прямых реставраций и инвазивных вмешательств на приеме.
- б) Переход к риск-ориентированному, персонализированному и превентивному ведению пациента с акцентом на сохранение зубов.
- с) Максимальное упрощение процесса ведения медицинской документации и заполнения амбулаторных карт.
- д) Полный отказ от использования рентгенологических методов исследования в пользу визуального осмотра.
- е) Существенное снижение себестоимости материалов и общих затрат клиники на проведение лечения кариеса.

№118. Укажите, согласно современным доказательным данным, наиболее перспективным материалом для герметизации после селективного удаления кариеса считается:

- а) Традиционный самоотверждаемый стеклоиономерный цемент без дополнительных модифицирующих добавок.
- б) Биоактивные материалы с ионным релизом или современные высоковязкие стеклоиономерные системы.
- с) Использование серебряной амальгамы для обеспечения максимальной механической прочности реставрации.
- д) Применение исключительно светоотверждаемых композитов без предварительного использования лечебных прокладок.
- е) Наложение временной пломбировочной массы сроком на 6 месяцев для проверки реакции пульпарных тканей.

№119. Пациент 7 лет, высокий кариес-риск, множественные поражения на молочных молярах (ICDAS 5–6), без признаков пульпита. Родители требуют «обычных пломб». Выберите, какой современный подход будет наиболее правильным?

а) Проведение тотальной некрэктомии под местной анестезией с последующей постановкой стандартных композитных реставраций на все пораженные зубы.

б) Установка преформированных коронок по Hall Technique на сложные дефекты в сочетании с SDF-терапией и программой контроля факторов риска.

в) Использование тактики динамического наблюдения до момента физиологической смены зубов без применения инвазивных методик лечения.

г) Однократное серебрение всех кариозных полостей без использования герметизирующих конструкций и коррекции домашней гигиены.

д) Удаление наиболее разрушенных молочных зубов с целью предотвращения инфицирования зачатков постоянных зубов и развития периодонтита.

№120. У пациента 28 лет глубокая полость на зубе 46 (ICDAS 6), тонкий слой дентина над пульпой (1 мм). Жалоб нет. Укажите, какое лечение по современным протоколам?

а) Полное удаление всего деминерализованного дентина с последующим наложением кальцийсодержащей прокладки и постоянной пломбы.

б) Частичное удаление пораженного дентина до мягкого слоя, герметизация полости биоактивным составом и последующий клинический мониторинг.

в) Профилактическое проведение витальной пульпотомии и заполнение коронковой части зуба стеклоиономерным цементом высокой вязкости.

г) Проведение традиционного эндодонтического лечения с последующим восстановлением зуба с помощью ортопедической коронки.

д) Отсроченное пломбирование: полное удаление кариеса через 6 месяцев после временного закрытия полости пастой на основе гидроксида кальция.

№121. У пациента 55 лет с выраженной ксеростомией (приём гипотензивных препаратов и антидепрессантов) и высоким кариес-риском выявлены множественные начальные проксимальные поражения (ICDAS 2). Определите какой наиболее эффективный и современный комплексный протокол лечения рекомендуется в 2026 году?

а) Проведение немедленного оперативного лечения всех выявленных участков деминерализации с использованием светоотверждаемых композитов.

б) Сочетание полимерной инфильтрации Ison, регулярной фтор-профилактики и терапии CPP-ACP на фоне строгого контроля риска по системе 4D.

в) Однократная аппликация 38% раствора диаминфторида серебра на все контактные поверхности зубов без дополнительной поддерживающей терапии.

г) Выжидательная тактика с проведением контрольных осмотров один раз в год для оценки стабильности выявленных кариозных поражений.

д) Формирование классических полостей второго класса по Блэку и их последующее пломбирование серебряной амальгамой для долговечности.

№122. Через 18 месяцев после реставрации зуба 26 нано-гибридным композитом диагностирован вторичный кариес на дне и стенках полости. Укажите что, согласно современным данным 2025–2026 гг., наиболее вероятно стало главной причиной прогрессирования?

а) Недостаточный уровень индивидуальной гигиены полости рта и пренебрежение правилами использования флосса.

б) Чрезмерная некрэктомия в сочетании с нарушением герметичности реставрации на фоне высокого кариес-риска.

в) Использование композитного материала с низкими прочностными характеристиками и высокой полимеризационной усадкой.

г) Отсутствие предварительной диагностической рентгенографии для оценки глубины поражения перед началом лечения.

д) Наличие у пациента специфической аллергической реакции замедленного типа на остаточные мономеры адгезивной системы.

№123. Пациентка 68 лет, крайне высокий кариес-риск, множественные активные корневые кариесы. Выберите метод остановки прогрессирования считается наиболее эффективным, безопасным и рекомендуемым в настоящее время?

а) Радикальное оперативное вмешательство с препарированием всех очагов деструкции и их замещением композитами.

б) Комплексная терапия: периодические аппликации SDF и фтор-лака в сочетании с домашним использованием CPP-ACP.

с) Проведение сеансов профессиональной гигиены полости рта один раз в квартал для удаления наддесневых отложений.

д) Полное восстановление зубных рядов несъемными ортопедическими конструкциями с предварительным депульпированием.

е) Плановое удаление всех зубов с признаками поражения корня и последующее изготовление съемных протезов.

№124. У ребёнка 9 лет на первом постоянном моляре 16 диагностирован глубокий кариес (ICDAS 5) с высоким риском экспозиции пульпы. Укажите, какое вмешательство наиболее предпочтительно по современным протоколам минимально-инвазивной стоматологии?

а) Проведение полной инструментальной обработки полости с риском случайного сообщения с камерой пульпы.

б) Выборочное иссечение тканей до мягкого дентина с герметизацией биоактивным составом или фиксацией коронки.

с) Проведение витальной или девитальной пульпотомии с последующим восстановлением коронковой части зуба.

д) Тактика пассивного динамического наблюдения за состоянием зуба без выполнения активных манипуляций.

е) Немедленная фиксация преформированной стальной коронки без предварительного удаления размягченных тканей.

№125. Пациент 42 года, средний кариес-риск, обнаружено поражение средней глубины на проксимальной поверхности зуба 25 (ICDAS 3). Определите, какое лечение в наибольшей степени соответствует современному минимально-инвазивному подходу?

а) Классическое препарирование полости II класса по Блэку с созданием широкого доступа и ретенционных пунктов.

б) Использование методики инфильтрации смолой или формирование микрополости с применением биоактивных масс.

с) Однократное нанесение 38% раствора диаминофторида серебра для химической остановки процесса деминерализации.

д) Проведение курса профессиональной фтор-терапии в условиях клиники без выполнения оперативного вмешательства.

е) Полный отказ от активных лечебных манипуляций и перевод пациента в группу динамического наблюдения.

№126. Через 6 месяцев после селективного удаления кариеса и герметизации биоактивным материалом на контрольном bite-wing снимке отмечается увеличение зоны рентгенопрозрачности. Клинически зуб полностью бессимптомный. Укажите правильные действия врача?

а) Проведение немедленной полной некрэктомии с заменой старой реставрации на новую композитную конструкцию.

б) Сопоставление данных рентгенографии с клинической картиной и назначение повторного контроля через 3 месяца.

с) Экстренное вскрытие полости зуба и выполнение пульпотомии для предотвращения развития острого периодонтита.

д) Рекомендация пациенту удаления зуба в связи с неблагоприятным прогнозом и риском развития очага инфекции.

е) Игнорирование выявленных рентгенологических изменений при условии отсутствия жалоб со стороны пациента.

№127. Определите у пациента высокого кариес-риска с множественными некавитативными поражениями (ICDAS 2) на гладких и проксимальных поверхностях наиболее эффективная долгосрочная стратегия контроля кариеса включает:

а) Проведение ежегодного профилактического осмотра для оценки состояния твердых тканей зубов и реставраций.

б) Реализацию интенсивного протокола 4D с частыми визитами и сочетанным применением фторидов и инфильтрантов.

с) Предоставление стандартных письменных рекомендаций по улучшению качества индивидуальной гигиены полости рта.

д) Проведение процедуры серебрения всех выявленных участков деминерализации эмали без использования адгезивов.

е) Оперативное вмешательство и замещение всех измененных в цвете поверхностей зубов световыми композитами.

№128. Укажите, согласно современной классификации некариозных поражений зубов (2025–2026), главное отличие эрозии от абфракции заключается в следующем:

а) Эрозия — химическое растворение тканей кислотами небактериального генеза, абфракция — следствие биомеханического стресса и окклюзионных нагрузок.

б) Эрозия всегда характеризуется выраженной гиперестезией тканей, тогда как абфракционные дефекты развиваются абсолютно бессимптомно.

в) Абфракция локализуется строго в пришеечной области, в то время как эрозивные поражения могут затрагивать любую анатомическую поверхность зуба.

г) Эрозия подлежит исключительно консервативному лечению методом реминерализации, а абфракция требует обязательного оперативного вмешательства.

д) Абфракция классифицируется как специфическая форма кариозного процесса, возникающая на фоне нарушения микрофлоры полости рта.

№129. Укажите основным этиологическим фактором развития абфракционных поражений (клиновидных дефектов) в пришеечной области является:

а) Систематическое воздействие экзогенных или эндогенных кислот, приводящее к деминерализации поверхностных слоев эмали.

б) Наличие окклюзионной травмы или бруксизма, вызывающих концентрацию напряжений и микротрещины в области шейки зуба.

в) Нарушение методики чистки зубов с использованием жестких щеток и абразивных паст, приводящее к механическому износу.

г) Врожденная структурная неполноценность эмали и дентина, обусловленная генетическими факторами развития тканей.

д) Хроническое воспаление тканей пародонта, приводящее к рецессии десны и последующему разрушению цемента корня.

№130. Укажите, согласно современным рекомендациям 2025–2026 годов, Основной индекс эрозивного износа (BEWE) при оценке 2 балла в одном секстанте означает:

а) Состояние тканей в пределах физиологической нормы без видимых признаков эрозивного разрушения поверхностей.

б) Наличие начальных деструктивных изменений эмали с потерей поверхностного слоя без вовлечения подлежащего дентина.

в) Масштабную потерю твердых тканей зуба с обнажением дентина, занимающую более половины площади исследуемой поверхности.

г) Критическую степень деструкции коронковой части зуба, требующую немедленного ортопедического восстановления.

д) Появление повышенной чувствительности (гиперестезии) к температурным раздражителям при сохранении целостности эмали.

№131. Определите при диагностике и лечении некариозных поражений ключевым современным принципом является:

а) Создание обширных зон ретенции путем иссечения здоровых тканей для обеспечения механической устойчивости пломбы.

б) Реализация этиотропного подхода — обязательное выявление и устранение причинного фактора до начала этапа реставрации.

в) Проведение эстетической коррекции дефекта с помощью современных композитных материалов без учета этиологии процесса.

г) Использование исключительно несъемных ортопедических конструкций для перекрытия зон поражения и защиты пульпы.

д) Полный отказ от оперативного лечения в пользу длительных курсов реминерализующей терапии препаратами кальция.

№132. Выберите для лечения выраженной гиперестезии дентина при некариозных поражениях наиболее эффективным в долгосрочной перспективе считается:

а) Однократное локальное нанесение фторсодержащего лака на чувствительные участки в рамках профессиональной гигиены.

б) Обтурация дентинных канальцев нано-гидрок시아патитом или фторидом олова в сочетании с лазерной стимуляцией тканей.

с) Немедленное перекрытие дефекта композитной реставрацией без проведения предварительной десенсиtaiзерной обработки.

д) Применение современных десенсиtaiзеров на основе глутарового альдегида в качестве единственного и основного метода лечения.

е) Депульпирование зуба и проведение полноценного эндодонтического лечения при неэффективности консервативных мер.

№133. Укажите абфракционные поражения чаще всего возникают в результате:

а) Систематического воздействия агрессивных химических соединений и кислот на твердые ткани зуба.

б) Циклической окклюзионной нагрузки, вызывающей концентрацию напряжений и микротрещины в области шейки.

с) Использования неправильной техники чистки зубов с применением щеток повышенной жесткости.

д) Формирования глубоких пародонтальных карманов и хронического воспаления в области маргинальной десны.

е) Наличия генетически обусловленной структурной неполноценности поверхностных слоев эмали и дентина.

№134. Отметьте при сочетанных некариозных поражениях (эрозия + абфракция + абразия) последовательность лечения должна быть:

а) Проведение немедленной эстетической реставрации всех выявленных дефектов современными композитами.

б) Устранение этиологии, купирование гиперестезии, реминерализация и последующая минимально-инвазивная терапия.

с) Использование методов ортопедической коррекции зубных рядов с помощью коронок или виниров.

д) Однократное нанесение раствора диаминфторида серебра для остановки процессов деструкции тканей.

е) Выбор тактики пассивного динамического наблюдения за состоянием зубов без активного вмешательства.

№135. Укажите современным материалом выбора для реставрации пришеечных абфракционных дефектов является:

а) Традиционный макронаполненный композитный материал с высокими показателями механической прочности.

б) Низкомодульный нано-гибридный композит или гиомер, обладающий модулем эластичности, близким к дентину.

с) Классический стеклоиономерный цемент химического отверждения для обеспечения химической адгезии.

д) Серебряная амальгама, обеспечивающая долговечность и стабильность реставрации в условиях влажной среды.

е) Жидкотекучий композит без использования перекрывающего слоя пакуемого материала для быстроты манипуляции.

№136. Укажите основным отличием эрозии от абразии зубов является:

а) Специфическая локализация дефектов исключительно в области режущих краев и бугров жевательных зубов.

б) Химическое растворение тканей кислотами (эрозия) против механического износа под действием внешних факторов (абразия).

с) Обязательное наличие выраженного болевого синдрома и гиперестезии при термических и химических пробах.

д) Возрастная категория пациента, так как абразия встречается преимущественно у лиц пожилого возраста.

е) Высокая скорость прогрессирования процесса деструкции эмали и вовлечение подлежащих слоев дентина.

№137. Укажите при планировании реставрации фронтальных зубов с выраженной эрозией III–IV степени по Основному индексу эрозивного износа (BEWE) обязательным является:

а) Выполнение исключительно прямых эстетических реставраций композитными материалами светового отверждения.

б) Диагностика в артикуляторе, коррекция окклюзионной высоты и комбинация прямых и непрямых методов восстановления.

- с) Категорический отказ от любого изменения высоты прикуса во избежание дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
- д) Применение исключительно металлокерамических коронок для обеспечения максимальной защиты оставшихся тканей.
- е) Тактика выжидания и мониторинга состояния тканей без проведения активного восстановительного лечения.

№138. Определите, что включает современная стратегия профилактики прогрессирования некариозных поражений:

- а) Проведение регулярной профессиональной гигиены полости рта в условиях клиники не реже одного раза в год.
- б) Комплексный контроль диеты, лечение сопутствующих патологий (ГЭРБ), окклюзионную терапию и мониторинг по BEWE.**
- с) Назначение курса процедур кабинетного или домашнего отбеливания для выравнивания цвета твердых тканей.
- д) Систематическое применение препаратов на основе диаминфторида серебра для глубокого фторирования дентина.
- е) Проведение планового ортодонтического лечения для исправления положения отдельных зубов и коррекции прикуса.

№139. Пациент 38 лет, бруксизм, множественные клиновидные дефекты в пришеечной области зубов 14, 15, 24, 25 с гиперестезией. Оклюзия нарушена. Выберите какой наиболее правильный план лечения:

- а) Немедленная фиксация светоотверждаемых композитных пломб во всех дефектах для устранения повышенной чувствительности.
- б) Изготовление защитной каппы и окклюзионная коррекция с последующей терапией гиперестезии и реставрацией эластичными массами.**
- с) Проведение сеансов электрофореза с препаратами кальция и фтора до полного исчезновения признаков чувствительности дентина.
- д) Тотальное препарирование пораженных зубов под цельнокерамические коронки для стабилизации окклюзионных взаимоотношений.
- е) Использование исключительно адгезивных систем пятого поколения для запечатывания дентинных канальцев без пломбирования.

№140. Пациентка 29 лет с выраженной эрозией фронтальных зубов верхней челюсти (BEWE = 12 баллов) вследствие частого употребления газированных напитков и ГЭРБ. Отметьте правильную последовательность действий:

- а) Проведение немедленной эстетической реставрации фронтальной группы зубов светоотверждаемыми композитами для устранения косметического дефекта.
- б) Консультация гастроэнтеролога, коррекция рациона питания, реминерализация и последующее восстановление зубов с учетом окклюзионной высоты.**
- с) Использование методов профессионального отбеливания для выравнивания цвета зубов с последующим покрытием их фторсодержащим лаком.
- д) Изготовление и фиксация полных керамических коронок на все зубы верхней челюсти без предварительного лечения сопутствующих заболеваний.
- е) Тактика активного наблюдения за состоянием твердых тканей в течение года без проведения лечебных и профилактических мероприятий.

№141. Пациент 45 лет, выраженный генерализованный эрозивный износ (BEWE = 14 баллов), причина — хроническая ГЭРБ и ежедневное употребление цитрусовых соков. Жалуется на повышенную чувствительность и эстетический дефект фронтальных зубов. Выберите наиболее правильный подход к лечению:

- а) Срочное выполнение прямой реставрации всех пораженных поверхностей современными нано-композитами под местной анестезией.
- б) Этиотропная терапия ГЭРБ, диетотерапия, интенсивный курс реминерализации и последующая реставрация после стабилизации процесса.**
- с) Восстановление эстетики и функции зубов с помощью прямых виниров без предварительного устранения патогенных факторов.
- д) Проведение тотального протезирования зубных рядов металлокерамическими или безметалловыми конструкциями для защиты дентина.
- е) Полный отказ от проведения любого стоматологического вмешательства в связи с высоким риском выпадения будущих пломб.

№142. У пациента 52 лет с бруксизмом и множественными абфракционными дефектами в пришеечной области зубов 13, 23, 33, 43 отмечается прогрессирование дефектов и периодическая гиперестезия. Выберите наиболее рациональное лечение:

- a) Проведение прямой реставрации пришеечных полостей композитами без учета особенностей окклюзионных взаимоотношений.
- b) Использование окклюзионной каппы, устранение зон преждевременных контактов и восстановление дефектов эластичными материалами.**
- c) Систематическое применение фторсодержащих гелей в домашних условиях для снижения чувствительности без пломбирования.
- d) Радикальное покрытие всех клыков искусственными коронками для предотвращения дальнейшего разрушения пришеечной области.
- e) Динамическое наблюдение за глубиной дефектов с периодическим проведением профессиональной гигиены полости рта.

№143. Пациентка 27 лет, профессиональная абразия (работает стоматологом-гигиенистом), выраженная стёртость режущих краёв фронтальных зубов и пришеечная абразия. Укажите, современный подход к реабилитации:

- a) Незамедлительное восстановление анатомической формы режущих краев и пришеечной зоны с помощью световых композитов.
- b) Анализ окклюзии, изменение техники чистки зубов, проведение реминерализации и последующая установка минимально-инвазивных конструкций.**
- c) Назначение курсового применения домашних десенситайзеров для самостоятельного устранения гиперестезии дентина.
- d) Проведение планового ортодонтического лечения для коррекции положения зубов и устранения травматической окклюзии.
- e) Полный отказ от проведения реставрационных работ до момента прекращения профессиональной деятельности пациентки.

№144. У пациента 36 лет сочетанное поражение: эрозия + абфракция на зубах 11, 21, 22 с обнажением дентина и сильной гиперестезией. Укажите правильная последовательность лечебных мероприятий:

- a) Проведение немедленной эстетической реставрации зубов композитными материалами для быстрого устранения болевого синдрома.
- b) Нейтрализация кислотного фактора, obturation дентинных канальцев и выполнение реставрации низкомодульными материалами.**
- c) Регулярные аппликации раствора диаминфторида серебра (SDF) для глубокого фторирования и дезинфекции поражённых тканей.
- d) Депульпирование поражённых зубов по клиническим показаниям с последующим пломбированием каналов и постановкой коронок.
- e) Назначение контрольного осмотра через 6 месяцев для оценки динамики процесса без проведения активного лечения.

№145. Пациент 61 год, выраженный генерализованный эрозивно-абразивный износ, BEWE = 17 баллов, значительное снижение окклюзионной высоты. Жалуется на нарушение функции и эстетики. Укажите современный план лечения:

- a) Одномоментное восстановление анатомической формы всех поражённых зубов прямым методом с использованием нано-композитов.
- b) Комплексная реабилитация через этап временного повышения прикуса и артикуляционный анализ с последующим протезированием.**
- c) Проведение длительного курса глубокого фторирования и реминерализации для стабилизации оставшихся твёрдых тканей.
- d) Изготовление полных или частичных съёмных протезов для восполнения дефицита тканей и восстановления высоты нижнего отдела лица.
- e) Тактика пассивного наблюдения с проведением профессиональной гигиены полости рта один раз в год без активного вмешательства.

№146. У ребёнка 14 лет выявлена начальная эрозия режущих краёв верхних резцов (BEWE = 6) вследствие частого употребления энергетических напитков. Укажите оптимальный протокол:

- a) Проведение немедленной прямой реставрации режущего края композитными материалами для предотвращения дальнейшего скола.
- b) Этиотропная работа с диетой, интенсивная реминерализирующая терапия препаратами кальция и фтора и регулярный мониторинг.**

- с) Однократное профессиональное покрытие пораженных зубов фторсодержащим лаком высокой концентрации в условиях клиники.
- д) Формирование классических полостей четвертого класса по Блэку и их последующее пломбирование световыми материалами.
- е) Динамическое наблюдение за состоянием эмали без предоставления специфических рекомендаций по питанию и гигиене.

№147. Пациент 49 лет с глубокими абфракционными дефектами на зубах 34, 35, 44, 45 и подвижностью зубов I степени. Оклюзия с суперконтактами. Выберите наиболее правильное лечение:

- а) Выполнение прямой эстетической реставрации пришеечных дефектов композитами без проведения предварительной коррекции прикуса.

б) Избирательное шлифование суперконтактов, шинирование зубов и реставрация полостей низкомолекулярными материалами.

- с) Использование методов консервативной пародонтологической терапии для устранения воспаления и снижения подвижности зубов.
- д) Радикальное препарирование зубов под металлокерамические коронки с объединением их в единый блок для стабилизации.
- е) Удаление подвижных зубов с последующим замещением дефектов зубного ряда мостовидными протезами или имплантатами.

№148. Укажите какой из перечисленных клинических признаков, согласно классификации Американской ассоциации эндодонтов (AAE) и рекомендациям Европейского общества эндодонтологии (ESE), наиболее точно указывает на диагноз обратимого пульпита?

- а) Появление спонтанных, самопроизвольных болей ноющего характера, которые усиливаются в ночное время и плохо купируются.

б) Кратковременная реакция на холодовые раздражители, быстро проходящая после их устранения, без периапикальных изменений.

- с) Наличие четко выраженной положительной реакции при проведении вертикальной перкуссии и пальпации проекции верхушки корня.
- д) Полное отсутствие какой-либо реакции на температурные тесты, что может свидетельствовать о начальной стадии дегенерации пульпы.
- е) Выраженный болевой синдром, возникающий при накусывании на зуб или механическом надавливании в области кариозной полости.

№149. Отметьте: в современной диагностике пульпита «золотым стандартом» комбинированной оценки состояния пульпы считается:

- а) Изолированное использование метода электроодонтодиагностики (ЭОД) для определения порога возбудимости нервных окончаний.

б) Сочетанное применение холодового теста, электроодонтометрии и компьютерной томографии при возникновении диагностических трудностей.

- с) Проведение тепловых тестов с использованием разогретой гуттаперчи для провокации болевого ответа со стороны сосудистого пучка.
- д) Выполнение сравнительной перкуссии зубов-антагонистов и стандартной внутриротовой рентгенографии в параллельной технике.
- е) Проведение тщательного визуального осмотра и зондирования дна кариозной полости на наличие сообщения с пульпарной камерой.

№150. Пациенту диагностирован необратимый пульпит в постоянном зубе с полностью сформированной верхушкой корня. Проанализируйте клиническую ситуацию и определите наиболее обоснованный метод лечения в соответствии с современными протоколами.

- а) Проведение глубокой пульпотомии с наложением лечебной прокладки на основе чистого гидроксида кальция.

б) Полная экстирпация пульпы с последующей инструментальной обработкой и герметичной obturацией системы каналов.

- с) Витальная ампутация коронковой пульпы с использованием минерал-триоксид агрегата для сохранения жизнеспособности корневой пульпы.
- д) Проведение процедуры классической апексификации для создания механического барьера в области верхушки корня.
- е) Применение регенеративных технологий для восстановления сосудисто-нервного пучка внутри пульпарной камеры.

№151. Проанализируйте клиническую ситуацию и определите, какие принципы лежат в основе современного лечения хронического апикального периодонтита.

- а) Значительное расширение просвета корневого канала до максимально возможных размеров для удаления инфицированного дентина.
- б) Комплексная антисептическая обработка, создание апикального упора, трехмерная obturation и герметизация коронковой части.**
- в) Применение исключительно методов медикаментозной стерилизации системы каналов без использования эндодонтического инструментария.
- г) Использование монофазной техники пломбирования только силером без применения гуттаперчевых штифтов для упрощения протокола.
- д) Проведение эндодонтического вмешательства в один визит во всех клинических случаях, независимо от наличия экссудации.

№152. Какой материал, согласно современным клиническим рекомендациям 2025–2026 годов, является наиболее обоснованным выбором для создания апикальной пробки при лечении зубов с открытым апексом и хроническим апикальным периодонтитом?

- а) Традиционный нетвердеющий препарат на основе гидроксида кальция для стимуляции естественного завершения роста корня.
- б) Группа биоактивных материалов: минерал-триоксид агрегат (МТА) или современные биокерамические силикатные цементы.**
- в) Использование резорцин-формалиновой смеси для мумификации тканей и предотвращения распространения инфекции в периапикальную зону.
- г) Специализированный кальций-салицилатный цемент химического отверждения, обладающий высокими показателями адгезии к дентину.
- д) Применение разогретой гуттаперчи без использования силера для создания плотного механического барьера в апикальной части.

№153. Оцените клиническую и рентгенологическую ситуацию и определите наиболее обоснованное заключение об эффективности лечения хронического апикального периодонтита через 12 месяцев после obturation корневого канала.

- а) Сочетание отсутствия клинических жалоб с признаками регенерации костной ткани по результатам КЛКТ-исследования.**
- б) Отсутствие выраженной болезненности при проведении вертикальной перкуссии и пальпации десны в проекции вершины корня.
- в) Наличие признаков уменьшения размера очага деструкции, определяемых по стандартной прицельной внутриротовой рентгенограмме.
- г) Появление положительного ответа со стороны тканей на температурные раздражители (холодовой тест) после завершения obturation.
- д) Стабильность естественного цвета коронки зуба и отсутствие видимого окрашивания твердых тканей продуктами распада пульпы.

№154. Проанализируйте клиническую ситуацию (необратимый пульпит зуба с открытым апексом у молодого пациента) и выберите оптимальный современный метод лечения.

- а) Проведение классической тотальной пульпэктомии с последующим пломбированием канала на всю рабочую длину.
- б) Применение регенеративных методик (REVASC) или проведение апексогенеза с использованием современных биосовместимых материалов.**
- в) Использование традиционного протокола апексификации с многократной заменой пасты гидроксида кальция в течение года.
- г) Проведение одномоментной obturation корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации без учета стадии роста корня.
- д) Удаление пораженного зуба с целью предотвращения развития остеомиелита челюсти и нарушения развития соседних зачатков.

№155. Проанализируйте клинические и диагностические данные и определите наиболее точный метод дифференциальной диагностики между острым апикальным абсцессом и острым необратимым пульпитом.

- а) Изолированное проведение холодного теста для оценки жизнеспособности пульпы в ответ на температурный раздражитель.
- б) Анализ комплекса общих и местных симптомов (отек, реакция лимфоузлов, гипертермия) совместно с данными 3D-диагностики.**

- с) Использование метода электроодонтодиагностики для определения точных цифр порога чувствительности нервных окончаний.
- д) Оценка реакции зуба на проведение сравнительной горизонтальной и вертикальной перкуссии с использованием ручки зонда.
- е) Проведение внутриротовой термометрии слизистой оболочки в области переходной складки для выявления очага воспаления.

№156. Выберите ирригационный раствор первого выбора при механико-медикаментозной обработке корневых каналов в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

а) Раствор гипохлорита натрия в низкой концентрации (0,5%) для минимизации риска раздражения периапикальных тканей.

б) Высококонцентрированный подогретый гипохлорит натрия в сочетании с хелатными агентами и методами активации раствора.

с) Использование водного раствора хлоргексидина биглюконата 2% в качестве основного антисептика для уничтожения патогенной флоры.

д) Применение изотонического физиологического раствора для механического вымывания опилок дентина и продуктов распада.

е) Использование раствора перекиси водорода 3% для создания эффекта кавитации и удаления инфицированных тканей из макроканала.

№157. Укажите современные показания к применению внутриканальных лекарственных средств при проведении межсеансовой медикаментозной обработки корневых каналов.

а) Проведение любого вида эндодонтического лечения зубов вне зависимости от поставленного диагноза и состояния тканей.

б) Диагностированный некроз пульпы или апикальный периодонтит, сопровождающийся активным воспалением и выделением экссудата.

с) Выявление обратимого пульпита, требующего проведения витальных методов лечения с сохранением корневой части пульпы.

д) Клиническая ситуация, характеризующаяся полным отсутствием отделяемого из корневых каналов при их инструментальной обработке.

е) Стандартный протокол эндодонтического лечения в один визит для предотвращения реинфицирования системы каналов.

№158. Определите современную тактику лечения хронического апикального периодонтита зуба при наличии свищевого хода (sinus tract). Какие этапы эндодонтического лечения являются приоритетными в данной клинической ситуации?

а) Проведение немедленной постоянной obturации корневых каналов в первое посещение при отсутствии жалоб пациента.

б) Поиск источника инфекции, полноценную обработку системы каналов и obturацию после прекращения выделения экссудата.

с) Назначение курса системной антибиотикотерапии без проведения первичного эндодонтического вмешательства в зубе.

д) Удаление причинного зуба как единственный надежный метод устранения хронического очага инфекции в челюсти.

е) Выполнение хирургического разреза по переходной складке и установку резинового дренажа без работы в каналах.

№159. Оцените и выделите наиболее прогностически значимый фактор успеха эндодонтического лечения.

а) Качество выполнения коронковой реставрации для обеспечения эстетики и восстановления анатомической формы зуба.

б) Сочетание герметичной трехмерной obturации системы каналов с качественным восстановлением коронковой части зуба.

с) Использование внутриканального штифта максимальной длины для обеспечения ретенции будущей искусственной конструкции.

д) Цветовые характеристики и прозрачность используемого пломбировочного материала при восстановлении доступа к каналам.

е) Общее количество посещений, затраченных на эндодонтическое лечение и медикаментозную обработку системы каналов.

№160. Какой материал рассматривается как «золотой стандарт» для постоянной obturации корневых каналов в современной эндодонтии (2026 г.)?

а) Методика холодной латеральной конденсации стандартных гуттаперчевых штифтов с использованием эпоксидного силера.

б) Применение биокерамических силеров в комбинации с техникой одного штифта или термопластической obturation.

с) Использование импрегнационного метода резорцин-формалиновой смесью для стерилизации труднопроходимых микроканалов.

д) Применение силеров на основе окиси цинка и эвгенола, обладающих выраженным антисептическим и седативным действием.

е) Использование исключительно гуттаперчевых штифтов без применения каких-либо герметизирующих паст или силеров.

№161. Проанализируйте рентгенологическую картину и определите основной диагностический признак, характерный для конденсирующего (склерозирующего) остита.

а) Равномерное расширение периодонтальной щели по всей длине корня зуба при сохранении целостности компактной пластинки.

б) Выявление очага склероза костной ткани в области апекса при сохранении или утрате жизнеспособности пульпы.

с) Наличие обширного участка просветления костной ткани с четкими границами в проекции вершины корня пораженного зуба.

д) Признаки наружной или внутренней резорбции твердых тканей корня зуба, определяемые при рентгенографии.

е) Полное отсутствие каких-либо видимых изменений структуры костной ткани и связочного аппарата на рентгеновском снимке.

№162. Выберите современную тактику лечения острого необратимого пульпита у пациентов с незавершенным формированием корня, обеспечивающую сохранение витальности пульпы

а) Проведение полной экстирпации пульпы (пульпэктомии) с последующим пломбированием канала на всю рабочую длину.

б) Выполнение частичной пульпотомии с использованием современных биоактивных материалов (МТА или Biodentine).

с) Использование методов консервативного медикаментозного лечения пульпита без проведения хирургического вскрытия полости.

д) Проведение процедуры апексогенеза путем многократного введения в корневой канал пасты на основе гидроксида кальция.

е) Применение регенеративного эндодонтического протокола с целью формирования нового сосудисто-нервного пучка.

№163. Проанализируйте клинические ситуации и определите, в каких случаях согласно рекомендациям Европейского общества эндодонтологии показано применение конусно-лучевой компьютерной томографии при эндодонтическом лечении.

а) Проведения любого первичного эндодонтического лечения во всех зубах для создания цифрового архива данных пациента.

б) Сложной анатомии, подозрении на фрактуру, оценке скрытых изменений и планировании микрохирургических вмешательств.

с) Выявления у пациента выраженного болевого синдрома неясной этиологии при отсутствии видимых дефектов на зубах.

д) Контроля качества obturation корневых каналов на этапе завершения лечения для оценки плотности прилегания материала.

е) Данный метод диагностики не рекомендуется к применению в эндодонтии ввиду высокой лучевой нагрузки на пациента.

№164. Определите наиболее значимый современный фактор, влияющий на долгосрочный прогноз лечения хронического очагового периодонтита.

а) Первоначальный геометрический размер периапикального очага деструкции костной ткани в области вершины корня.

б) Обеспечение герметичности коронковой реставрации для предотвращения микроподтекания и повторного инфицирования.

с) Паспортный возраст пациента и общее состояние его иммунной системы на момент начала стоматологического лечения.

д) Общее количество обнаруженных, инструментально обработанных и obturированных дополнительных корневых каналов.

е) Химический состав и торговое название используемого силера для постоянного пломбирования корневых каналов.

№165. Выберите какой метод является современным методом выбора при лечении внутреннего воспалительно-резорбтивного процесса пульпы?

а) Тактика пассивного динамического наблюдения за состоянием зуба с регулярным рентгенологическим контролем.

б) Полная экстирпация пульпы с последующей трехмерной obturацией канала биоактивными материалами.

с) Проведение частичной пульпотомии с сохранением жизнеспособности корневой пульпы под лечебной прокладкой.

д) Изолированное применение системной антибиотикотерапии для подавления воспалительного процесса в пульпе.

е) Удаление зуба вследствие высокого риска перфорации стенки корня и невозможности герметичного пломбирования.

№166. Проанализируйте современные протоколы активации ирригационных растворов в эндодонтии и определите основные методы и этапы их применения

а) Использование исключительно ручной активации раствора с помощью гуттаперчевого штифта или ручного эндофайла.

б) Применение ультразвуковых, лазерных или специализированных механических систем для активации антисептика.

с) Проведение стандартного шприцевого промывания системы каналов без использования дополнительных методов активации.

д) Предварительное нагревание ирригационного раствора перед введением в канал без его последующей активации.

е) Полный отказ от любых методов активации раствора во избежание риска выведения антисептика за верхушку корня.

№167. Укажите, каков уровень клинического успеха витальной пульпотомии с использованием МТА или Biodentine в постоянных зубах с незавершённым формированием корня согласно современным данным.

а) Менее 50%, что делает данный метод лечения нецелесообразным при наличии сформированного апикального упора.

б) Стабильно высокие показатели в пределах 85–95% при условии строгого соблюдения протокола и отбора случаев.

с) Около 60%, что сопоставимо с результатами лечения при использовании традиционных паст на основе гидроксида кальция.

д) Менее 30% в связи с высоким риском инфицирования пульпы и развития последующего некроза в отдаленные сроки.

е) Достигает 100% во всех клинических ситуациях независимо от возраста пациента и степени инфицирования кариозной полости.

№168. Пациент 24 лет, зуб 36. Жалуется на кратковременную острую боль от холодного, которая проходит через 8–12 секунд. ЭОД — 12 мкА, холодовой тест положительный, перкуссия отрицательная. На КЛКТ — небольшое расширение периодонтальной щели в области мезиального корня. Укажите диагноз и план лечения?

а) Острый необратимый пульпит, требующий немедленного проведения полной экстирпации пульпы и obturации каналов.

б) Обратимый пульпит, при котором показано проведение непрямого покрытия пульпы и постановка реставрации.

с) Хронический апикальный периодонтит в стадии обострения, требующий полноценного эндодонтического вмешательства.

д) Состояние пульпы в пределах физиологической нормы, требующее только динамического наблюдения за пациентом.

е) Тотальный некроз пульпы, требующий проведения антисептической обработки и временного пломбирования каналов.

№169. У пациента 19 лет после глубокого препарирования под коронку зуба 21 возникла длительная ноющая боль, усиливающаяся ночью. Холодовой тест вызывает резкую боль, сохраняющуюся более 25 секунд. Укажите, какой диагноз наиболее вероятен в данной клинической ситуации?

а) Развитие обратимого пульпита, требующее проведения консервативного лечения с сохранением жизнеспособности пульпы.

б) Формирование необратимого пульпита, требующее проведения экстирпации пульпы и обработки системы каналов.

с) Развитие острого апикального периодонтита вследствие механической или термической травмы при препарировании.

д) Бессимптомный некроз пульпы, возникший в результате нарушения кровообращения в сосудисто-нервном пучке.

е) Формирование пародонтального абсцесса в области межзубного сосочка из-за травматизации десневого края.

№170. Пациентка 32 лет, зуб 11. Спонтанные приступы боли в течение 3 дней. Холодовой тест вызывает длительную боль. На КЛКТ — нормальная периапикальная картина. Укажите, какой метод лечения наиболее современный?

а) Проведение глубокой пульпотомии с использованием МТА для сохранения жизнеспособности корневого отдела пульпы.

б) Полная пульпэктомия с последующей инструментальной обработкой и герметичной obturацией корневого канала.

с) Проведение исключительно медикаментозного лечения с назначением противовоспалительных препаратов и антибиотиков.

д) Выполнение непрямого покрытия пульпы лечебными прокладками через сформированную кариозную полость.

е) Тактика выжидания и наблюдения за состоянием зуба до момента появления четких рентгенологических изменений.

№171. У ребёнка 11 лет, зуб 36 с незавершённым ростом корней. Глубокий кариес, спонтанная боль. Холодовой тест — длительная боль. Укажите, какой метод лечения предпочтителен?

а) Проведение полной экстирпации пульпы с последующей инструментальной обработкой и obturацией всей системы каналов.

б) Выполнение частичной пульпотомии с использованием современных биоактивных материалов (Biodentine или МТА).

с) Проведение процедуры классической апексификации для создания механического барьера в области верхушки корня.

д) Применение регенеративного эндодонтического подхода (REVASC) для восстановления сосудисто-нервного пучка.

е) Удаление пораженного зуба с целью предотвращения развития воспалительных осложнений в области зачатков.

№172. Пациент 45 лет, зуб 46. Длительная боль от холодного, перкуссия резко положительная, ЭОД — 85 мкА. На рентгене — расширение периодонтальной щели. Установите диагноз:

а) Обратимый пульпит, требующий проведения консервативного лечения и сохранения жизнеспособности всей пульпы.

б) Сочетание острого необратимого пульпита с признаками сопутствующего апикального периодонтита.

с) Хронический апикальный периодонтит в стадии ремиссии без признаков активного воспаления тканей пульпы.

д) Бессимптомный некроз пульпы, требующий плановой антисептической обработки системы корневых каналов.

е) Состояние пульпы в пределах физиологической нормы при наличии выраженной окклюзионной травмы зуба.

№173. После прямого покрытия пульпы МТА в зубе 25 через 4 месяца появилась длительная боль на холод. КЛКТ показывает периапикальные изменения. Объясните что произошло?

а) Успешное завершение процесса регенерации с формированием защитного дентинного мостика над материалом.

б) Прогрессирование воспаления с переходом в необратимую форму пульпита и развитием апикального периодонтита.

с) Нормальная реакция тканей на присутствие биоактивного материала, не требующая дополнительного вмешательства.

д) Развитие специфической аллергической реакции замедленного типа на химические компоненты минерал-триоксид агрегата.

е) Вертикальный перелом корня зуба, возникший вследствие чрезмерного жевательного давления на ослабленную коронку.

№174. Пациент 28 лет, зуб 21 после травмы 2 месяца назад. Нет реакции на холод и ЭОД, но есть свищевой ход на десне. Установите диагноз:

- а) Обратимый пульпит, возникший как отсроченное осложнение после перенесенной механической травмы зуба.
- б) Некроз пульпарных тканей, осложненный развитием хронического апикального абсцесса со свищевым ходом.**
- в) Острый необратимый пульпит, требующий немедленного вскрытия полости зуба для купирования болевого синдрома.
- г) Острый серозный пульпит в стадии выраженного отека, характеризующийся отсутствием реакции на температурные тесты.
- д) Состояние тканей в пределах клинической нормы, характерное для посттравматического периода восстановления сосудов.

№175. У пациента 16 лет зуб 25 с открытым апексом. Необратимый пульпит. Выберите какой современный подход предпочтителен:

- а) Полная пульпэктомия с obturацией канала методом латеральной конденсации гуттаперчи до физиологической верхушки.
- б) Применение регенеративного эндодонтического протокола (REVASC) для стимуляции дальнейшего развития корня.**
- в) Использование традиционной методики апексификации с многократным введением препаратов на основе гидроксида кальция.
- г) Проведение классической глубокой пульпотомии с последующим динамическим наблюдением за состоянием пульпы.
- д) Тактика пассивного ожидания самопроизвольного закрытия верхушечного отверстия без проведения активного лечения.

№176. После лечения необратимого пульпита в зубе 16 методом витальной экстирпации с последующим пломбированием каналов через 3 недели пациент жалуется на периодическую ноющую боль при накусывании. Каналы запломбированы. Укажите наиболее вероятную причину болевых ощущений

- а) Проявление физиологической постпломбировочной реакции тканей на проведенное эндодонтическое вмешательство.
- б) Наличие нарушения герметичности коронковой реставрации или присутствие необнаруженного дополнительного канала.**
- в) Ожидаемая клиническая динамика процесса заживления периодонта при использовании современных силеров.
- г) Развитие специфической аллергической реакции организма на химические компоненты используемого корневого герметика.
- д) Иррадиация болевых ощущений от соседнего зуба, имеющего скрытую полость или хронический апикальный периодонтит.

№177. Пациент 50 лет, зуб 46. Жалуется на длительную ноющую боль от горячего, которая быстро снимается холодным. ЭОД — 8 мкА. Проанализируйте клинические данные и установите наиболее вероятный диагноз. Обоснуйте свой выбор.

- а) Тотальный некроз пульпарных тканей с распадом сосудисто-нервного пучка и вовлечением периапикальной области.
- б) Необратимый пульпит (стадия выраженной гиперемии с вовлечением глубоких безмиелиновых С-волокон).**
- в) Развитие обратимого пульпита, требующего консервативного лечения биологическим методом с сохранением витальности.
- г) Острый апикальный периодонтит, характеризующийся выраженной реакцией на температурные и механические раздражители.
- д) Состояние тканей пульпы в пределах клинической нормы при наличии повышенной индивидуальной чувствительности.

№178. Пациент 38 лет, зуб 36. Жалуется на свищ на десне в проекции корня. Перкуссия положительная, ЭОД — реакции нет. На КЛКТ визуализируется большой периапикальный очаг деструкции костной ткани. Укажите наиболее вероятный диагноз и оптимальный план лечения

- а) Хронический апикальный периодонтит в стадии стабильной ремиссии, требующий лечения в одно посещение.
- б) Хронический апикальный абсцесс: комплексная обработка каналов с временной медикаментозной obturацией.**

с) Назначение системной антибиотикотерапии как основного метода подавления периапикального очага инфекции.

д) Удаление пораженного зуба вследствие неблагоприятного прогноза и высокого риска развития остеомиелита челюсти.

е) Тактика пассивного динамического наблюдения за состоянием свища без проведения активного эндодонтического лечения.

№179. Через 14 месяцев после лечения хронического апикального периодонтита зуба 25 на КЛКТ очаг сохраняется. Клинически бессимптомно. Укажите ваши действия:

а) Принятие решения о немедленном повторном эндодонтическом вмешательстве и замене obturационного материала.

б) Продолжение динамического наблюдения сроком до 12 месяцев (полное восстановление кости может занять до 4 лет).

с) Проведение микрохирургической резекции верхушки корня для механического удаления очага деструкции.

д) Рекомендация пациенту удаления зуба и последующей дентальной имплантации в связи с отсутствием успеха лечения.

е) Назначение профилактического курса антибиотиков широкого спектра действия для стимуляции регенерации костной ткани.

№180. Пациент 55 лет, зуб 46 с большим периапикальным очагом и свищем. Выраженная экссудация из каналов. Укажите какой подход оптимален:

а) Проведение эндодонтического лечения в одно посещение с использованием биокерамических силеров высокой вязкости.

б) Многосеансное лечение с применением препаратов гидроксида кальция в каналах на срок от 2 до 4 недель.

с) Использование исключительно системных антибиотиков для купирования экссудации до начала работы в каналах.

д) Выполнение немедленной ретроградной хирургической ревизии верхушки корня без первичной обработки системы каналов.

е) Мониторинг состояния тканей без вмешательства до момента полного самопроизвольного закрытия свищевого хода.

№181. У пациента 29 лет после obtурации зуба 16 сохраняется боль при накусывании. На КЛКТ выявлен пропущенный второй мезиальный канал (МБ2). Определите ваши действия:

а) Тактика пассивного динамического наблюдения в течение 6 месяцев для оценки адаптации периодонта к пломбировочному материалу.

б) Повторное эндодонтическое вмешательство с обязательным поиском, инструментальной и медикаментозной обработкой пропущенного канала.

с) Немедленное проведение микрохирургической резекции верхушки мезиального корня для устранения очага хронического воспаления.

д) Удаление зуба вследствие невозможности достижения полной герметизации системы корневых каналов и неблагоприятного прогноза.

е) Назначение курса системной антибиотикотерапии для подавления микрофлоры в необработанной части системы каналов.

№182. Укажите что является основным принципом регенеративной эндодонтии, согласно современным рекомендациям Американской ассоциации эндодонтов (AAE, 2025)?

а) Проведение тотальной пульпэктомии с последующей трехмерной obtурацией системы каналов термопластической гуттаперчей.

б) Индукция кровяного сгустка, доставка стволовых клеток апикальной папиллы и применение скаффолдов для доразвития корня.

с) Выполнение процедуры апексификации с использованием минерал-триоксид агрегата (МТА) для создания механического апикального упора.

д) Внутривенное введение системных стволовых клеток для стимуляции регенераторного потенциала тканей челюстно-лицевой области.

е) Применение хирургического эндодонтического протокола с целью ретроградного закрытия широкого апикального отверстия.

№183. Пациенту 9 лет с незавершённым формированием корней зуба 3.6 и некрозом пульпы требуется эндодонтическое лечение. Обоснуйте выбор метода (апексогенез или апексификация) и объясните, почему другой метод в данном случае противопоказан

а) Апексогенез выполняется исключительно при витальном состоянии пульпы, в то время как апексификация — только при её некрозе.

б) Апексогенез — естественное завершение развития корня при витальности, апексификация — создание искусственной пробки при некрозе.

с) Полное совпадение используемых биоматериалов и клинических протоколов при выполнении обеих манипуляций в детской практике.

д) Отсутствие необходимости в обеспечении адекватного кровотока в апикальной области при проведении процедуры апексогенеза.

е) Возможность проведения апексификации только у взрослых пациентов со сформированным прикусом и законченным ростом челюстей.

№184. Укажите биоматериал, который в 2025–2026 гг. преимущественно используется для создания апикальной пробки при проведении традиционной апексификации.

а) Применение нетвердеющих паст на основе гидроксида кальция, требующих длительного нахождения в канале и частой замены.

б) Использование минерал-триоксид агрегата (МТА) или современных биокерамических составов на основе силикатов кальция.

с) Применение резорцин-формалиновой смеси для глубокой антисептической обработки и мумификации тканей в апикальной зоне.

д) Использование кальций-салицилатного цемента химического отверждения, обладающего высокой растворимостью в тканевой жидкости.

е) Выполнение obturation только гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без предварительного создания барьера.

№185. Укажите что является обязательным этапом в современном протоколе регенеративной эндодонтии (REPs) по ААЕ 2025?

а) Проведение агрессивной инструментальной обработки макроканала с целью удаления инфицированного дентина.

б) Использование исключительно химической дезинфекции без механического воздействия и индукции кровотока.

с) Сочетание бережной дезинфекции, минимальной обработки и индукции кровотока для формирования сгустка.

д) Проведение одномоментной obturation всей системы корневых каналов термопластической гуттаперчей.

е) Назначение длительного курса системной антибиотикотерапии как основного этапа стерилизации канала.

№186. Укажите наиболее перспективным методом стимуляции апексогенеза у зубов с открытым апексом и некротической пульпой в настоящее время является:

а) Традиционная апексификация с использованием гидроксида кальция для создания верхушечного барьера.

б) Полная экстирпация пульпы с последующим пломбированием канала методом латеральной конденсации.

с) Проведение хирургической апексэктомии с ретроградным пломбированием для закрытия широкого отверстия.

д) Регенеративный эндодонтический подход (cell-free REPs) с использованием скаффолдов и факторов роста.

е) Применение методики апексогенеза без обеспечения притока крови из периапикальных тканей в просвет канала.

№187. Укажите материал, применяемый для герметизации коронковой части корневого канала после проведения регенеративного эндодонтического лечения

а) Постановка классической пломбировочной конструкции из стеклоиономера без применения биоактивных прокладок.

б) Сочетанное применение биоактивного силикатного цемента (МТА или Biodentine) и композитной реставрации.

с) Использование временного пломбировочного материала на масляной основе для последующего контроля тканей.

д) Выполнение obturation только гуттаперчевыми штифтами без использования адгезивного герметизирующего слоя.

е) Изолированное применение светоотверждаемого композита непосредственно на область сформированного сгустка.

№188. Согласно современным рекомендациям ESE (2026), какое из перечисленных утверждений наиболее точно отражает основное преимущество регенеративной эндодонтии по сравнению с традиционной апексификацией

а) Сокращение общего времени пребывания пациента в кресле и упрощение протокола клинических манипуляций.

б) Возможность доразвития корня в длину, утолщения его стенок и закрытия апекса за счёт регенерации тканей.

с) Значительное снижение стоимости лечения в сравнении с использованием биокерамических материалов для апексификации.

д) Полное отсутствие необходимости в проведении конусно-лучевой компьютерной томографии на этапах контроля.

е) Достоверно меньшая частота возникновения воспалительных осложнений в раннем постпломбировочном периоде.

№189. Укажите какова основная роль богатой тромбоцитами плазмы (PRP) или фибрина (PRF) при их использовании в регенеративной эндодонтии?

а) Обеспечении исключительно антибактериального эффекта внутри системы корневых каналов.

б) Доставке факторов роста и создании естественного скаффолда для пролиферации стволовых клеток.

с) Использовании данных компонентов как полной альтернативы минерал-триоксид агрегату (MTA).

д) Повышении риска возникновения дисколорации коронковой части зуба в отдаленные сроки.

е) Проведении процедуры как прямой замены этапа формирования кровяного сгустка.

№190. Укажите какой из перечисленных признаков наиболее полно отражает успех регенеративной эндодонтии через 12–24 месяца наблюдения с учётом клинических и рентгенологических данных?

а) Полное восстановление чувствительности пульпы при проведении электроодонтодиагностики.

б) Изолированное отсутствие клинических симптомов и жалоб пациента на момент осмотра.

с) Отсутствие симптомов в сочетании с утолщением стенок корня и закрытием апекса по данным КЛКТ.

д) Сохранение первоначального естественного цвета коронки зуба без признаков окрашивания.

е) Получение гистологического подтверждения формирования полноценной ткани пульпы.

№191. Определите: одним из главных осложнений регенеративной эндодонтии при использовании классического MTA является:

а) Развитие специфической аллергической реакции организма на силикатные компоненты материала.

б) Дисколорация (окрашивание) коронки зуба за счёт высвобождения оксидов железа и висмута.

с) Слишком быстрое закрытие верхушечного отверстия, препятствующее дальнейшему росту корня.

д) Значительное снижение механической прочности стенок корня в области апикальной трети.

е) Полное отсутствие процессов регенерации тканей в просвете корневого канала.

№192. Укажите, почему в регенеративной эндодонтии современные биоактивные силикатные цементы (TotalFill, NeoMTA) предпочтительны перед классическим MTA:

а) Данные материалы обладают более низкой стоимостью в сравнении с традиционным порошковым MTA.

б) Они не вызывают дисколорацию коронки и обладают улучшенными манипуляционными свойствами.

с) Материалы не требуют предварительного увлажнения дентина перед этапом внесения в канал.

д) Составы полностью рассасываются в процессе регенерации, замещаясь собственной костной тканью.

е) Цементы не обладают антибактериальной активностью, что благоприятно для роста стволовых клеток.

№193. Укажите, что современный cell-homing (самонаведение клеток) подход в регенеративной эндодонтии подразумевает?

а) Трансплантацию выращенных в лаборатории мезенхимальных стволовых клеток непосредственно в канал.

б) Полное удаление всех клеточных элементов из канала с целью обеспечения стерильности пространства.

с) Привлечение собственных стволовых клеток пациента с помощью факторов роста и скаффолдов.

д) Использование исключительно индукции кровотока без применения дополнительных биоактивных веществ.

е) Применение методов локальной генной терапии для перепрограммирования оставшихся клеток пульпы.

№194. Выберите: при выборе метода стимуляции апексогенеза у зуба с открытым апексом и частично витальной пульпой предпочтение отдаётся:

- а) Проведению традиционной апексификации с созданием искусственного барьера в области верхушки корня.
- б) Сочетанию частичной пульпотомии с биоактивными материалами и элементов регенеративного подхода.
- в) Выполнению полной экстирпации пульпы с последующим пломбированием канала на всю рабочую длину.
- г) Изолированному применению антибактериальных препаратов без проведения оперативного вмешательства.
- д) Тактика пассивного динамического наблюдения за состоянием пульпы без проведения лечебных манипуляций.

№195. Укажите согласно современным исследованиям 2025–2026 гг., успех регенеративной эндодонтии (REPs) по сравнению с МТА-апексификацией выше по показателю:

- а) Общей скорости завершения всех этапов стоматологического лечения и постановки постоянной пломбы.
- б) Увеличения толщины и длины корня, а также существенного снижения риска его последующего перелома.
- в) Полного отсутствия риска развития дисколорации (окрашивания) твердых тканей коронковой части зуба.
- г) Экономической эффективности и низкой стоимости используемых расходных материалов и оборудования.
- д) Минимального количества посещений, необходимых для достижения стабильного клинического результата.

№196. Укажите: в регенеративной эндодонтии скаффолдами нового поколения являются:

- а) Использование исключительно аутологичного кровяного сгустка, сформированного в просвете корневого канала.
- б) Гидрогели на основе коллагена и наночастиц с контролируемым высвобождением специфических факторов роста.
- в) Применение стандартных гуттаперчевых штифтов в сочетании с биокерамическими силерами последнего поколения.
- г) Использование стеклоиономерных цементах высокой вязкости для временного заполнения объема канала.
- д) Применение титановых или стекловолоконных штифтов для создания жесткого каркаса внутри системы каналов.

№197. Установите: основным противопоказанием к регенеративной эндодонтии является:

- а) Наличие анатомически открытого апекса в зубе с незавершенным формированием верхушки корня.
- б) Совокупность аллергии на антибиотики, невозможности гемостаза и тяжелых системных заболеваний.
- в) Паспортный возраст пациента старше 18 лет при наличии признаков регенераторного потенциала тканей.
- г) Сохранение витальности пульпы, требующее проведения консервативных методов лечения пульпита.
- д) Клиническое отсутствие свищевого хода на слизистой оболочке в проекции верхушки корня зуба.

№198. Укажите: современным методом активации регенерации в регенеративной эндодонтии является:

- а) Использование исключительно ручных эндодонтических инструментов для создания микрошероховатости дентина.
- б) Лазерная активация растворов (PIPS/SWEEPS) в сочетании с применением факторов роста и фибрина (PRF).
- в) Проведение стандартного шприцевого промывания системы каналов антисептиками без дополнительной энергии.
- г) Полный отказ от любых методов физической активации растворов во избежание повреждения стволовых клеток.
- д) Проведение химической дезинфекции канала высоконцентрированными растворами без использования лазера.

№199. Укажите: согласно ESE 2026, регенеративная эндодонтия рекомендуется в первую очередь при:

- а) Полностью сформированном корне с закрытым апексом при наличии подтвержденного некроза пульпы.
- б) Незавершённом росте корня и некрозе пульпы у молодых пациентов с широким апикальным отверстием.

с) Лечении хронических форм апикального периодонтита у взрослых пациентов со сформированным прикусом.

д) Наличии горизонтального перелома корня в средней или апикальной трети при сохранении витальности.

е) Диагностированной внутренней резорбции корня, не затронувшей наружную поверхность цемента.

№200. Выберите: самым перспективным направлением развития регенеративной эндодонтии в 2026 году считается:

а) Увеличение частоты применения классического минерал-триоксид агрегата (МТА) для создания апикальных барьеров.

б) Переход к cell-based подходам с ex-vivo культивированием стволовых клеток и 3D-биопечатью скаффолдов.

с) Возврат к традиционным методикам использования гидроксида кальция для стимуляции естественного закрытия апекса.

д) Полный отказ от использования искусственных биоматериалов в пользу естественной регенерации тканей пульпы.

е) Применение исключительно хирургических методов лечения для радикального устранения периапикальных очагов.

№201. Выберите: при использовании Biodentine в регенеративной эндодонтии его преимущество перед МТА заключается в:

а) Более быстром времени схватывания, отсутствии риска дисколорации и высоких показателях биосовместимости.

б) Существенно более низкой рыночной стоимости материала в сравнении с импортными аналогами на основе силикатов.

с) Полном отсутствии выраженного антибактериального эффекта, что благоприятно для деления стволовых клеток.

д) Необходимости обеспечения длительного увлажнения поверхности дентина в течение всего процесса полимеризации.

е) Более низких показателях герметичности прилегания к тканям зуба, что облегчает проведение повторного лечения.

№202. Пациент 12 лет, зуб 21 с незавершённым формированием корня и некрозом пульпы. Через 12 месяцев после реваскуляризации по КЛКТ не отмечено утолщения стенок и закрытия апекса, хотя жалобы отсутствуют. Определите вашу дальнейшую наиболее обоснованную тактику:

а) Проведение повторного протокола реваскуляризации с целью повторного индуцирования полноценного кровяного сгустка.

б) Переход к методике апексификации гидроксидом кальция с многократной заменой пасты в течение длительного периода.

с) Создание апикального барьера с использованием минерального триоксидного агрегата (МТА) или биокерамики.

д) Проведение obturation корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации без создания апикального упора.

е) Продолжение тактики динамического наблюдения без активного вмешательства в течение еще одного года.

№203. Пациент 10 лет. При регенеративной терапии зуба с незавершённым формированием корня использована тройная антибиотик-паста. Через 2 недели отмечена выраженная дисколорация коронки. Укажите, какой компонент вызвал это осложнение?

а) Метронидазол — вследствие нарушения метаболизма в окружающих тканях и накопления продуктов распада.

б) Ципрофлоксацин — из-за специфической химической реакции с неорганическими компонентами эмали и дентина.

с) Миноциклин — по причине связывания с кальцием дентина и образования окрашенных хелатных комплексов.

д) Амоксициллин — в результате системного влияния препарата на структуру твердых тканей формирующегося зуба.

е) Клиндамицин — вследствие прямого токсического воздействия на одонтобласты и нарушения синтеза дентина.

№204. Ключевым этапом регенеративной эндодонтии является индуцирование кровотечения из апикальной зоны. Определите, каков основной механизм терапевтического эффекта этого действия?

- а) Формирование грануляционной ткани в просвете канала без участия специфических клеток-предшественников.
 - б) Стимуляция и активация оставшихся одонтобластов в коронковой части пульпарной камеры.
 - с) Обеспечение притока мезенхимальных стволовых клеток из апикальной папиллы в область дезинфицированного канала.
 - д) Заполнение пространства фиброзным рубцом, обеспечивающим механическую стабильность корня зуба.
 - е) Избирательная активация цементобластов для ускорения формирования наружного слоя корня зуба.
- №205.** В регенеративной процедуре над сформированным кровавым сгустком использован минеральный триоксидный агрегат (МТА). Укажите какое его свойство является наиболее важным для успеха данной манипуляции:
- а) Высокая эластичность материала, позволяющая компенсировать микродеформации коронки при нагрузке.
 - б) Способность к быстрому рассасыванию и замещению естественными тканями организма в процессе заживления.
 - с) Высокая биосовместимость и способность стимулировать процессы минерализации тканей.
 - д) Выраженное пролонгированное антибактериальное действие на патогенную микрофлору макроканала.
 - е) Оптическая радиопрозрачность, позволяющая детально изучать состояние тканей под пломбой на рентгене.
- №206.** Укажите при выборе тактики лечения подростка с некрозом пульпы, какое клинико-анатомическое состояние является прямым показанием к применению регенеративной эндодонтии?
- а) Полностью завершённое формирование корня зуба с физиологическим сужением в апикальной части.
 - б) Наличие достаточной толщины стенок корня, обеспечивающей высокую устойчивость к механическим факторам.
 - с) Узкое апикальное отверстие, затрудняющее проникновение стволовых клеток из периапикальных тканей в область канала.
 - д) Сочетание широкого апикального отверстия и критически тонких стенок корня зуба.
 - е) Полное отсутствие видимых периапикальных изменений на диагностических рентгеновских снимках.
- №207.** После успешно проведенной реваскуляризации на контрольных снимках наблюдается закрытие верхушки корня, однако показатели ЭОД остаются отрицательными. Выберите как следует интерпретировать данный результат?
- а) Лечение признается неэффективным, так как не произошло восстановления иннервации тканей внутри канала.
 - б) Истинная пульпарная ткань не сформировалась, и канал заполнен аморфным кальцифицированным веществом.
 - с) В процессе регенерации образовался исключительно вторичный дентин без участия сосудистых структур.
 - д) В канале сформировалась живая ткань, которая гистологически не идентична исходной пульпе зуба.
 - е) Клиническая картина свидетельствует о развитии хронического пульпита в регенерированной ткани.
- №208.** При проведении регенеративной терапии был использован гипохлорит натрия в высокой концентрации (5,25%). Укажите негативное последствие наиболее вероятно в данном случае:
- а) Значительное усиление антисептического эффекта, приводящее к полной стерильности системы каналов.
 - б) Химическое повреждение и гибель стволовых клеток апикальной папиллы, необходимых для регенерации.
 - с) Неоправданное ускорение темпов формирования твердых тканей корня зуба в апикальной трети.
 - д) Выраженное усиление кровотечения из периапикальных тканей при попытке создания сгустка.
 - е) Специфическая стимуляция процессов ангиогенеза за счет раздражающего действия хлора.
- №209.** Укажите какой стоматологический материал является предпочтительным для минимизации риска дисколорации (окрашивания) коронки при сохранении высокой биоактивности?
- а) Светоотверждаемый композитный материал последнего поколения.
 - б) Биоактивный заменитель дентина на основе силиката кальция (Биодентин).
 - с) Традиционный цинк-фосфатный цемент для фиксации конструкций.
 - д) Стеклоиономерный цемент высокой вязкости для постоянных пломб.
 - е) Поликарбоксилатный цемент, обладающий высокой адгезией к дентину.
- №210.** Определите в чем заключается основной клинический недостаток метода апексификации с использованием препаратов гидроксида кальция?

- a) Полное отсутствие выраженного антисептического эффекта в системе каналов.
- b) Чрезмерно высокая стоимость расходных материалов и оборудования для процедуры.
- c) Длительный период лечения и риск последующего перелома стенок корня.**
- d) Техническая невозможность формирования апикального кальцифицированного барьера.
- e) Высокая системная токсичность препарата при его контакте с периодонтом.

№211. После проведения регенеративной терапии на контрольном снимке отмечается утолщение стенок корня и частичная облитерация просвета канала. Укажите какова наиболее вероятная биологическая причина этого явления?

- a) Ошибка на этапе проведения obturации и случайное выведение материала в канал.
- b) Прогрессирующая внутренняя резорбция твердых тканей корня зуба.
- c) Активное отложение твёрдых тканей вследствие специфической дифференцировки клеток.**
- d) Тотальный некроз пульпарных тканей и отсутствие процессов заживления.
- e) Случайная перфорация стенки корня в процессе инструментальной обработки.

№212. Пациент 52 лет обратился с жалобой на белесоватое пятно на боковой поверхности языка. Объективно: участок гиперкератоза с чёткими границами, не снимается при поскабливании.

Гистологически выявлены акантоз, паракератоз и умеренная дисплазия. Установите наиболее вероятный диагноз.

- a) Типичная форма красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта.
- b) Хронический гиперпластический кандидоз с вовлечением глубоких слоев эпителия.
- c) Лейкоплакия (веррукозная или плоская форма) с признаками дисплазии.**
- d) Внутриэпителиальный рак слизистой оболочки (болезнь Боуэна).
- e) Множественные папилломы слизистой оболочки полости рта.

№213. Пациентка 48 лет жалуется на чувство жжения слизистой щеки. Объективно: на слизистой определяется характерный симметричный белый сетчатый рисунок (сетка Уикхема). Укажите оптимальную тактику ведения пациентки:

- a) Немедленное радикальное хирургическое иссечение пораженного участка слизистой.
- b) Назначение длительного курса системных антибиотиков широкого спектра действия.
- c) Применение местных глюкокортикостероидов для купирования воспаления.**
- d) Тактика пассивного динамического наблюдения без проведения активной терапии.
- e) Назначение курса лучевой терапии на область пораженной слизистой оболочки.

№214. У пациента диагностирована эрозивная форма лейкоплакии. Определите фактор из перечисленных в наибольшей степени увеличивает риск малигнизации (озлокачествления) данного поражения:

- a) Возраст пациента менее 30 лет при отсутствии сопутствующих системных патологий.
- b) Анатомическая локализация очага на красной кайме нижней губы.
- c) Наличие морфологически подтвержденной дисплазии эпителия различной степени.**
- d) Кратковременное течение заболевания (менее одного месяца с момента появления).
- e) Полное отсутствие субъективных жалоб со стороны пациента на боль или дискомфорт.

№215. Пациент 60 лет. На слизистой щеки обнаружен очаг с участками гиперкератоза и изъязвления. Определите при подозрении на предраковое состояние, какой метод диагностики является решающим для постановки окончательного диагноза?

- a) Тщательный визуальный осмотр с использованием стоматологического зеркала и зонда.
- b) Цитологическое исследование мазка-отпечатка с поверхности пораженного участка.
- c) Проведение эксцизионной или инцизионной биопсии с последующим гистологическим анализом.**
- d) Люминесцентная диагностика (стоматоскопия) в ультрафиолетовых лучах.
- e) Проведение стоматологической пробы Шиллера–Писарева с раствором Люголя.

№216. У пациента диагностирована эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая. Укажите какой принцип патогенетического лечения является основным для данной патологии?

- a) Интенсивная антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия.
- b) Назначение местной или системной иммуносупрессивной терапии.**
- c) Применение противогрибковых препаратов для устранения вторичной флоры.
- d) Немедленное радикальное хирургическое удаление всех очагов поражения.
- e) Монотерапия витаминными комплексами и общеукрепляющими средствами.

№217. Пациент со стажем курения более 20 лет. При осмотре на слизистой оболочке полости рта выявлен очаг лейкоплакии. Укажите, что должно стать первым и обязательным этапом лечения?

- a) Проведение хирургического удаления участка гиперкератоза с помощью лазера или скальпеля.
- b) Назначение превентивного курса антибиотиков для профилактики инфицирования.
- c) Полное устранение этиологических факторов (отказ от курения, устранение травмы).**

д) Назначение курса лучевой терапии для предотвращения озлокачествления процесса.

е) Немедленное протезирование или перепротезирование для восстановления высоты прикуса.

№218. Пациент обратился с признаками хронической травмы слизистой оболочки, вызванной краем съемного протеза. Укажите биологический механизм, лежащий в основе потенциальных предраковых изменений в этой зоне.

а) Специфическая аллергическая реакция на компоненты базисной пластмассы протеза.

б) Процессы хронического воспаления и постоянной патологической регенерации тканей.

с) Острый инфекционный процесс, вызванный внедрением неспецифической микрофлоры.

д) Локальное нарушение кровоснабжения и ишемия тканей под базисом протеза.

е) Первичная спонтанная генетическая мутация клеток эпителия в зоне контакта.

№219. Пациентка 55 лет жалуется на выраженную сухость во рту (ксеростомия), жжение и появление белых полос на слизистой. Укажите с каким системным заболеванием следует дифференцировать данное состояние в первую очередь?

а) Локализованная форма плоской лейкоплакии слизистой оболочки.

б) Болезнь или синдром Шегрена (аутоиммунное поражение желез).

с) Изолированный десквамативный глоссит («географический язык»).

д) Острый язвенно-некротический стоматит Венсана.

е) Рецидивирующий герпетический стоматит в стадии высыпаний.

№220. Определите при лечении предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР), какой принцип ведения пациента является обязательным согласно протоколам?

а) Превентивное назначение курсов антибиотиков широкого спектра действия.

б) Проведение радикального хирургического иссечения всем без исключения пациентам.

с) Пожизненное диспансерное наблюдение с регулярными осмотрами.

д) Обязательная госпитализация в челюстно-лицевой стационар для обследования.

е) Назначение профилактической лучевой терапии на зоны гиперкератоза.

№221. Тревожный пациент активно избегает лечения и категорически отказывается от биопсии при наличии клинического подозрения на предрак. Укажите наиболее правильную тактику врача в рамках деонтологии:

а) Немедленное прекращение приема и отказ от дальнейшего ведения пациента.

б) Настаивание на процедуре в жесткой ультимативной форме для спасения жизни.

с) Использование методов мотивационного интервью и разъяснение рисков.

д) Игнорирование отказа и попытка провести манипуляцию под видом другой услуги.

е) Назначение седативных препаратов без объяснения причин их приема.

№222. Пациент страдает выраженной дентофобией (страхом стоматологического вмешательства).

Определите метод психологической подготовки наиболее эффективен на первичном приеме:

а) Проведение немедленного лечения в полном объеме для сокращения времени стресса.

б) Подробное информирование о манипуляциях и установление доверительного контакта.

с) Применение глубокой седации без предварительного обсуждения плана лечения.

д) Полное игнорирование страха пациента и переход к инструментальному осмотру.

е) Максимально быстрое выполнение болезненных этапов без предупреждения.

№223. Пациент ведет себя агрессивно и провоцирует конфликтную ситуацию в кабинете. Выберите какой стиль профессионального общения врача является предпочтительным?

а) Авторитарный стиль с демонстрацией профессионального превосходства.

б) Полное игнорирование высказываний пациента до момента его успокоения.

с) Спокойный, уверенный и эмпатичный тон с сохранением личных границ.

д) Жесткий контроль над поведением пациента с угрозой прекращения приема.

е) Сугубо формальный и холодный стиль общения без эмоционального вовлечения.

№224. Пациент систематически не соблюдает врачебные рекомендации по гигиене и приему препаратов. Установите какой психологический подход со стороны врача будет наиболее эффективным?

а) Применение системы психологического наказания и порицания пациента.

б) Игнорирование факта несоблюдения рекомендаций и продолжение лечения.

с) Повторная мотивация и подробное объяснение клинических последствий.

д) Одностороннее прекращение договора на оказание стоматологических услуг.

е) Усиление психологического давления на пациента через авторитет врача.

№225. Пациент испытывает выраженный страх перед возможной болью во время стоматологического вмешательства. Выберите какой фактор в рамках психологической подготовки наиболее эффективно снижает уровень тревожности:

а) Максимально быстрое начало проведения инвазивных манипуляций без лишних разговоров.

б) Подробное объяснение каждого этапа лечения и планируемых ощущений пациента.

с) Игнорирование жалоб на страх с целью демонстрации уверенности и спокойствия врача.

д) Профилактическое назначение курса антибиотиков для снижения воспалительной реакции.

е) Повышение голоса и использование строгого тона для дисциплинирования пациента в кресле.

№226. Укажите при необходимости сообщения пациенту информации о выявленном предраковом состоянии слизистой оболочки, какой принцип коммуникации является наиболее важным?

а) Предоставление минимального объема информации во избежание излишней психологической травмы.

б) Использование сложной академической терминологии для демонстрации экспертности врача.

с) Предоставление четкой, доступной и честной информации о состоянии и рисках.

д) Скрытие истинного диагноза до момента получения результатов гистологического исследования.

е) Использование метода запугивания для обеспечения стопроцентной явки на дальнейшее лечение.

№227. Пациентка начала плакать непосредственно во время стоматологического приема. Определите какова должна быть наиболее корректная и профессиональная тактика врача?

а) Продолжение лечения в обычном темпе, чтобы не акцентировать внимание на эмоциональном состоянии.

б) Полное игнорирование эмоциональной реакции с целью сохранения рабочего ритма кабинета.

с) Проявление эмпатии, временная приостановка манипуляций и предложение сделать паузу.

д) Немедленное прекращение приема и предложение пациенту отправиться домой до успокоения.

е) Повышение голоса с требованием взять себя в руки для обеспечения безопасности лечения.

№228. Пациент проявляет высокую онкобеспокойность и задает много уточняющих вопросов. Укажите какой фактор со стороны врача в этой ситуации сильнее всего укрепит доверие?

а) Высокая скорость проведения осмотра, демонстрирующая опыт и профессиональную хватку.

б) Подробное, аргументированное объяснение диагноза, методов диагностики и плана действий.

с) Минимизация общения по существу вопроса для предотвращения роста тревоги у пациента.

д) Быстрое назначение симптоматических препаратов без проведения глубокой диагностики.

е) Вежливое игнорирование части вопросов, которые врач считает несущественными.

№229. Пациент выражает сомнение в правильности поставленного диагноза. Выберите какая тактика врача в этой ситуации будет наиболее профессиональной и этичной?

а) Игнорирование сомнений пациента с целью сохранения его уверенности в компетенции врача.

б) Использование авторитета врача и стажа работы для подавления критического настроения пациента.

с) Предложение пациенту получить «второе мнение» у другого специалиста или консилиума.

д) Односторонний отказ в дальнейшем лечении вследствие отсутствия доверия между сторонами.

е) Назначение широкого спектра препаратов для быстрого купирования симптомов без разъяснений.

№230. Пациент находится в состоянии хронического стресса. Укажите каким образом этот фактор влияет на течение заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР)?

а) Данное состояние не оказывает клинически значимого влияния на патогенез заболеваний слизистой.

б) Происходит усиление воспалительных процессов и замедление механизмов регенерации тканей.

с) Состояние стресса провоцирует развитие исключительно кариозного процесса и болезней пародонта.

д) Происходит незначительное снижение местного иммунитета, не требующее коррекции плана лечения.

е) Гормональный фон при стрессе способствует ускоренному заживлению эрозий и язвенных дефектов.

№231. Выберите при ведении пациентов с выявленными предраковыми заболеваниями, какой прогностический фактор является наиболее клинически значимым?

а) Биологический пол пациента и наличие сопутствующих эндокринных нарушений.

б) Конкретная анатомическая локализация патологического очага в полости рта.

с) Гистологически подтвержденная степень дисплазии эпителия в зоне поражения.

д) Изменение цветовых характеристик слизистой оболочки в очаге гиперкератоза.

е) Характер и интенсивность субъективных жалоб пациента на момент первичного осмотра.

№232. Пациент 57 лет, курит более 25 лет. Жалобы на белое пятно на языке с эрозиями. Цитология выявила атипичные клетки. Пациент категорически отказывается от биопсии из-за страха. Укажите какова наиболее правильная тактика врача?

а) Ограничиться назначением местной противовоспалительной терапии и кератопластиков.

б) Оставить пациента под наблюдением, не предпринимая активных попыток проведения диагностики.

с) Провести хирургическое иссечение очага в принудительном порядке для спасения жизни пациента.

д) Применить методы мотивационного консультирования с подробным разъяснением всех рисков.

е) Назначить эмпирическую противогрибковую терапию для исключения сопутствующей инфекции.

№233. Пациентка 49 лет жалуется на жжение слизистой щек. Объективно: двусторонние белые сетчатые элементы и участки эрозий. В анамнезе: хронический стресс и системное аутоиммунное заболевание. Укажите наиболее вероятный диагноз.

- а) Плоская форма лейкоплакии слизистой оболочки, вызванная хронической травмой.
- б) Хронический гиперпластический кандидоз на фоне снижения общей резистентности.
- в) Красный плоский лишай (эрозивно-язвенная форма) с характерным рисунком.
- г) Острый рецидивирующий герпетический стоматит в стадии образования эрозий.
- д) Болезнь Боуэна (внутриэпителиальный рак) слизистой оболочки полости рта.

№234. Пациент 62 лет. Жалобы на язву на слизистой дна полости рта, не заживающую более 1 месяца.

Объективно: язва с плотными краями, инфильтрацией, без выраженной болезненности. При пальпации выявлены увеличенные регионарные лимфоузлы. Выберите действие которое является первоочередным:

- а) Назначение курса антибиотиков широкого спектра действия для купирования возможного воспаления.
- б) Проведение курса физиотерапевтических процедур для стимуляции эпителизации язвенного дефекта.
- в) Срочное выполнение инцизионной биопсии с последующим гистологическим исследованием тканей.
- г) Назначение местной и системной противогрибковой терапии при подозрении на специфический процесс.
- д) Ограничение тактикой пассивного динамического наблюдения в течение ближайших двух недель.

№235. Пациент 14 лет с выраженной дентофобией. Требуется осмотр подозрительного участка слизистой. При попытке осмотра пациент отказывается открыть рот и проявляет высокую тревогу. Выберите оптимальную тактику врача:

- а) Немедленное проведение диагностической процедуры с применением физического удержания, несмотря на сопротивление.
- б) Полное прекращение приёма и отказ от дальнейшего ведения пациента ввиду невозможности контакта.
- в) Использование методов постепенной десенсибилизации и установление доверительного психологического контакта.
- г) Назначение курса антибактериальных препаратов для предотвращения инфицирования подозрительного участка.
- д) Направление пациента в специализированный стационар без объяснения причин и предварительного осмотра.

№236. Пациент 55 лет, лейкоплакия щеки. После устранения травмы и отказа от курения динамики нет. Гистология после биопсии: тяжёлая дисплазия эпителия. Выберите наиболее обоснованную тактику лечения.

- а) Продолжение тактики динамического наблюдения с регулярными осмотрами один раз в три месяца.
- б) Назначение длительной местной медикаментозной терапии с использованием кератопластических средств.
- в) Радикальное хирургическое иссечение патологического очага в пределах здоровых тканей.
- г) Проведение курса интенсивной витаминотерапии (витамины А, Е) как основного метода лечения.
- д) Применение методов физиотерапии (электрофорез, лазеростимуляция) для воздействия на зону гиперкератоза.

№237. Укажите какой физиологический механизм лежит в основе метода электроодонтодиагностики (ЭОД), используемого в клинической практике?

- а) Специфическое возбуждение механорецепторов пульпы при контакте с активным электродом прибора.
- б) Кратковременное тепловое раздражение сосудистого русла пульпы под воздействием электрического тока.

в) Дозированная электрическая стимуляция чувствительных нервных окончаний сосудисто-нервного пучка зуба.

г) Прямое воздействие электрического импульса на слой одонтобластов для оценки их функциональной активности.

д) Избирательная активация цементобластов в области верхушки корня зуба для определения их жизнеспособности.

№238. Выберите, какой фактор из перечисленных наиболее существенно влияет на достоверность и точность показателей электроодонтодиагностики?

- а) Индивидуальные цветовые характеристики эмали (оттенок, прозрачность) исследуемого зуба.
- б) Суммарная толщина твердых тканей (эмали и дентина) над проекцией рога пульпы.
- в) Анатомическая форма коронковой части зуба и выраженность бугров на жевательной поверхности.
- г) Паспортный возраст пациента на момент проведения диагностического исследования.
- д) Половая принадлежность пациента и особенности его гормонального статуса.

№239. Укажите при остром очаговом пульпите порог чувствительности пульпы при проведении электроодонтодиагностики (ЭОД):

- а) Резко повышается относительно возрастной нормы пациента.
- б) Снижается (например, до 15–20 мкА), что указывает на повышенную возбудимость.
- в) Полностью отсутствует вследствие необратимых изменений в тканях.
- г) Остается в пределах физиологической нормы (2–6 мкА).
- д) Демонстрирует хаотичные изменения без четкой закономерности.

№240. Укажите при полном некрозе пульпарных тканей показатели электроодонтодиагностики (ЭОД) обычно составляют:

- а) От 2 до 6 мкА (нормальная реакция сосудисто-нервного пучка).
- б) От 10 до 20 мкА (начальные стадии воспалительного процесса).
- в) От 20 до 40 мкА (хронические формы воспаления пульпы).
- г) Более 100 мкА или полное отсутствие ответа на максимальный ток.
- д) От 50 до 60 мкА (глубокие дистрофические изменения).

№241. Определите какое клиническое состояние или техническая ошибка может привести к получению ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата при ЭОД?

- а) Глубокий некроз пульпарных тканей во всех корневых каналах.
- б) Чрезмерное высушивание поверхности зуба перед исследованием.
- в) Случайный контакт активного электрода со слизистой оболочкой десны.
- г) Отсутствие плотного физического контакта электрода с тканями зуба.
- д) Полная изоляция исследуемого зуба от слюны и соседних тканей.

№242. Укажите какой фактор в ходе проведения электроодонтодиагностики чаще всего приводит к получению ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНОГО результата?

- а) Влажная поверхность зуба, способствующая растеканию тока.
- б) Контакт электрода с металлической коронкой или пломбой.
- в) Плохая проводимость из-за толстого слоя дентина или склероза тканей.
- г) Наличие слюны в области межзубных промежутков.
- д) Соприкосновение электрода с мягкими тканями пародонта.

№243. Укажите при хроническом фиброзном пульпите, характеризующемся разрастанием соединительной ткани и склерозом, порог электроодонтодиагностики (ЭОД):

- а) Значительно снижается (менее 2–6 мкА) из-за гипервозбудимости нервных волокон.
- б) Остается в пределах физиологической нормы, соответствующей интактному зубу.
- в) Умеренно повышается (в среднем до 30–50 мкА) вследствие дистрофических изменений.
- г) Резко повышается (более 100 мкА), что свидетельствует о тотальном некрозе тканей.
- д) Полностью отсутствует, так как нервный аппарат пульпы полностью разрушен.

№244. Определите: в чем заключается основное диагностическое ограничение метода электроодонтодиагностики (ЭОД) в клинической стоматологии?

- а) Чрезмерно высокая стоимость оборудования и расходных материалов для исследования.
- б) Высокая техническая сложность проведения процедуры и необходимость участия ассистента.
- в) Возможность оценки исключительно нервного компонента (чувствительности) пульпы.
- г) Низкая чувствительность метода к изменениям в тканях при острых формах воспаления.
- д) Выраженная инвазивность процедуры, вызывающая повреждение твердых тканей зуба.

№245. Укажите: какой физический принцип лежит в основе функционирования ультразвуковых систем, применяемых в современной стоматологии?

- а) Генерация мощного электромагнитного излучения в видимом спектре.
- б) Преобразование энергии в механические колебания высокой частоты.
- в) Использование направленного теплового воздействия на ткани пародонта.
- г) Провоцирование химического разрушения органической матрицы зубных отложений.
- д) Использование квантового светового излучения для дезинтеграции налета.

№246. Укажите: какой физический эффект, возникающий при работе ультразвукового скалера, является ключевым для эффективного удаления зубных отложений?

- а) Фотоэффект, вызывающий разрушение связей между налетом и поверхностью эмали.
- б) Кавитация — образование и схлопывание микропузырьков в жидкой среде.
- в) Осмотическое давление, способствующее отслоению камня от поверхности корня.
- г) Свободная диффузия ионов антисептика в структуру поддесневых отложений.
- д) Химическая адгезия рабочих компонентов наконечника к минерализованному налету.

№247. Укажите: помимо механического очищения, какой дополнительный эффект кавитации является крайне важным в стоматологической практике?

- a) Значительное локальное повышение температуры, способствующее коагуляции.
- b) Выраженное антибактериальное действие за счет разрушения клеточных стенок.
- c) Рефлекторное усиление болевой чувствительности для контроля глубины обработки.
- d) Поверхностное повреждение эмали для улучшения последующей адгезии пломбы.
- e) Глубокая дегидратация твердых тканей зуба в процессе ультразвуковой обработки.

№248. Определите: какой параметр ультразвукового воздействия является наиболее критичным для обеспечения безопасности твердых и мягких тканей в процессе работы?

- a) Цветовая кодировка или дизайн используемого ультразвукового наконечника.
- b) Сочетание частоты и амплитуды колебаний рабочей части инструмента.
- c) Длина световой волны встроенной системы подсветки наконечника.
- d) Давление подаваемого воздуха в системе стоматологической установки.
- e) Органолептические свойства (вкус и запах) используемой воды для охлаждения.

№249. Укажите: при использовании ультразвуковых насадок (эндочаков) в процессе эндодонтического лечения основным терапевтическим эффектом является:

- a) Химическое отбеливание твердых тканей корня внутри системы каналов.
- b) Качественное улучшение ирригации и очистки труднодоступных участков каналов.
- c) Направленное уменьшение длины корня для устранения периапикального очага.
- d) Искусственное формирование апикального упора при незавершенном росте корня.
- e) Уплотнение и конденсация obturационного материала в просвете макроканала.

№250. Определите: какой фактор в ходе проведения ультразвуковой обработки корневых каналов или снятия отложений чаще всего приводит к термическому повреждению тканей?

- a) Использование слишком низкой частоты колебаний рабочего наконечника.
- b) Недостаточное водяное охлаждение зоны контакта инструмента с тканями.
- c) Кратковременное воздействие на твердые ткани (менее 5–10 секунд).
- d) Минимальное давление на инструмент в процессе проведения манипуляции.
- e) Постоянное использование дистиллированной воды в системе охлаждения.

№251. Укажите: в чем заключается основное клиническое преимущество ультразвуковых инструментов перед традиционными ручными инструментами при снятии зубных отложений?

- a) Обеспечение полного отсутствия болевых ощущений без применения анестезии.
- b) Избирательное воздействие на налет и минимальная травматизация окружающих тканей.
- c) Отсутствие необходимости в использовании воды или антисептических растворов.
- d) Абсолютная универсальность метода для всех без исключения стоматологических процедур.
- e) Значительно более низкая стоимость оборудования по сравнению с ручным набором.

№252. Определите: какой физико-химический механизм обеспечивает направленный транспорт лекарственного вещества в ткани зуба или пародонта при проведении электрофореза?

- a) Осмотическое давление, возникающее в межклеточном пространстве.
- b) Свободная диффузия молекул вещества в глубокие слои слизистой оболочки.
- c) Процессы электромиграции ионов и электроосмоса под действием поля.
- d) Механическая фильтрация раствора через дентинные каналы или поры.
- e) Активный пиноцитоз лекарственных частиц клетками эпителия слизистой.

№253. Укажите: какой клинический параметр наиболее существенно влияет на итоговую глубину проникновения и концентрацию лекарственного вещества при электрофорезе?

- a) Особенности пигментации и цвет слизистой оболочки в зоне введения.
- b) Половая принадлежность пациента и особенности его гормонального фона.
- c) Совокупность силы подаваемого тока и общей продолжительности воздействия.
- d) Температурный режим в стоматологическом кабинете во время процедуры.
- e) Положение пациента в стоматологическом кресле (сидя или полулежа).

№254. Укажите: согласно законам электростатики, при проведении лекарственного электрофореза в стоматологии активное вещество вводится:

- a) Вне зависимости от величины и знака собственного электрического заряда.
- b) Исключительно с положительного электрода (анода) во всех клинических случаях.
- c) Исключительно с отрицательного электрода (катода) для лучшей диффузии.
- d) С электрода, имеющего одноименный с лекарственным ионом заряд.
- e) С противоположно заряженного электрода для обеспечения притяжения частиц.

№255. Выберите: какой клинический эффект лекарственного электрофореза считается наиболее ценным при лечении стоматологических заболеваний?

- a) Обеспечение исключительно локального воздействия на поверхностные слои слизистой.
- b) Возможность достижения быстрого системного эффекта во всем организме.
- c) Создание депо лекарственного препарата в тканях для его пролонгированного действия.
- d) Гарантированное полное отсутствие побочных эффектов вне зависимости от препарата.
- e) Получение мгновенного терапевтического результата сразу после начала процедуры.

№256. Укажите: какое состояние пациента является абсолютным противопоказанием к проведению процедур лекарственного электрофореза в стоматологии?

- a) Хронические формы апикального периодонтита в стадии ремиссии.
- b) Повышенная чувствительность (гиперестезия) твердых тканей зубов.
- c) Наличие у пациента имплантированного искусственного кардиостимулятора.
- d) Наличие кариозных полостей различной локализации и глубины.
- e) Хронический катаральный гингивит без признаков обострения.

№257. Пациент 35 лет, хронический периодонтит. Назначен электрофорез с антисептиком. После процедуры отмечается усиление боли. Укажите наиболее вероятную техническую причину данного осложнения:

- a) Ошибочный выбор антисептического препарата без учета микрофлоры канала.
- b) Установка слишком низкой силы тока, не обеспечивающей движение ионов.
- c) Неверно выбранная полярность введения (несоответствие заряда иона и электрода).
- d) Недостаточное время физиотерапевтического воздействия на ткани.
- e) Проявление индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного средства.

№258. Пациентка 28 лет обратилась с жалобами на гиперестезию эмали. Назначен курс электрофореза с препаратами кальция. Укажите: какой биологический механизм обеспечит лечебный эффект?

- a) Направленное уменьшение интенсивности кровотока в пульпе зуба.
- b) Облитерация (закрытие) дентинных канальцев и реминерализация тканей.
- c) Контролируемое частичное разрушение поверхностного слоя эмали.
- d) Усиление чувствительной иннервации в области коронки зуба.
- e) Локальное повышение кислотности среды для активации ионов кальция.

№259. Пациент 40 лет, хронический гингивит. После курса электрофореза отмечено кратковременное улучшение, после чего симптомы вернулись. Определите: какова наиболее вероятная причина низкой эффективности лечения?

- a) Неправильная техника чистки зубов и сохранение этиологического фактора (налета).
- b) Недостаточная способность выбранного препарата к депонированию в тканях десны.
- c) Превышение терапевтической дозы препарата в ходе проведения процедур.
- d) Недостаточное количество процедур в назначенном физиотерапевтическом курсе.
- e) Развитие скрытой аллергической реакции на компоненты лекарственного раствора.

№260. Пациент 50 лет проходит курс электрофореза с йодом. Сразу после процедуры появились жалобы на металлический вкус во рту и легкое жжение. Укажите причину данных ощущений:

- a) Клиническое проявление передозировки препарата йода в организме.
- b) Специфическая индивидуальная реакция рецепторов на вводимый препарат.
- c) Процессы электролиза ионов под действием постоянного электрического тока.
- d) Ошибка в первичной диагностике основного стоматологического заболевания.
- e) Наличие плохого электрического контакта между электродом и слизистой.

№261. При проведении электрофореза врач преднамеренно или случайно использует слишком высокую силу тока. Укажите: какое осложнение является наиболее вероятным в данной ситуации:

- a) Полное отсутствие терапевтического эффекта из-за ионного дисбаланса.
- b) Развитие химического или термического ожога слизистой оболочки.
- c) Парадоксальное снижение эффективности проникновения лекарства в ткани.
- d) Развитие немедленной аллергической реакции на электрический ток.
- e) Возникновение локального асептического некроза подлежащей костной ткани.

№262. При лечении хронических форм пульпита метод лекарственного электрофореза часто признается малоэффективным. Установите основную причину низкой результативности в данном случае:

- a) Полное отсутствие прямого физического доступа лекарства к воспаленным тканям.
- b) Отсутствие выраженного воспалительного процесса, на который мог бы подействовать ток.
- c) Грубое нарушение иннервации, препятствующее адекватному ответу тканей на процедуру.
- d) Глубокое анатомическое расположение очага воспаления (внутри системы каналов).

е) Слишком низкая температура используемого лекарственного раствора во время сеанса.

№263. Пациент 32 лет. В ходе процедуры лекарственного электрофореза препарат наносится на обильно увлажненную слюной слизистую оболочку. Укажите: как это техническое условие влияет на процедуру?

а) Значительно улучшает глубину и скорость проникновения лекарственных ионов в ткани.

б) Не оказывает никакого влияния на физико-химические процессы переноса вещества.

с) Существенно снижает точность дозировки из-за неконтролируемого растекания тока.

д) Рефлекторно усиливает болевые ощущения пациента во время подачи напряжения.

е) Гарантированно вызывает термический ожог подлежащих мягких тканей.

№264. Пациент 45 лет закончил полный курс электрофореза, однако терапевтический эффект полностью отсутствует. Определите какова наиболее вероятная техническая причина неудачи?

а) Неправильный выбор полярности активного электрода относительно заряда иона.

б) Использование слишком низкой температуры в помещении или раствора препарата.

с) Недостаточная продолжительность каждой процедуры (менее 5 минут).

д) Несоблюдение пациентом принципов правильного питания во время курса лечения.

е) Возрастные изменения тканей, препятствующие накоплению депо лекарства.

№265. При планировании курса электрофореза врач сталкивается с новым препаратом, электрический заряд ионов которого точно не известен. Выберите какое решение будет наиболее правильным?

а) Использовать любой удобный электрод, полагаясь на процессы диффузии.

б) Обязательно определить заряд активного вещества по справочнику перед процедурой.

с) Компенсировать отсутствие знаний значительным увеличением силы подаваемого тока.

д) Максимально сократить время воздействия, чтобы избежать побочных реакций.

е) Полностью отменить физиотерапевтическое лечение из-за отсутствия данных.

№266. У пациента выявлена повышенная чувствительность слизистой оболочки к электрическому раздражению. Укажите как следует модифицировать методику проведения электрофореза?

а) Увеличить силу тока для быстрой адаптации рецепторов к раздражителю.

б) Уменьшить силу тока до комфортных значений с возможным увеличением времени.

с) Увеличить время процедуры без изменения параметров электрического тока.

д) Проводить процедуру на абсолютно сухой слизистой для снижения проводимости.

е) Немедленно и окончательно прекратить физиотерапевтическое лечение.

№267. При лечении хронических воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) электрофорез показывает высокую эффективность. Укажите какой механизм лежит в основе успеха?

а) Метод обеспечивает исключительно симптоматическое местное обезболивание.

б) Сочетание улучшения микроциркуляции и направленной доставки препарата в ткани.

с) Направленное уничтожение патологически измененных тканей электрическим током.

д) Намеренное временное снижение местного иммунитета для подавления воспаления.

е) Создание локальной гипоксии, губительной для аэробной патогенной микрофлоры.

№268. Укажите какой физический принцип лежит в основе метода диатермокоагуляции, применяемого в стоматологической практике?

а) Прямое механическое разрушение клеточных структур острым электродом.

б) Термическое воздействие высокочастотного тока, вызывающее денатурацию белков.

с) Использование химических реагентов для коагуляции белковых структур.

д) Направленное фотоактивное разрушение мягких тканей лазерным излучением.

е) Создание ультразвуковой микровибрации, приводящей к деструкции тканей.

№269. Отметьте какой тип электрического тока является наиболее предпочтительным для проведения безопасной диатермокоагуляции слизистой оболочки?

а) Стабильный постоянный ток низкого напряжения (гальванизация).

б) Синусоидальный переменный ток низкой частоты (до 50 Гц).

с) Высокочастотный переменный ток, обеспечивающий быстрый нагрев тканей.

д) Импульсный ток постоянного направления с регулируемой скважностью.

е) Статический электрический разряд высокой мощности.

№270. Укажите в чем заключается основное клиническое преимущество диатермокоагуляции перед использованием традиционного хирургического скальпеля?

а) Полное исключение болевых ощущений во время и после проведения процедуры.

б) Обеспечение гемостаза (минимальная кровоточивость) и стерильность операционного поля.

с) Мгновенное заживление раневой поверхности без образования рубцов и корок.

д) Полное восстановление эпителиального покрова в течение первых суток после операции.

е) Исключительно низкая стоимость оборудования по сравнению с набором хирургических инструментов.

№271. Определите какое техническое условие является главным ограничением для широкого применения диатермокоагуляции в полости рта?

- а) Наличие у пациента аллергических реакций на электрический ток.
- б) Наличие несъемных металлических конструкций (протезов, имплантатов) в зоне работы.
- с) Повышенная чувствительность (гиперестезия) твердых тканей соседних зубов.
- д) Низкая терапевтическая эффективность метода при работе с мягкими тканями.
- е) Чрезмерная сухость слизистой оболочки, препятствующая прохождению тока.

№272. Пациент 45 лет, лейкоплакия на боковой поверхности языка. Планируется удаление участка методом диатермокоагуляции. Укажите какую полярность активного электрода целесообразно использовать для минимизации ожога окружающих тканей и лучшей коагуляции?

- а) Отрицательный полюс (катод), способствующий разжижению тканей.
- б) Положительный полюс (анод), способствующий дегидратации и уплотнению тканей.
- с) Полярность не имеет физического значения при использовании переменного тока высокой частоты.
- д) Постоянная смена полярности в ходе проведения оперативного вмешательства.
- е) Проведение манипуляции исключительно через нейтральный электрод без активного наконечника.

№273. Пациентка 38 лет с хроническим гингивитом. Укажите каким образом диатермокоагуляция воздействует на гиперемизированные и кровоточащие ткани десны в ходе процедуры?

- а) Снижает локальный кровоток и вызывает коагуляцию белков в стенках патологически измененных сосудов.
- б) Иницирует каскад реакций, усиливающих острое воспаление для стимуляции иммунного ответа.
- с) Значительно увеличивает объемное кровоснабжение в зоне воздействия для ускорения метаболизма.
- д) Оказывает деструктивное влияние на твердые ткани зубов (эмаль и дентин) в пришеечной области.
- е) Не оказывает выраженного биологического влияния на мягкие ткани, выполняя роль плацебо.

№274. У пациента 50 лет под съемным протезом обнаружена гипертрофированная ткань (гранулема). Укажите почему метод диатермокоагуляции считается эффективным для удаления подобных образований?

- а) Основным эффектом заключается исключительно в глубоком местном обезболивании зоны вмешательства.
- б) Метод обеспечивает одновременную коагуляцию сосудов и деструкцию патологически измененной ткани.
- с) Воздействие провоцирует массивную инфильтрацию тканей лейкоцитами для естественного рассасывания.
- д) Электрический ток специфически стимулирует дальнейший рост грануляционной ткани для закрытия дефекта.
- е) Процедура намеренно повышает уровень воспаления для перевода процесса из хронического в острый.

№275. Пациент имеет множественные металлические пломбы в зоне проведения диатермокоагуляции слизистой. Выберите какое правило безопасности является критически важным?

- а) Электрод не должен касаться пломб, так как передача тока через металл может вызвать термический ожог пульпы или десны.
- б) Наличие металлических пломб не имеет клинического значения при выборе параметров тока.
- с) Необходимо использовать максимально возможную силу тока для преодоления сопротивления металла.
- д) Все металлические пломбы и конструкции подлежат обязательному снятию перед началом физиопроцедуры.
- е) Следует снижать частоту переменного тока до минимума (50 Гц) для предотвращения искрения.

№276. Пациентка 42 лет. На следующий день после диатермокоагуляции на слизистой десны визуализируется плотный налет серого цвета (струп). Укажите как врачу следует интерпретировать данную клиническую картину?

- а) Некроз поверхностных слоев тканей — это ожидаемый и нормальный эффект после коагуляции.
- б) Состояние является следствием ожога из-за нарушения врачом техники проведения процедуры.
- с) Клиническое проявление немедленной аллергической реакции организма на воздействие током.
- д) Развитие патологического процесса, требующего немедленного хирургического вмешательства.
- е) Присоединение вторичной инфекции и развитие острого гнойного воспаления в ране.

№277. У пациента 55 лет выявлена обширная лейкоплакия. Определите почему в данном клиническом случае метод диатермокоагуляции часто предпочтительнее работы обычным скальпелем?

- а) Обеспечивается значительно более быстрое заживление раневой поверхности под струпом.

б) Минимизируется риск интраоперационного кровотечения и создается стерильное поле в зоне деструкции.

с) После электрохирургического вмешательства образуется значительно меньше первичного струпа.

д) Полностью исключается развитие послеоперационного болевого синдрома в периоде восстановления.

е) Стоимость процедуры для клиники и пациента существенно ниже стоимости набора одноразовых скальпелей.

№278. Пациент с очагом гиперкератоза, вызванного хронической травмой. Планируется диатермокоагуляция. Укажите действия врача необходимые непосредственно перед началом процедуры:

а) Тщательная проверка зоны вмешательства на отсутствие вблизи металлических конструкций.

б) Проведение адекватного местного обезболивания и антисептической обработки операционного поля.

с) Предварительный контроль и оценка глубины поражения тканей для настройки параметров аппарата.

д) Все вышеперечисленные действия являются обязательными этапами подготовки.

е) Ограничение подготовки исключительно проведением инъекционной или аппликационной анестезии.

№279. Пациент 40 лет. В процессе манипуляции активный электрод удерживался на одном участке ткани дольше рекомендованного времени. Выберите наиболее вероятное осложнение:

а) Парадоксальное расширение зоны капиллярной кровоточивости из-за пареза сосудов.

б) Развитие глубокого термического ожога и некроза подлежащих тканей, вплоть до кости.

с) Развитие костного анкилоза в области корня зуба, находящегося в зоне воздействия.

д) Резкое повышение тактильной чувствительности слизистой оболочки во всей полости рта.

е) Мгновенное инфицирование раны патогенной микрофлорой из-за перегрева тканей.

№280. Укажите какова основная цель проведения антисептической обработки кариозной полости перед этапом постоянного пломбирования?

а) Обеспечение химической адгезии композитного материала к дентину.

б) Полная ликвидация остаточной микрофлоры и предотвращение рецидива.

с) Искусственное окрашивание деминерализованного дентина (детектирование).

д) Ускорение процесса полимеризации адгезивной системы последнего поколения.

е) Снижение чувствительности пульпы к температурным раздражителям.

№281. Укажите при лечении глубокого кариеса в качестве лечебной прокладки чаще всего используются препараты на основе:

а) Стеклоиономерного цемента двойного механизма отверждения.

б) Гидроксида кальция, обладающего выраженным щелочным рН.

с) Цинк-фосфатного цемента, обеспечивающего механическую прочность.

д) Композитного материала химического способа отверждения.

е) Резорцин-формалиновой смеси для мумификации остатков пульпы.

№282. Выберите какое свойство стеклоиономерных цемента (СИЦ) является ключевым для профилактики вторичного кариеса?

а) Высокая прочность на изгиб и устойчивость к истиранию.

б) Способность к длительному выделению ионов фтора в ткани зуба.

с) Идеальное соответствие цвета материала оптическим свойствам эмали.

д) Минимальное время окончательного отверждения материала в полости.

е) Полное отсутствие потребности в предварительном кондиционировании.

№283. Обозначьте что является наиболее вероятной причиной выпадения пломбы из композитного материала через короткое время после постановки?

а) Недостаточная толщина лечебной прокладки под материалом.

б) Использование слишком мощной полимеризационной лампы.

с) Нарушение герметичности (попадание влаги или слюны) на этапе адгезии.

д) Повышенное содержание ионов фтора в питьевой воде пациента.

е) Проведение профессиональной гигиены за неделю до лечения.

№284. Укажите какой этап протокола адгезивной подготовки является обязательным при использовании самопротравливающих систем?

а) Тщательное смывание состава струей воды в течение 20 секунд.

б) Активное втирание адгезива в ткани зуба (браш-массаж).

с) Предварительное протравливание дентина 37% фосфорной кислотой.

д) Нанесение материала исключительно на абсолютно сухую поверхность.

е) Использование металлической матрицы для изоляции рабочего поля.

№285. Пациентка 45 лет жалуется на лёгкую чувствительность зуба при проведении гигиенических процедур. Рентгенологическое исследование выявило цервикальную инвазивную резорбцию (ЦИР) II

стадии по классификации Heithersay. Укажите какой принцип лечения является оптимальным в данной клинической ситуации?

- a) Тактика пассивного динамического наблюдения за состоянием зуба.
- b) Немедленное хирургическое удаление зуба и планирование имплантации.
- c) Консервативная эндодонтическая терапия в сочетании с герметизацией дефекта.
- d) Проведение глубокой диатермокоагуляции тканей в области шейки зуба.
- e) Поверхностное пломбирование кариозной полости без учета резорбции.

№286. Пациент 50 лет. Диагностирована ЦИР III стадии с существенным разрушением дентинного кортикального слоя, при этом пульпа сохраняет жизнеспособность. Определите что необходимо учитывать при выборе тактики лечения?

- a) Неизбежность удаления зуба вследствие значительного объема поражения.
- b) Необходимость сохранения жизнеспособности пульпы при полном удалении резорбтивной ткани.
- c) Возможность игнорирования очага резорбции при отсутствии болевого синдрома.
- d) Проведение только избирательного шлифования поверхности корня зуба.
- e) Применение курсов лекарственного электрофореза как основного метода лечения.

№287. Пациент 42 лет. Выявлена ЦИР II стадии, локализованная на медиальной поверхности резца. Почему использование конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) является критически важным этапом перед началом лечения?

- a) Для точного планирования консервативного доступа и оценки истинной глубины резорбции.
- b) Для функциональной проверки прикуса и выявления преждевременных контактов.
- c) Для дифференциальной диагностики кариеса эмали и сопутствующих дефектов.
- d) Для оценки уровня костной ткани и состояния маргинального пародонта.
- e) Использование КЛКТ не является обязательным при наличии качественного визиографа.

№288. Пациент 36 лет. При обследовании выявлена начальная (I стадия) ЦИР. Пульпа интактна, признаки воспаления десны отсутствуют. Выберите какой метод ведения пациента предпочтителен на данном этапе?

- a) Тактика наблюдения с обязательным повторным рентгенологическим контролем через 6 месяцев.
- b) Немедленное хирургическое вмешательство с целью иссечения очага резорбции.
- c) Назначение курса электрофореза с препаратами кальция для стабилизации процесса.
- d) Проведение диагностической биопсии тканей в пришеечной области зуба.
- e) Профилактическое пломбирование корневого канала гуттаперчей.

№289. Пациентка 48 лет. Диагностирована ЦИР III–IV стадии, пульпа находится в состоянии некроза, клинически определяется периапикальный абсцесс. Укажите что является обязательным первым этапом комплексного лечения?

- a) Консервативное восстановление дефекта композитными материалами.
- b) Эндодонтическая терапия с тщательным удалением некротических масс.
- c) Тактика пассивного наблюдения до стихания острых явлений.
- d) Немедленное ортопедическое протезирование коронковой части зуба.
- e) Изолированная хирургическая резекция десневого края в зоне дефекта.

№290. Пациент 52 лет. В рамках дистанционной консультации (телестоматология) по поводу ЦИР II стадии пациент предоставил серию фотографий зуба. Укажите какой аспект является наиболее значимым для качественной удаленной оценки состояния?

- a) Цветовые характеристики эмали и наличие специфической пигментации.
- b) Точный размер и анатомическое расположение выявленного дефекта.
- c) Визуальные признаки воспаления прилежащей мягкой ткани десны.
- d) Подробный сбор и анализ субъективных жалоб и анамнеза пациента.
- e) Комплексная оценка всех вышеперечисленных диагностических факторов.

№291. Пациент 44 лет. Выявлен участок резорбции (ЦИР), топографически труднодоступный для прямого визуального осмотра в кресле. Укажите каким образом методы телестоматологии могут оптимизировать диагностический процесс?

- a) Дистанционная помощь в данном клиническом случае невозможна.
- b) Использование фотографий высокого разрешения и анализ 3D-моделей.
- c) Исключительно проведение видеозвонка для оценки мимики пациента.
- d) Ограничение взаимодействия только письменной формой консультации.
- e) Обмен текстовыми сообщениями в стандартном мессенджере.

№292. Пациентка 39 лет. Обнаружен дефект (ЦИР II стадии). Пациент проявляет сомнение в необходимости активного лечения и запрашивает «второе мнение» дистанционно. Определите какая тактика врача будет наиболее корректной?

- a) Прекращение всякого лечения ввиду отсутствия комплаентности пациента.
- b) Организация получения второго мнения через телестоматологическую платформу.
- c) Жесткое настаивание на немедленном хирургическом вмешательстве.
- d) Игнорирование сомнений пациента и переход к запланированному приему.
- e) Эмпирическое назначение курса антибиотиков для снятия тревожности.

№293. Пациент 41 год. Выявлена ЦИР II–III стадии, планируется комплексная эндодонтическая терапия. Выберите какой клинический фактор в наибольшей степени повышает риск возникновения рецидива заболевания?

- a) Неполное или недостаточно тщательное удаление резорбтивной ткани.
- b) Регулярное использование КЛКТ на этапах диагностики и контроля.
- c) Своевременное начало лечения сразу после обнаружения дефекта.
- d) Достижение полной герметизации системы корневых каналов.
- e) Проведение тщательного обследования всех рядом стоящих зубов.

№294. Пациент 46 лет. Диагностирована ЦИР IV стадии с масштабным разрушением коронки и корня зуба. Пациент настаивает на сохранении зуба. Укажите какая профессиональная рекомендация наиболее обоснована?

- a) Однозначное утверждение, что сохранение зуба невозможно, и показано удаление.
- b) Консервативное лечение технически сложно; необходим консилиум с ортопедом и хирургом.
- c) Выбор тактики длительного пассивного наблюдения за скоростью разрушения.
- d) Проведение процедур лекарственного электрофореза и герметизации дефекта.
- e) Выполнение диагностической биопсии костной ткани в области апекса.

№295. Укажите самым перспективным направлением развития регенеративной эндодонтии в 2026 году считается:

- a) Увеличение частоты применения классического минерал-триоксид агрегата (МТА) для создания апикальных барьеров.
- b) Переход к cell-based подходам с ex-vivo культивированием стволовых клеток и 3D-биопечатью скаффолдов.
- c) Возврат к традиционным методикам использования гидроксида кальция для стимуляции естественного закрытия апекса.
- d) Полный отказ от использования искусственных биоматериалов в пользу естественной регенерации тканей пульпы.
- e) Применение исключительно хирургических методов лечения для радикального устранения периапикальных очагов.

№296. Укажите при использовании Biodentine в регенеративной эндодонтии его преимущество перед МТА заключается в:

- a) Более быстром времени схватывания, отсутствии риска дисколорации и высоких показателях биосовместимости.
- b) Существенно более низкой рыночной стоимости материала в сравнении с импортными аналогами на основе силикатов.
- c) Полном отсутствии выраженного антибактериального эффекта, что благоприятно для деления стволовых клеток.
- d) Необходимости обеспечения длительного увлажнения поверхности дентина в течение всего процесса полимеризации.
- e) Более низких показателях герметичности прилегания к тканям зуба, что облегчает проведение повторного лечения.

№297. Пациент 12 лет, зуб 21 с незавершённым формированием корня и некрозом пульпы. Через 12 месяцев после реваскуляризации по КЛКТ не отмечено утолщения стенок и закрытия апекса, хотя жалобы отсутствуют. Выберите наиболее обоснованную дальнейшую тактику?

- a) Проведение повторного протокола реваскуляризации с целью повторного индуцирования полноценного кровяного сгустка.
- b) Переход к методике апексификации гидроксидом кальция с многократной заменой пасты в течение длительного периода.
- c) Создание апикального барьера с использованием минерального триоксидного агрегата (МТА) или биокерамики.

д) Проведение obturation корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации без создания апикального упора.

е) Продолжение тактики динамического наблюдения без активного вмешательства в течение еще одного года.

№298. Пациент 10 лет. При регенеративной терапии зуба с незавершенным формированием корня использована тройная антибиотик-паста. Через 2 недели отмечена выраженная дисколорация коронки. Укажите какой компонент вызвал это осложнение?

а) Метронидазол — вследствие нарушения метаболизма в окружающих тканях и накопления продуктов распада.

б) Ципрофлоксацин — из-за специфической химической реакции с неорганическими компонентами эмали и дентина.

с) Миноциклин — по причине связывания с кальцием дентина и образования окрашенных хелатных комплексов.

д) Амоксициллин — в результате системного влияния препарата на структуру твердых тканей формирующегося зуба.

е) Клиндамицин — вследствие прямого токсического воздействия на одонтобласты и нарушения синтеза дентина.

№299. Ключевым этапом регенеративной эндодонтии является индуцирование кровотечения из апикальной зоны. Определите каков основной механизм терапевтического эффекта этого действия?

а) Формирование грануляционной ткани в просвете канала без участия специфических клеток-предшественников.

б) Стимуляция и активация оставшихся одонтобластов в коронковой части пульпарной камеры.

с) Обеспечение притока мезенхимальных стволовых клеток из апикальной папиллы в область дезинфицированного канала.

д) Заполнение пространства фиброзным рубцом, обеспечивающим механическую стабильность корня зуба.

е) Избирательная активация цементобластов для ускорения формирования наружного слоя корня зуба.

№300. В регенеративной процедуре над сформированным кровяным сгустком использован минеральный триоксидный агрегат (МТА). Укажите какое его свойство является наиболее важным для успеха данной манипуляции?

а) Высокая эластичность материала, позволяющая компенсировать микродеформации коронки при нагрузке.

б) Способность к быстрому рассасыванию и замещению естественными тканями организма в процессе заживления.

с) Высокая биосовместимость и способность стимулировать процессы минерализации тканей.

д) Выраженное пролонгированное антибактериальное действие на патогенную микрофлору макроканала.

е) Оптическая радиопрозрачность, позволяющая детально изучать состояние тканей под пломбой на рентгене.